

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENFERMAGEM

FRANCINE MORAIS DA SILVA

**SIGNIFICADO DAS AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PERSPECTIVAS DE ENFERMEIROS E
FAMILIARES**

Porto Alegre
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENFERMAGEM

FRANCINE MORAIS DA SILVA

**SIGNIFICADO DAS AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PERSPECTIVAS DE ENFERMEIROS E
FAMILIARES**

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Enfermagem.

Área de concentração: Políticas e Práticas em Saúde e Enfermagem

Linha de Pesquisa: Saúde Mental e Enfermagem.

Eixo Temático: Cuidado em Saúde Mental

Orientadora: Profª. Dra. Cintia Nasi

Porto Alegre
2026

DEDICATÓRIA

À Deus, sem ele eu nada seria. Aos meus amados pais por acreditarem na força dos estudos e ao meu esposo pelas palavras de incentivo e acalento quando mais precisei.

Obrigada por acreditarem em mim e nos meus sonhos!

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela sabedoria concedida e pela vocação que me conduz na Enfermagem.

À minha família, expresso minha profunda gratidão. Ao meu pai, Luiz Fernando, exemplo de força e dedicação, cujo esforço foi fundamental para que eu pudesse alcançar esta formação. À minha mãe, Rejane, mulher valorosa, que sempre esteve presente, oferecendo apoio, segurança e respostas nos momentos de insegurança.

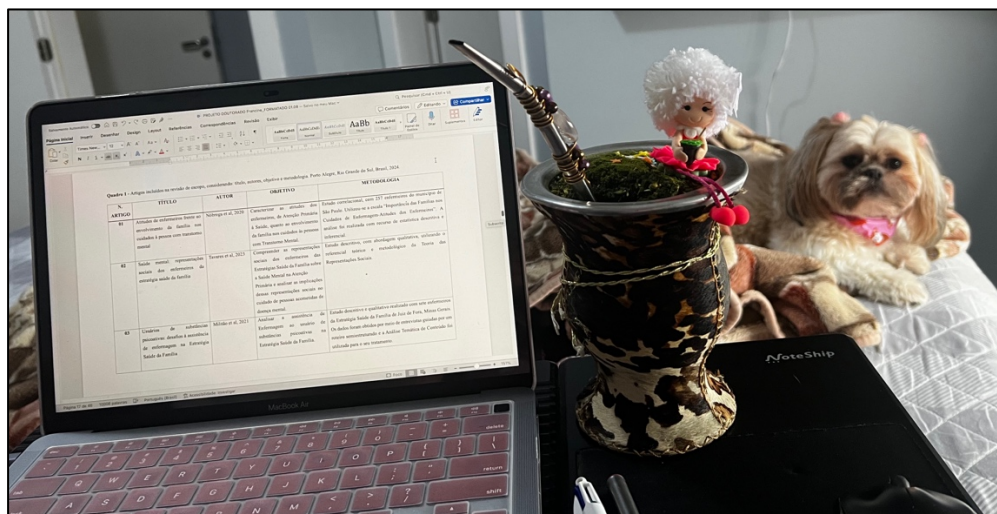
Registro, com carinho e saudade, minha homenagem aos meus avós, Ivete e Nelson (in memoriam), cujas memórias, ensinamentos e afeto permanecem vivos em minha trajetória.

Aos demais familiares, agradeço pelo apoio constante e pela presença nos momentos mais desafiadores desta caminhada na pós-graduação.

À minha companheira de tese, Rubi, que esteve ao meu lado em longos momentos de escrita, tornando essa jornada mais leve e afetuosa.

Ao meu esposo e eterno namorado, Alex Dumann, agradeço pelo amor, companheirismo, incentivo e por compartilhar comigo sonhos e projetos de vida.

À minha orientadora, Prof.^a Dr.^a Cíntia Nasí, expresso meu sincero agradecimento pela condução atenta, pela parceria acadêmica e pela força amiga que sustentou esta pesquisa em um percurso atravessado por inúmeros desafios, como o período da pandemia e as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Sua confiança, incentivo e generosidade intelectual foram fundamentais para a continuidade e conclusão deste trabalho, assim como para abrir horizontes à continuidade da minha trajetória acadêmica, na perspectiva de projetos futuros.



*“Domínus pascit me, et nihil mihi deerit;
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal algum, porque Tu
estás comigo; a tua vara e o teu cajado me
consolam.*

*Preparas uma mesa perante a mim na
presença dos meus inimigos, unges a minha
cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida; e
habitarei na casa do Senhor por longos dias”.*
(Salmo 23)

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP - Catalogação na Publicação

Morais da Silva, Francine
Significado das Ações de Enfermagem em Saúde Mental
na Atenção Primária à Saúde: Perspectivas de
Enfermeiros e Familiares / Francine Moraes da Silva.
-- 2026.
167 f.
Orientador: Cintia Nasi.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Atenção Primária em Saúde. 2. Enfermagem. 3.
Saúde Mental. 4. Família. 5. Fenomenologia. I. Nasi,
Cintia, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

FOLHA DE APROVAÇÃO

Francine Moraes da Silva

SIGNIFICADO DAS AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: PERSPECTIVAS DE ENFERMEIROS E FAMILIARES

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Enfermagem.

Aprovada em Porto Alegre, 12 de maio de 2026

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
 **CINTIA NASI**
Data: 17/05/2026 10:52:09-0300
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Profª. Dra. Cíntia Nasi

Presidente da Banca – Orientadora

PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO WAGNER CAMATTA**
Data: 12/05/2026 23:22:10-0300
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Prof. Dr. Marcio Wagner Camatta

Membro da banca

PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **VANESSA PELLEGRINO TOLEDO**
Data: 12/05/2026 13:36:22-0300
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Profª. Dra. Vanessa Pellegrino Toledo

Membro da banca

FENF/UNICAMP

Documento assinado digitalmente
 **ZAIRA LETICIA TISOTT**
Data: 12/05/2026 16:38:02-0300
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Profª. Dra. Zaira Leticia Tisott

Membro da banca

RESUMO

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui a principal porta de entrada do sistema de saúde e desempenha papel estratégico na organização do cuidado em saúde mental no território. Nesse contexto, destaca-se a atuação do enfermeiro na articulação do cuidado psicossocial junto aos usuários e suas famílias. **Objetivo:** compreender o significado das ações em saúde mental na APS na perspectiva de enfermeiros e familiares. **Método:** estudo qualitativo fundamentado na sociologia fenomenológica de Alfred Schutz, realizado em Unidades de Saúde da zona norte de Porto Alegre. Participaram 12 enfermeiros e 7 familiares de usuários em sofrimento psíquico pertencentes às áreas de abrangência dessas unidades. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas fenomenológicas realizadas entre 2021 e 2023, analisadas conforme a abordagem compreensiva schutziana. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE nº 04991418.1.1001.5347. **Resultados:** as ações de saúde mental na APS expressam-se por meio da escuta qualificada, da construção de vínculo e do acompanhamento contínuo de usuários e familiares. Essas práticas são sustentadas pelo compromisso ético e pelo estoque de conhecimento acumulado na experiência profissional, mesmo diante de desafios como sobrecarga de trabalho e limitações de recursos. Entre os familiares, o cuidado mostrou-se orientado por laços afetivos e responsabilidade diante do sofrimento do ente, permeado por sentimentos de amor e preocupação; apesar da sobrecarga cotidiana, reconhecem nos enfermeiros uma importante fonte de apoio. **Conclusão:** compreendeu-se que o agir do enfermeiro e a busca do familiar são orientados por *motivos porque* e *motivos para*, revelando o cuidado como prática sustentada por tecnologias leves e pela implicação subjetiva dos envolvidos. Emergiram paradoxos importantes: o cuidado acontece apesar das fragilidades estruturais da rede, e a centralidade do enfermeiro e do familiar evidencia tanto a potência do vínculo quanto a insuficiência institucional para garantir suporte contínuo e resolutivo.

Palavras-chave: Atenção primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família; Fenomenologia.

ABSTRACT

Introduction: Primary Health Care (PHC) constitutes the main entry point to the health system and plays a strategic role in organizing mental health care in the territory. In this context, the nurse's role in articulating psychosocial care with users and their families stands out. **Objective:** To understand the meaning of mental health actions in PHC from the perspective of nurses and family members. **Method:** A qualitative study based on Alfred Schutz's phenomenological sociology, conducted in Health Units in the northern zone of Porto Alegre. Twelve nurses and seven family members of users experiencing mental distress from the catchment areas of these units participated. Data collection occurred through phenomenological interviews conducted between 2021 and 2023, analyzed according to Schutz's comprehensive approach. The study was approved by the Research Ethics Committee under CAAE No. 04991418.1.1001.5347. **Results:** Mental health actions in primary health care are expressed through qualified listening, building bonds, and continuous monitoring of users and their families. These practices are supported by ethical commitment and the accumulated knowledge gained through professional experience, even in the face of challenges such as work overload and resource limitations. Among family members, care was shown to be guided by affective ties and responsibility in the face of the loved one's suffering, permeated by feelings of love and concern; despite the daily overload, they recognize nurses as an important source of support. **Conclusion:** It was understood that the nurse's actions and the family member's search for help are guided by "why" and "how to" reasons, revealing care as a practice supported by soft technologies and the subjective involvement of those involved. Important paradoxes emerged: care occurs despite the structural weaknesses of the network, and the centrality of the nurse and the family member highlights both the power of the bond and the institutional insufficiency to guarantee continuous and effective support.

Keywords: Primary Health Care; Nursing; Mental Health; Family; Phenomenology.

RESUMEN

Introducción: La Atención Primaria de Salud (APS) constituye el principal punto de entrada al sistema de salud y desempeña un papel estratégico en la organización de la atención de la salud mental en el territorio. En este contexto, destaca el rol de la enfermera en la articulación de la atención psicosocial con los usuarios y sus familias. **Objetivo:** Comprender el significado de las acciones de salud mental en la APS desde la perspectiva de las enfermeras y los familiares. **Método:** Estudio cualitativo basado en la sociología fenomenológica de Alfred Schutz, realizado en Unidades de Salud en la zona norte de Porto Alegre. Participaron doce enfermeras y siete familiares de usuarios con malestar mental de las áreas de influencia de estas unidades. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas fenomenológicas realizadas entre 2021 y 2023, analizadas según el enfoque integral de Schutz. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación bajo CAAE No. 04991418.1.1001.5347. **Resultados:** Las acciones de salud mental en la atención primaria de salud se expresan a través de la escucha calificada, la construcción de vínculos y el monitoreo continuo de los usuarios y sus familias. Estas prácticas se sustentan en el compromiso ético y el conocimiento acumulado a través de la experiencia profesional, incluso ante desafíos como la sobrecarga laboral y la limitación de recursos. Entre los familiares, se observó que el cuidado se guiaba por los lazos afectivos y la responsabilidad ante el sufrimiento del ser querido, impregnado de sentimientos de amor y preocupación; a pesar de la sobrecarga diaria, reconocen a las enfermeras como una importante fuente de apoyo. **Conclusión:** Se comprendió que las acciones de la enfermera y la búsqueda de ayuda por parte del familiar se guían por razones de "por qué" y "cómo", revelando el cuidado como una práctica sustentada en tecnologías blandas y la implicación subjetiva de los involucrados. Surgieron importantes paradojas: el cuidado se produce a pesar de las debilidades estructurales de la red, y la centralidad de la enfermera y el familiar resalta tanto el poder del vínculo como la insuficiencia institucional para garantizar un apoyo continuo y efectivo.

Palabras-Clave: Atención Primaria de Salud; Enfermería; Salud Mental; Familia; Fenomenología.

SUMÁRIO

RESUMO	6
1) TRAJETÓRIA PRÉ-REFLEXIVA: CAMINHOS ENTRE A FORMAÇÃO, A PRÁTICA E O EMERGIR DA PESQUISA.....	10
2) INTRODUÇÃO	13
3) OBJETIVO.....	24
4) REVISÃO DA LITERATURA	25
TÓPICO 1 – REVISÃO DE ESCOPO	25
TÓPICO 2 - FAMÍLIA E SAÚDE MENTAL NA APS	49
TÓPICO 3 - REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO.....	52
1) ASPECTOS BIOGRÁFICOS DE ALFRED SCHUTZ	52
2) CONCEPÇÕES TEÓRICO-FILOSÓFICAS DA SOCIOLOGIA FENOMENOLÓGICA DE ALFRED SCHUTZ	54
3) APLICAÇÃO NO CAMPO DA PESQUISA EM SAÚDE/ENFERMAGEM	60
5) MÉTODO.....	62
6) CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	70
7) REFERÊNCIAS.....	74
APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE INFORMAÇÕES	83
ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP	85
ANEXO 2 – ARTIGO REVISÃO DE ESCOPO.....	90
ANEXO 3 – TERMO DE CIÊNCIA	101

1) TRAJETÓRIA PRÉ-REFLEXIVA: CAMINHOS ENTRE A FORMAÇÃO, A PRÁTICA E O EMERGIR DA PESQUISA

A escrita pré-reflexiva constitui um movimento de retorno ao vivido, de rememoração das experiências que antecedem a formulação conceitual do fenômeno a ser estudado. Na perspectiva fenomenológica, compreender o percurso existencial da pesquisadora é um modo de reconhecer o lugar de onde emergem suas inquietações e sentidos, pois toda investigação nasce de uma experiência concreta no mundo da vida. Assim, o momento pré-reflexivo busca explicitar o solo de significados a partir do qual a pesquisadora se aproxima do campo da saúde mental, revelando como sua trajetória formativa, profissional e afetiva se entrelaça ao tema da pesquisa. Essa retomada do vivido não tem o propósito de narrar uma biografia, mas de explicitar a intencionalidade que orienta o olhar da pesquisadora e dá sentido ao caminho investigativo. É nesse movimento de retorno às origens do encontro com o cuidado, com enfermeiros e às famílias, que se delineia a motivação para compreender o fenômeno do cuidado em saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS), em meio aos atravessamentos históricos, sociais e subjetivos que o constituem.

Minha trajetória no campo da Enfermagem iniciou em agosto de 2010, na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Contudo, foi apenas em 2012, ao cursar a disciplina de Enfermagem em Saúde Mental II, que vivi minha primeira aproximação significativa com o universo da saúde mental. A experiência de estágio em uma unidade de internação psiquiátrica foi um marco formativo, especialmente pela proposta pedagógica que priorizava o encontro com o sujeito antes mesmo do acesso ao seu prontuário. Esse gesto, aparentemente simples, ensinou-me que o cuidado nasce do reconhecimento do outro como ser singular, antes de qualquer diagnóstico ou categoria clínica. Foi também nesse espaço que ocorreu meu primeiro contato com os familiares dos pacientes, durante as visitas institucionais, momento em que despertei para a relevância das relações familiares e para o papel central da família na sustentação do cuidado.

Entre 2013 e 2014, atuei como estagiária assistencial no Serviço de Enfermagem em Adição (SEA) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), na Unidade Álvaro Alvim. Essa vivência ampliou minha compreensão sobre o sofrimento psíquico associado ao uso de substâncias, marcando a passagem da dimensão acadêmica à experiência concreta do cuidado. Em 2015, ao concluir a graduação e ingressar na Residência Multiprofissional em Saúde Mental no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), mergulhei mais profundamente no cotidiano das práticas em saúde mental, percorrendo diferentes dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Porto Alegre — CAPS II, CAPS AD III, internações psiquiátricas de adolescentes e adultos. Essa imersão evidenciou

que o cuidado em saúde mental é tecido na intersubjetividade e na corresponsabilidade entre profissionais, usuários e famílias.

Durante minha passagem pela APS, na Unidade Básica de Saúde Vila Sesc, deparei-me com as múltiplas configurações familiares que compõem o território: famílias nucleares, extensas, recompostas, monoparentais, entre outras. Nesse contexto, compreendi que o conceito de família ultrapassa os laços consanguíneos e se ancora em vínculos de afeto, solidariedade e pertencimento. A experiência na APS revelou também a complexidade do trabalho do enfermeiro diante das condições sociais e culturais que atravessam o cuidado, exigindo escuta, vínculo e sensibilidade para reconhecer o outro em sua totalidade. Essa vivência constituiu um marco na construção do meu olhar como pesquisadora, pois despertou o desejo de compreender o cuidado em saúde mental a partir das experiências vividas e dos significados que emergem do cotidiano.

Em 2017, ao ingressar no Mestrado Acadêmico em Enfermagem (PPGENF/UFRGS), aprofundi o estudo sobre a família de usuários de drogas, articulando o vivido à teoria. O mestrado foi um tempo de amadurecimento intelectual e existencial, no qual percebi que o conhecimento científico ganha sentido quando dialoga com o vivido. Paralelamente, atuei como enfermeira em uma unidade de internação psiquiátrica voltada a adolescentes dependentes químicos no Hospital Santa Ana — serviço integrante da RAPS de Porto Alegre. Nesse espaço, a família se revelou novamente como elemento estruturante do processo terapêutico, demandando do enfermeiro não apenas habilidades técnicas, mas também empatia, escuta e capacidade de mediação entre os sujeitos e suas histórias.

O doutorado, portanto, emerge como continuidade e desdobramento dessa trajetória, motivado pelo desejo de compreender o sentido das ações em saúde mental na Atenção Primária à Saúde na perspectiva de enfermeiros e familiares. Tal escolha nasce da percepção de que o cuidado em saúde mental não se reduz a intervenções clínicas, mas se constrói nas relações humanas, nas trocas e na compreensão mútua. Nesse horizonte, o pensamento de Alfred Schutz oferece sustentação teórica, ao compreender a ação social como um fenômeno orientado por “*motivos para*” e “*motivos porque*”, enraizados na experiência cotidiana dos sujeitos (SCHUTZ, 2023). Assim, a pesquisa busca compreender como os enfermeiros e familiares atribuem sentido às suas ações, considerando o contexto vivido, suas expectativas e intencionalidades.

A condução deste estudo, entretanto, foi marcada por atravessamentos que ultrapassaram o âmbito individual. A pandemia de Covid-19 e, posteriormente, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 impactaram profundamente o cenário da pesquisa e o cotidiano dos

serviços da Gerência Distrital Norte de Porto Alegre. Esses acontecimentos trouxeram à tona a vulnerabilidade das redes de cuidado e evidenciaram a potência da APS como espaço de escuta, acolhimento e reorganização das práticas em situações de crise. A experiência de realizar a coleta de dados nesse contexto permitiu-me refletir sobre a força e a fragilidade do trabalho em saúde mental, bem como sobre o modo como os profissionais e as famílias ressignificam o cuidado diante da adversidade.

Minha atuação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre — nas Unidades de Adições, Infância e Internação Psiquiátrica 4 Norte — constitui um campo vivo de interlocução entre teoria e prática. A vivência cotidiana com usuários e famílias em sofrimento psíquico reafirma a importância de uma prática reflexiva, pautada no encontro e na escuta sensível. O doutorado, nesse contexto, não se apresenta apenas como continuidade acadêmica, mas como um movimento de retorno ao vivido, de busca por compreender os significados do cuidar, em um diálogo constante entre ciência, experiência e existência.

O cuidado em saúde mental, ao longo da minha trajetória, revelou-se como uma experiência que ultrapassa a dimensão técnica e adentra o campo da intersubjetividade. Cuidar, nesse contexto, é mais do que intervir sobre o sofrimento — é estar com o outro, reconhecendo-o em sua singularidade e legitimando seus modos de existir. Sob a perspectiva fenomenológica, o cuidado é compreendido como uma ação social significativa, orientada por motivos e intencionalidades que emergem do mundo vivido (SCHUTZ, 2023). Assim, cada gesto de escuta, acolhimento ou acompanhamento domiciliar se insere em um campo relacional permeado de sentidos, nos quais enfermeiros e familiares compartilham expectativas, esperanças e limites. Na APS, esse cuidado ganha contornos próprios, pois se tece no cotidiano das relações comunitárias, na proximidade com o território e nas histórias que o atravessam. O enfermeiro, ao acolher o sofrimento psíquico, é também afetado por ele, tornando-se coautor do processo de reconstrução do sentido de viver do outro. Cuidar em saúde mental, portanto, implica reconhecer a vulnerabilidade como espaço de encontro, onde o diálogo, a empatia e o vínculo se constituem como práticas éticas e políticas, sustentando a integralidade do cuidado e a valorização da vida em sua complexidade.

Portanto, esta trajetória pré-reflexiva delineia o solo existencial e epistemológico que sustenta a pesquisa: o desejo de compreender o cuidado em saúde mental na APS como fenômeno vivido, situado e intersubjetivo, atravessado por experiências, contextos e sentidos que se constroem no encontro entre enfermeiros, familiares e usuários.

2) INTRODUÇÃO

Um dos movimentos de efervescência conceitual-filosófica com implicações diretas a pessoa em sofrimento mental foi a Reforma Psiquiátrica no Brasil em 1970, com intuito de questionar a instituição asilar e a prática médica a fim de humanizar a assistência e propor novas práticas terapêuticas para incluir os usuários de Saúde Mental na cultura e na sociedade. Essa mudança de paradigma culminou na transformação de um modelo segregador e hospitalocêntrico para uma rede de serviços pautados nos territórios e comunidades, articulando as necessidades em saúde mental apresentadas a terapias multifacetadas, inserindo não somente a pessoa em sofrimento mental, bem como seus familiares (AMARANTE; NUNES, 2018).

Apesar dos avanços obtidos ao longo das últimas décadas no campo da saúde mental, resultantes de mobilizações sociais e debates políticos, a consolidação da Reforma Psiquiátrica no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. O cuidado em liberdade, orientado pela reinserção social e pela construção de práticas de atenção nos territórios e nas comunidades, constitui um dos pilares desse processo. Entretanto, a efetivação desse modelo tem sido atravessada por disputas políticas e institucionais que, em determinados períodos, promoveram mudanças nas diretrizes da política nacional de saúde mental. Embora algumas normativas que reforçavam a centralidade do modelo hospitalar tenham sido posteriormente revogadas, essas movimentações evidenciam tensões persistentes na organização da Rede de Atenção Psicossocial e na consolidação do paradigma psicossocial de cuidado (BRASIL, 2019).

Tal fato não ocorre somente em território brasileiro. A Atenção à Saúde Mental, a nível mundial, tem sido tema central nas discussões, pois questões relacionadas ao sofrimento mental acometem cerca de uma em cada oito pessoas a nível mundial (WHO, 2022). Apesar dos números expressivos, questões de saúde em geral tendem a ter maior enfoque e relevância diante das questões relacionadas a saúde mental. De acordo com a Organização Panamericana da Saúde, mais de 50% dos recursos destinados aos cuidados em saúde mental, estão dirigidos a hospitais psiquiátricos, indo de encontro ao preconizado pela Reforma Psiquiátrica (OPAS, 2018). Tal fato aponta para a fragilidade da atenção psicossocial como modelo orientador no campo da saúde mental coletiva, não levando em consideração intervenções pautadas da rede de atenção, ao deixar de envolver múltiplos setores, serviços e atores sociais ao retroceder questões pautadas pela Reforma Psiquiátrica (KREFER; OLIVEIRA, 2025).

Dentre esses serviços, as equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) desempenham um papel importante na composição da rede comunitária e territorial de assistência em Saúde Mental. A Atenção Primária em Saúde (APS) constitui-se como o primeiro nível assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada o centro articulador de acesso à comunidade às Redes de Atenção em Saúde (RAS), orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade, ou seja, configura-se como um espaço potente para desenvolvimento de programas e ações, considerando as reais necessidades de saúde dos usuários e suas famílias (GIOVANELLA et al., 2021).

Esses princípios estão intrinsecamente ligados aos atributos essenciais da APS, como a longitudinalidade, que promove o acompanhamento contínuo do paciente, a integralidade, que reforça o atendimento completo e coordenado, e coordenação do cuidado, que busca integrar serviços e facilitar a transição entre diferentes níveis de atenção, ou seja, a APS é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das Unidades de Saúde da Família (USF) no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2022).

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma das principais iniciativas do Sistema Único de Saúde (SUS) para fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. Criada em 1994, a ESF visa melhorar o acesso e a qualidade do cuidado por meio da criação de Unidades de Saúde da Família (USF) que oferecem serviços multidisciplinares. As equipes da ESF são compostas por profissionais diversos, incluindo médicos de família e comunidade, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões-dentistas, auxiliares ou técnicos em saúde bucal, e agentes comunitários de saúde (ACS). Cada equipe de ESF deve atender de 2.000 a 3.500 pessoas e cada ACS deve atender em torno de 750 pessoas (BRASIL, 2017). Integrada à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a ESF tem desempenhado um papel crucial no atendimento à saúde de uma parcela significativa da população. Em 2019, a ESF atendeu aproximadamente 131,2 milhões de pessoas em todo o país (BRASIL, 2017; BRASIL, 2022).

Importante salientar que a PNAB, nos últimos anos, sofreu diversas modificações em suas diretrizes. A primeira edição foi publicada em 2006, a segunda edição em 2011 e a terceira em 2017. Em sua última atualização, com a Portaria 2.436 que revoga a PNAB de 2011 e estabelece a mais recente revisão nas diretrizes para a organização da Atenção Básica em território brasileiro. Em sua última atualização, traz um retrocesso em relação ao efetivo de ACS após revogar a obrigatoriedade

de atendimento a 100% da cobertura do território por ACS, tornou também mais flexível a jornada de trabalho por profissional de equipe mínima, podendo contratar profissionais de até 10 horas semanais por contrato estabelecido, além de proporcionar maior flexibilização com o setor privado para a prestação dos serviços na APS (BRASIL, 2017).

Cabe ressaltar que no contexto exposto acima, torna a APS mais excludente e seletiva, tornando as desigualdades sociais mais evidentes, além de diminuir a carta de serviços disponibilizados a população, ao diminuir o efetivo de ACS, acaba por estreitar vínculos com a comunidade, aumentando assim, seu distanciamento das unidades de saúde.

No que tange o estado do Rio Grande do Sul (RS), atualmente, as ações e os serviços da APS são ofertados em 497 municípios e existem 2.586 Unidades Básicas em Saúde (UBS), as quais comportam 2.099 equipes de ESF RIO GRANDE DO SUL, 2021; RIO GRANDE DO SUL, 2023).

Em 2025, Porto Alegre alcançou cerca de 93,8% de cobertura potencial da ESF, superando a meta de 80% do Plano Municipal de Saúde (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2026).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul (RS), possui uma população estimada em aproximadamente, 1,5 milhão de habitantes, as ações e os serviços da APS incluem 133 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 26 Equipes de Saúde da Família, 62 Equipes de Atenção Primária, nove equipes de Consultório na Rua, 18 equipes do programa Melhor em Casa e 24 equipes multiprofissionais, refletindo a estrutura tradicional de atendimento (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2026).

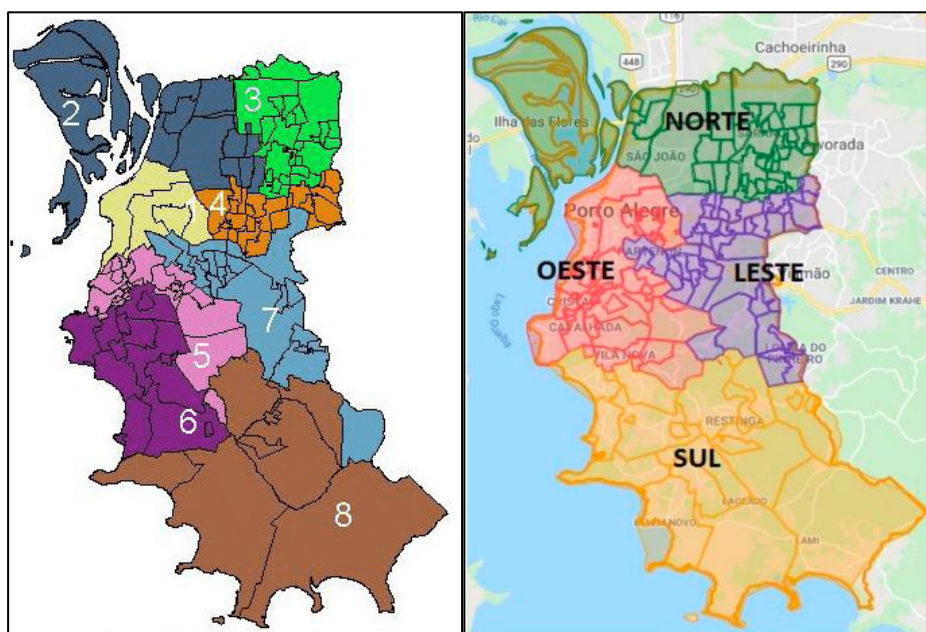
O município de Porto Alegre enquadra-se na modalidade de Gestão do Sistema de Saúde na qual ampliou sua rede municipal de serviços ofertados à população e organizou sua estrutura gerencial a fim de potencializar a descentralização dos serviços e desempenhar suas atividades (PORTO ALEGRE, 2018).

No município de Porto Alegre (RS), os serviços do SUS de Porto Alegre são divididos em 17 Distritos Sanitários (DS) que compõem as Gerências Distritais (GD). Os DS existentes em Porto Alegre são: Ilhas, Humaitá/Navegantes, Centro, Noroeste, Norte, Eixo Baltazar, Leste, Nordeste, Glória, Cruzeiro, Cristal, Sul, Centro-Sul, Paternon, Lomba do Pinheiro, Restinga e Extremo-Sul. No que tange às GD, anteriormente eram distribuídas em oito regiões em saúde: 1) Centro, 2) Noroeste /Humaitá /Navegantes /Ilhas, 3) Norte /Eixo Baltazar, 4) Leste /Nordeste, 5) Glória /Cruzeiro /Cristal, 6) Sul /Centro-Sul, 7) Paternon /Lomba do Pinheiro, 8) Restinga /Extremo-Sul. Atualmente, houve uma mudança em relação ao papel gerencial das GD com objetivo de padronizar os processos perante todo o município, elaborando assim, uma nova configuração, passando de oito para quatro: Leste,

Norte, Oeste e Sul. A nova configuração prevê além da reorganização no território, a mudança das funções, de gerente, subgerente, a coordenação técnica, de monitoramento e administrativa (PORTO ALEGRE, 2022), como ilustra a Figura 3.

Nesse sentido, As GD são núcleos administrativos regionais caracterizados por serem potentes espaços de discussão e prática assistencial onde são operacionalizadas estratégias para atenção à saúde no SUS. São compostas por Unidades de Saúde (US), Centros de Especialidades e Serviços Especializados Ambulatoriais e Substitutivos (RIO GRANDE DO SUL, 2021).

Figura 3: Comparativo Gerências Distritais.



Fonte: PORTO ALEGRE, 2022.

As mudanças acima supracitadas caminhavam em direção a formação das chamadas Clínicas de Família. No ano de 2011, no município de Porto Alegre (RS) foi criada uma empresa pública de direito privado a fim de gerenciar os serviços da APS intitulado Instituto Municipal de Estratégia Saúde da Família (IMESF) na qual os funcionários eram contratados via concurso público mantendo vínculo celetista de trabalho, indo de encontro com que era preconizado pelos sindicatos na época, que exigiam contratação via regime de trabalho estatutário já que compreendiam que era uma fundação pública de direito privado. Contudo, no ano de 2013, os sindicatos insatisfeitos com o regime de trabalho celetista, instauraram via processo judicial a inconstitucionalidade do IMESF (MARTINS; CARBONAI, 2021).

No ano de 2019, foi reconhecida a inconstitucionalidade do IMESF e foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal a sua extinção, exigindo que todos os profissionais contratados pelo IMESF que estavam compondo as equipes da APS no município de Porto Alegre (RS), fossem demitidos e recontratados com base em uma nova configuração das equipes (MARTINS; CARBONAI, 2021).

Um fato importante é que essa nova reorganização da APS no município de Porto Alegre (RS), diminuiu consideravelmente a cobertura de ACS como agentes importantes ao aproximar usuários, famílias e comunidades aos serviços de saúde a nível primário, ao representar no ano de 2020, cerca de uma cobertura de apenas 23,5% do território (PORTO ALEGRE, 2020).

Com essa reorganização, o Relatório de Gestão, em 2020, mencionou o fechamento de seis unidades de saúde e a sua população foi referenciada para unidade maiores, chamadas Clínicas da Família (PORTO ALEGRE, 2020).

Desde 2020, Porto Alegre (RS) iniciou a transição das antigas Unidades de Saúde da Família (USF) para as Clínicas da Família, com o objetivo de aprimorar o atendimento à saúde. Essa mudança busca oferecer uma abordagem mais integrada e eficiente, ampliando os serviços disponíveis e melhorando a coordenação do cuidado. As Clínicas da Família, têm por objetivo principal proporcionar um atendimento contínuo e abrangente à população, incluindo cuidados preventivos, manejo de doenças crônicas e suporte psicossocial alinhados com as diretrizes da PNAB. Embora a maioria das UBS na cidade de Porto Alegre tenham sido adaptadas para essa nova abordagem, a cobertura exata proporcionada pelas Clínicas da Família não chega a 75% da população. Atualmente, de acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2026), a cobertura potencial da ESF atingiu 93,8 % da população em 2025 permitindo acesso direto aos serviços das Clínicas da Família, refletindo um esforço contínuo para melhorar o acesso e a qualidade da APS no município (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2026).

Esse processo de transição para as Clínicas da Família é permeado por desafios. A integração efetivação dos serviços, o treinamento de profissionais e a adaptação da infraestrutura são questões cruciais a serem enfrentadas. Além disso, é fundamental abordar as resistências potenciais e garantir que a implementação seja acompanhada de uma avaliação contínua da eficácia a fim de maximizar os benefícios desse novo modelo. Contudo, surgem alguns questionamentos: com a demissão em larga escala de profissionais que compunham as equipes simples de atendimento às comunidades nos territórios, diminuição da cobertura territorial pelos ACS, fechamentos de seis unidades de saúde, tais movimentos vão ao encontro com o que é preconizado pelo movimento sanitário e aos princípios do

SUS? Quando a população é referenciada para unidades maiores, mais afastadas dos territórios, aproxima o usuário e suas famílias aos serviços de saúde? Possibilita a criação de vínculos da população com os serviços? A população dispõe de recursos para deslocamento ao ser referenciada para unidades maiores, mais afastadas de suas residências?

A Atenção Primária à Saúde (APS) enfrenta várias restrições que comprometem seu pleno desempenho e a resolução de alguns problemas de saúde. Essas transições para as Clínicas da Família também irão absorver as questões relacionadas à saúde mental nos territórios? Como se dará o cuidado em saúde mental? Atualmente, observa-se uma demanda crescente por atendimentos de emergência para condições que poderiam ser tratadas adequadamente nas Unidades de Saúde da Família (USF), resultando em um aumento das internações desnecessárias, especialmente em saúde mental. Além disso, há desafios significativos no manejo de casos relacionados à saúde mental dos usuários e suas famílias (TAVARES et al, 2023). A efetividade das ações em saúde mental nesse nível de atenção são cruciais para a identificação precoce de transtornos, a implementação de estratégias de intervenção e a promoção de um suporte contínuo e acessível à população.

Sabe-se que mudanças políticas geram inseguranças, ainda mais quando o assunto saúde é colocado em pauta. Cabe lembrarmos as lutas sociais que foram travadas a fim de cunhar os princípios que regem o SUS no Brasil. No entanto, a população almeja por melhores condições de vida e melhores condições para acesso aos serviços de saúde nos territórios, facilitando o acesso a cuidados primários, consultas médicas, acompanhamento de saúde mental e programas de prevenção e promoção da saúde (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 2024; RAIMUNDI et al., 2016).

Diante desse contexto, torna-se fundamental refletir sobre a organização dos serviços de saúde nos territórios, especialmente no que se refere à integralidade do cuidado. A garantia de acesso deve estar aliada à qualidade da atenção prestada, considerando as necessidades singulares dos usuários e de seus familiares. É nesse cenário que a saúde mental ganha centralidade, demandando ações articuladas entre os diferentes níveis de atenção e valorizando práticas que respeitem a autonomia, os vínculos comunitários e a escuta qualificada (TAVARES et al, 2023).

O cuidado em saúde mental no território proporciona à pessoa em sofrimento psíquico e suas famílias a possibilidade de reinserção aos espaços de vida cotidiana, ofertando maior inserção e aceitação dos usuários na comunidade (PELEK et al., 2022).

Tendo em vista que a APS se constitui como plano privilegiado para o cuidado em saúde mental no território, os enfermeiros, atuantes desse serviço, necessitam ampliar seu olhar para além da saúde física e reconhecer a saúde mental como indissociável de qualquer contexto e ação realizada.

Faz-se necessário aprimorar sua prática de trabalho, incluindo a família com fator indispensável para o cuidado em saúde mental (MARCOLINO; FANTINATTI; GOZZI, 2018).

Ao envolver as famílias, o enfermeiro promove o cuidado em saúde mental integral, possibilitando que essas famílias encontrem sentido para a vivência de seus próprios sofrimentos, ampliando seus conhecimentos a respeito do sofrimento psíquico de seu ente, além de desenvolverem habilidades no contexto de cuidar (NÓBREGA et al., 2020). Nesse sentido, torna-se essencial a construção de uma parceria enfermeiro-família para potencializar o cuidado em saúde mental, mas para tanto, torna-se pertinente compreender as perspectivas de enfermeiros e familiares sobre as ações de saúde mental na APS (COSTA et al., 2017).

O enfermeiro exerce um papel central na Atenção Primária à Saúde (APS), especialmente no contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo protagonista nas ações de acolhimento, escuta qualificada, promoção da saúde mental e articulação com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Suas práticas incluem visitas domiciliares com abordagem psicossocial, desenvolvimento de atividades educativas e construção de planos terapêuticos que envolvem ativamente os usuários e seus familiares. A família, por sua vez, é reconhecida como elemento fundamental no cuidado contínuo, atuando tanto como cuidadora quanto como parceira no planejamento e execução das ações terapêuticas. A corresponsabilização entre equipe de enfermagem e família contribui para o fortalecimento do vínculo, adesão ao tratamento e efetivação de um cuidado integral, humanizado e territorializado, conforme preconizado pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SANTOS et al., 2025).

A abordagem que será adotada nesta investigação será a qualitativa, tendo como referencial teórico-filosófico a sociologia fenomenológica de Alfred Schutz. Visto que este método está ancorado no campo das ciências sociais e humanas, fundamentado nas áreas da sociologia e fenomenologia, pode-se assim contribuir para melhor compreensão do fenômeno a ser estudado.

A sociologia fenomenológica fundamenta-se naquele que vivencia a experiência de determinado fenômeno, pois só o próprio indivíduo pode dizer o que pretende com a ação. Com este entendimento a abordagem valoriza o sujeito, suas vivências e suas ações conscientes e intenções (SCHUTZ, 2018). Desta maneira, este referencial poderá auxiliar nos processos reflexivos que permitam ao enfermeiro instituir ações em saúde mental permeadas pelo modo de atenção psicossocial em que as famílias das pessoas em sofrimento psíquico possam ser protagonistas.

Durante meu processo formativo no mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(EEUFRGS), trabalhei com a ótica da Sociologia Fenomenológica de Alfred Schutz com a temática acerca das *“Motivações de Familiares no Cuidado ao Usuário de Drogas”* (SILVA et al., 2023) com base nas vivências e experiências de cada sujeito, de acordo com a metodologia compreensiva. Minha pesquisa foi realizada em dois serviços de tratamento de usuários de substâncias (internação e ambulatório em adição) de um hospital universitário no sul do Brasil com 15 familiares de usuários de substâncias em tratamento sendo cinco deles abordados na internação e 10 no ambulatório. Ainda que a família possa representar fator de risco ou de proteção para o uso de substâncias, o olhar do profissional de saúde e de enfermagem deve se voltar para a avaliação da organização e dinâmica das relações da vida do usuário na família, apontando para uma lacuna de cuidado à família que precisa ser melhor estudada e atendida nos serviços que atende usuários de substâncias, uma vez que o cuidado à unidade familiar sempre se mostra essencial para resultados mais duradouros e consistentes. Portanto, esse cuidado deve considerar a família a partir da compreensão de suas singularidades (desejos e intenções) construídas ao longo de suas experiências vividas (biografia). Portanto, os profissionais que atuam na área da saúde mental devem se tornar mais sensíveis no trabalho com os familiares das pessoas em sofrimento psíquico, conscientizando-se do seu papel como provocadores e catalisadores dos processos de reinserção social desses sujeitos.

No campo da saúde mental e da enfermagem, o atual contexto de trabalho tem suscitado reflexões importantes e necessárias em relação às ações de enfermagem voltadas à APS, bem como as perspectivas de familiares das pessoas em sofrimento psíquico que buscam esses serviços caracterizados como porta de entrada nas comunidades.

As ações de saúde mental desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde (APS) são relevantes e carregam significados específicos para profissionais de enfermagem e familiares, pois refletem experiências, percepções e práticas cotidianas de cuidado. Tais ações não são neutras; ao contrário, são construídas socialmente por quem as vivencia, o que justifica abordagens investigativas de cunho qualitativo. A APS, nesse contexto, apresenta grande potencial para atuar em duas frentes principais: a primeira voltada à detecção das queixas relacionadas ao sofrimento psíquico, mediante uma escuta qualificada e acolhedora; e a segunda voltada à forma de enfrentamento desses problemas, seja por meio do tratamento direto na APS, seja por meio do encaminhamento dos pacientes aos serviços especializados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), fortalecendo a integralidade e a continuidade do cuidado em saúde mental (TANAKA; RIBEIRO, 2009).

Essa pesquisa torna-se relevante por ouvir as vozes dos enfermeiros e familiares, abordando suas experiências vividas no primeiro nível de atenção, relacionadas com a atenção em saúde mental

no território. Desse modo, o presente estudo teve como propósito oferecer subsídios que permitam qualificar o cuidado em saúde mental e enfermagem a partir das reflexões sobre as perspectivas de enfermeiros e familiares sobre as ações de saúde mental na APS.

Ouvir as vozes de enfermeiros e familiares no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) não deve se limitar a um exercício descritivo ou meramente empático, mas precisa ser entendido como ponto de partida para processos concretos de transformação institucional e política no cuidado em saúde mental. A escuta qualificada, orientada pela fenomenologia social de Alfred Schutz, permite acessar os sentidos subjetivos das experiências vividas, revelando as motivações, expectativas e intencionalidades que permeiam a prática cotidiana desses sujeitos. No entanto, esses sentidos só ganham potência transformadora quando são tomados como base para a construção coletiva de respostas institucionais que respeitem a autonomia dos sujeitos e fortaleçam os vínculos no território.

Nesse sentido, é necessário que as instituições extrapolem a lógica das capacitações pontuais e avancem na construção de dispositivos de cogestão do cuidado, que incorporem a participação ativa dos profissionais, usuários e familiares. Tais práticas se alinham à concepção de clínica ampliada e gestão democrática do cuidado, conforme proposto por autores como Merhy e Feuerwerker (2006), que defendem o compromisso ético-estético-político da equipe de saúde com a singularidade dos sujeitos e com o fortalecimento das redes de apoio. Ao mesmo tempo, é fundamental promover espaços instituintes (CAMPOS, 2000) para a problematização permanente do fazer em saúde, onde as experiências relatadas possam ser reinterpretadas de forma crítica e transformadora.

A escuta deve, portanto, alimentar processos intersetoriais, revisões de fluxos assistenciais e redesenho das práticas de cuidado, promovendo estratégias territoriais que reconheçam os familiares como coprodutores da saúde e parceiros ativos na construção de planos terapêuticos. Isso exige, ainda, o reconhecimento das desigualdades sociais e institucionais que atravessam o cotidiano dos serviços e que, muitas vezes, produzem exclusão e silenciamento. Diante disso, investir em formas de cuidado que considerem os saberes locais, os vínculos afetivos, as redes comunitárias e os modos de vida é uma estratégia potente de resistência e reinvenção do cuidado em liberdade, como preconiza a Reforma Psiquiátrica.

Assim, esta pesquisa não se propõe apenas a descrever realidades, mas a potencializar mudanças, contribuindo para o aprimoramento das práticas em saúde mental na APS, a partir da valorização dos sujeitos que nelas atuam e são por elas afetados. Trata-se, portanto, de um movimento ético e político, que reafirma o papel da enfermagem como agente articulador do cuidado integral, fortalecendo o SUS como sistema público, universal e socialmente comprometido.

Assim, minha pesquisa permitiu um olhar voltado os familiares na sua singularidade, destacando a sua importância como elemento fundamental no tratamento das pessoas em sofrimento psíquico, uma vez que suas perspectivas possam ser fortalecidas e apoiadas na relação com profissionais de saúde e enfermagem, além de propor um “repensar de práticas” dos enfermeiros da APS quanto às ações de saúde mental para melhoria do cuidado prestado aos pacientes, família e comunidade.

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir com o aprofundamento da compreensão dessa temática, contribuindo em âmbito científico e assistencial para a construção do conhecimento na área da saúde e da enfermagem, colaborando para o cuidado em saúde mental no território. Nesse sentido, partindo da implicação como enfermeira, pesquisadora e futura docente de Enfermagem, a confecção desse projeto de doutorado tem por finalidade a produção de conhecimento na área da saúde mental.

Nesse sentido, com o intuito de contribuir com a pesquisa em enfermagem sobre a compreensão das perspectivas de enfermeiros e familiares sobre as ações de saúde mental na APS sob a ótica do referencial teórico-filosófico da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz, define-se como questão norteadora: *Qual é o significado das ações em saúde mental na Atenção Primária (APS) na perspectiva de enfermeiros e familiares?*

Assim sendo, o referencial da fenomenologia social proposto neste estudo busca preencher uma lacuna na produção de conhecimento sobre as ações voltadas para a saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo a perspectiva de atores sociais fundamentais, como enfermeiros e familiares, ressaltando a importância de suas experiências e vivências nesse contexto.

Embora a literatura nacional venha ampliando as discussões sobre saúde mental na Atenção Primária à Saúde, observa-se que grande parte dos estudos concentra-se na organização dos serviços, nos processos de trabalho, nos desafios da Rede de Atenção Psicossocial e nas práticas profissionais desenvolvidas pelas equipes. Ainda são menos frequentes as pesquisas que buscam compreender, de forma aprofundada, os significados atribuídos às ações de saúde mental a partir das experiências vividas pelos próprios enfermeiros e familiares, especialmente em uma perspectiva fenomenológica e relacional.

No que se refere aos enfermeiros, os estudos frequentemente abordam dificuldades relacionadas à formação, à sobrecarga de trabalho, à insegurança profissional e à fragilidade do apoio matricial para o cuidado em saúde mental na APS. Entretanto, poucas investigações privilegiam a

escuta das experiências subjetivas desses profissionais, considerando seus motivos, expectativas, intenções e sentidos atribuídos ao cuidado produzido no cotidiano dos serviços.

Da mesma forma, embora a família seja reconhecida como elemento central no cuidado em saúde mental e na permanência do usuário no território, observa-se que sua participação nas pesquisas ainda ocorre, muitas vezes, de maneira secundária, sendo mais comum a abordagem da família como suporte ao tratamento do que como sujeito que experiencia, interpreta e produz sentidos sobre o cuidado em saúde mental. Desse modo, permanecem lacunas quanto à compreensão das vivências, necessidades, expectativas e perspectivas dos familiares sobre as ações desenvolvidas na APS.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de estudos que valorizem a escuta de enfermeiros e familiares enquanto atores sociais diretamente implicados no cuidado em saúde mental no território. A partir do referencial da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz, este estudo busca contribuir para o preenchimento dessa lacuna ao compreender os significados das ações em saúde mental na APS a partir das experiências intersubjetivas desses sujeitos, ressaltando suas vivências, relações e construções de sentido no cotidiano do cuidado.

3) OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GERAL

Compreender o significado das ações de saúde mental na APS na perspectiva de enfermeiros e familiares.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Conhecer as ações em saúde mental que são desenvolvidas por enfermeiros na APS;
- ✓ Conhecer as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros voltadas aos familiar-cuidador de pessoas em sofrimento psíquico;
- ✓ Identificar as intenções de enfermeiros sobre as ações de saúde mental na APS;
- ✓ Compreender as expectativas de familiares em relação às ações de saúde mental desenvolvidas por enfermeiros;
- ✓ Descrever o típico da ação de familiares e enfermeiros quanto às ações em saúde mental na APS.

4) REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura está estruturada em três tópicos: 1) Revisão de Escopo sobre as Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde (SILVA; NASI; FIORINI, 2025) (ANEXO 2), em formato de artigo; 2) Contextualização sobre Família e Saúde Mental na APS; 3) Referencial Teórico-Filosófico de Alfred Schutz.

TÓPICO 1 – REVISÃO DE ESCOPO

Título: Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

Resumo:

Objetivo: Identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde. **Método:** Foi conduzida uma revisão de escopo, seguindo o referencial do *Joanna Briggs Institute* e pelo protocolo PRISMA-ScR, com o objetivo de responder à questão: “Quais são as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde?” nas bases de dados LILACS, BVS, Medline e BDENF. **Resultados:** Foram incluídos 20 estudos na revisão. As ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS foram classificadas em duas categorias: Ações de cuidado enfermeiro-paciente e Desafios das ações de Saúde Mental. Exibição do fluxograma construído. **Conclusão:** Espera-se que a *scoping review* contribua em âmbito científico e assistencial para a construção do conhecimento na área da saúde e da enfermagem a partir da análise crítica das ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família.

Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como o primeiro nível assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada o centro articulador de acesso à comunidade às Redes de Atenção em Saúde (RAS), orientada pelos princípios de acessibilidade, integralidade, coordenação do cuidado e espaço potente para desenvolvimento de programas e ações, considerando as reais necessidades de saúde dos usuários e suas famílias (OLIVEIRA et al., 2017).

As principais estruturas físicas da APS são as unidades de saúde (US) instaladas próximas às comunidades, isto é, desempenham papel central na garantia de acesso aos usuários e suas famílias a uma saúde pública de qualidade. As US ofertam à comunidade serviços diversos, entre eles: acolhimento de demandas, consultas médicas e de enfermagem, educação em saúde, espaço de promoção de saúde mental, dentre outros (GIOVANELLA et al., 2021; TAVARES et al, 2023).

As US proporcionam a mobilização de recursos institucionais e comunitários para o enfrentamento aos problemas relacionados à saúde mental, além de articular saberes técnicos e populares ao cuidado à essa clientela (NUNES et al., 2020). O cuidado em saúde mental no território proporciona à pessoa em sofrimento psíquico e suas famílias a possibilidade de reinserção aos espaços de vida cotidiana, ofertando maior inserção e aceitação dos usuários na comunidade (GIOVANELLA et al., 2021).

Tendo em vista que a APS se constitui como plano privilegiado para o cuidado em saúde mental no território, os enfermeiros, atuantes desse serviço, necessitam ampliar seu olhar para além da saúde física e reconhecer a saúde mental como indissociável de qualquer contexto e ação realizada. Faz-se necessário aprimorar sua prática de trabalho, incluindo a família como fator indispensável para o cuidado em saúde mental (MARCOLINO; FANTINATTI; GOZZI, 2018).

Ao envolver as famílias, o enfermeiro promove o cuidado em saúde mental integral, possibilitando que essas famílias encontrem sentido para a vivência de seus próprios sofrimentos, ampliando seus conhecimentos a respeito do sofrimento psíquico de seu familiar-cuidador, além de desenvolverem habilidades no contexto de cuidar (NÓBREGA et al., 2020). Nesse sentido, torna-se essencial a construção de uma parceria enfermeiro-família para potencializar o cuidado em saúde mental, mas para tanto, torna-se pertinente identificar as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde (APS) (COSTA et al., 2017).

Nesse sentido, com o intuito de contribuir com a pesquisa em enfermagem sobre as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS, define-se como questão norteadora: *Quais são as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde?*

Essa pesquisa torna-se relevante e tem como propósito oferecer subsídios para a construção do conhecimento na área da saúde e da enfermagem a partir da análise crítica das ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS.

Assim, essa pesquisa permitirá um olhar mais aprofundado sobre as práticas atuais, desafios enfrentados e estratégias eficazes no cuidado à saúde mental no contexto da APS.

Ao analisar as ações desenvolvidas por enfermeiros no referido campo de atuação a nível primário, essa pesquisa visa identificar as potencialidades no cuidado à pessoa em sofrimento psíquico e suas famílias promovendo um entendimento mais claro das dinâmicas envolvidas no cuidado à essa clientela. Espera-se que esse estudo possa proporcionar insights valiosos que impulsionem a formulação de políticas, a prática de cuidado em liberdade e a educação profissional, contribuindo para um atendimento mais eficaz e humanizado.

Além disso, ao destacar as limitações e desafios, essa pesquisa visa sugerir direções para a implementação de melhorias, como a necessidade de formação específica em saúde mental para enfermeiros e a importância de abordagens integradas e colaborativas no cuidado. A identificação de boas práticas e a análise crítica das ações realizadas são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover o cuidado em saúde mental centrado nos princípios do SUS e no cuidado em liberdade preconizado pela Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Em última análise, essa pesquisa busca promover um avanço no conhecimento e na prática da saúde mental na APS, apoiando a construção de um sistema de saúde mais inclusivo e efetivo. Através da análise crítica e da reflexão sobre as práticas atuais, espera-se contribuir para a melhoria contínua da qualidade do cuidado e o fortalecimento da saúde mental no nível primário de atenção.

O objetivo dessa *scoping review* consiste em identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde (APS). Esse mapeamento permitirá identificar as práticas e estratégias empregadas, os desafios enfrentados, as potencialidades observadas e as lacunas existentes no cuidado em saúde mental oferecido nesse nível de atenção.

Método

O estudo configura-se como uma revisão de escopo a qual seguiu as orientações do Preferred Reporting items for Systematic Reviews and meta-analysis extension for scoping reviews (PRISMA-SCR 2020), elaborada de acordo com o referencial teórico disponibilizado pelo *Joanna Briggs Institute* (JBI) (PETERS, 2020) utilizando a estratégia PCC (acrônimo de P: População = Enfermeiros, C: Conceito = Ações em Saúde Mental, C: Contexto = Atenção Primária à Saúde), com a questão norteadora: Quais são as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde? O protocolo de pesquisa foi registrado no *Open Science Framework*, com identificação do doi: 10.17605/OSF.IO/TEWVZ.

Esse tipo de revisão permite explorar as principais evidências científicas, identificar e mapear possíveis lacunas e propor estudos futuros. Buscou-se realizar uma análise com objetivo de propagar conhecimentos acerca do tema das ações em saúde mental na Atenção Primária à Saúde (PETERS, 2020). As buscas foram realizadas de abril a julho de 2024. Os critérios de inclusão foram: publicações disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês, português e espanhol, nos últimos 10 anos. Foram excluídos estudos do tipo opinião, carta ao editor, editoriais, utilizando-se as palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Enfermagem, Saúde Mental e Família nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Portal Regional da Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS), no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline), Banco de Dados em Enfermagem – Bibliografia Brasileira (BDENF). A busca considerou documentos da literatura cinzenta como Google Acadêmico (apenas as 05 primeiras páginas). Para adequação às demais bases de dados e plataformas foram também utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) para as bases em português: Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família e Medical Subject Healding (MESH): Primary Health Care, Nursing, Mental Health, Family, para as bases em inglês.

A primeira etapa da pesquisa foi realizada na BVS, para análise das palavras contidas no título e no resumo, com a utilização das seguintes palavras-chave: “Primary Health Care”, “Nursing”, “Mental Health”, “Family” que eram potencialmente elegíveis, para responder à questão e abordavam os elementos do PCC: População = Enfermeiros, C: Conceito = Ações em Saúde Mental, C: Contexto = Atenção Primária à Saúde. Para a continuidade da seleção e recuperação dos textos completos, foi gerada uma planilha Excel, a partir do Rayyan do *Qatar Computing Research Institute* (QCRI) (RAYYAN, 2022), onde foram extraídos os seguintes dados: título, autores, objetivo e metodologia. Na segunda etapa, os estudos foram identificados por meio de estratégia de busca adaptada para cada base eletrônica de dados (Quadro 1). Somando-se os descritores com os termos booleanos: AND, OR para compor as chaves de busca. Nessa etapa houve a leitura do texto completo de todos os artigos selecionados e foram excluídos os estudos que não cumpriam os critérios de inclusão do estudo (Figura 1).

A análise do conteúdo deu-se a partir da leitura atenta e detalhada dos estudos, que foram agrupados conforme suas semelhanças, emergindo dois temas que atendiam ao objetivo desta revisão de escopo. O método de tratamento e o resumo dos dados foram mapeados conforme a temática e seguiram as determinações do PRISMA-ScR.

Por se tratar de uma revisão de escopo, não houve submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pois foram utilizados, como fonte de dados, documentos com acesso aberto (artigos, consensos e recomendações), garantido-lhes a especificação de autoria para salvaguardar a propriedade intelectual. Este estudo respeita a lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais e dá outras providências.

Quadro 1. Estratégias de busca por base de dados. Porto Alegre, 2024.

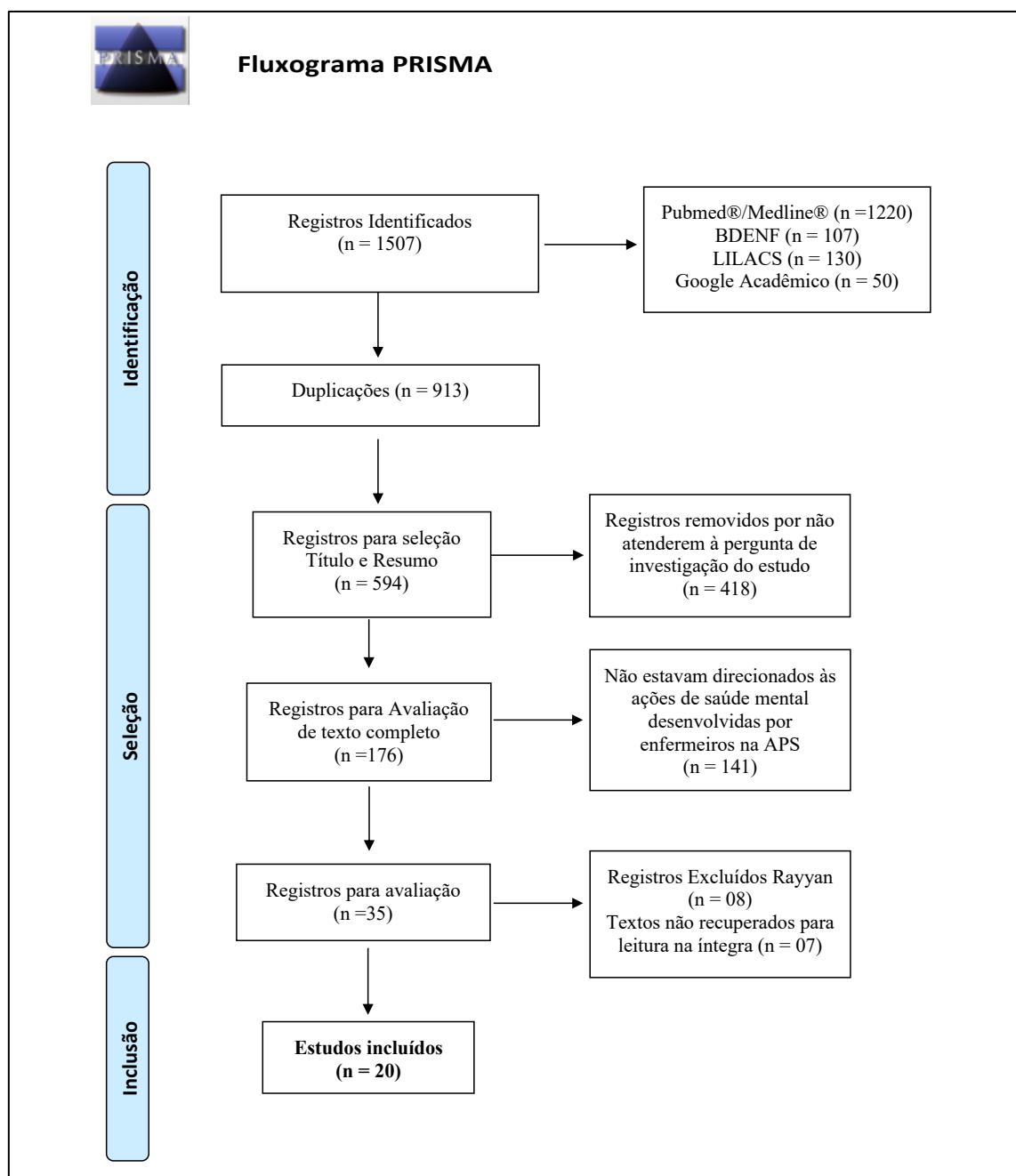
Bases	Estratégia de Busca
Medline/PubMed	(Primary Health Care) AND (nursing) AND (Mental Health)

	AND (Family)
LILACS/BDENF	Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família
Google Acadêmico	Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família

Fonte: Silva FM (2024).

As etapas de seleção dos estudos foram realizadas de acordo fluxograma de revisão do escopo (PRISMA - ScR), conforme a Figura 1.

Figura 1 - Diagrama de fluxo do processo de seleção dos artigos da revisão, PRISMA-ScR.



Fonte: PRISMA-ScR (2020).

Resultados

Nessa *scoping review* foram encontradas 1507 publicações, após avaliação, 20 contemplaram os critérios de inclusão do estudo.

Para a apresentação dos estudos selecionados, foi gerada uma planilha no Excel, na qual foram extraídos os dados que seguem: título, autores, objetivo e metodologia. Assim, os resultados estão descritos no Quadro 2.

Quadro 2 - Artigos incluídos na revisão de escopo, considerando: título, autores, objetivo, metodologia e resultados. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 2024.

N. ARTIGO	TÍTULO	AUTOR	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
01	Atitudes de enfermeiros frente ao envolvimento da família nos cuidados à pessoa com transtorno mental	NÓBREGA et al, 2020.	Caracterizar as atitudes dos enfermeiros, de Atenção Primária à Saúde, quanto ao envolvimento da família nos cuidados às pessoas com Transtorno Mental.	Estudo correlacional, com 257 enfermeiros do município de São Paulo. Utilizou-se a escala “Importância das Famílias nos Cuidados de Enfermagem-Atitudes dos Enfermeiros”. A análise foi realizada com recurso de estatística descritiva e inferencial.	Os enfermeiros que atuam em cuidados primários no município de São Paulo detêm, na sua maioria, uma atitude positiva para com o envolvimento das famílias, indicador relevante para a integração dessas no processo de cuidado em saúde-doença mental. Aponta-se ainda que a carga-horária de 40hs/sem de trabalho favorece o maior contato com a população, e que as habilitações acadêmicas e a especialização parecem relacionar-se com atitudes mais positivas em relação às famílias e, consequentemente, potencializar a qualidade nos cuidados.
02	Saúde mental: representações sociais dos enfermeiros da estratégia saúde da família	TAVARES et al, 2023.	Compreender as representações sociais dos enfermeiros das Estratégias Saúde da Família sobre a Saúde Mental na Atenção Primária e analisar as implicações dessas	Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando o referencial teórico e metodológico da Teoria das Representações Sociais.	Emergiram três núcleos direcionadores: ‘Impressões e Representações consensuais quanto a Saúde Mental na Atenção Primária’; ‘Intervenções de enfermagem na Estratégia Saúde da Família no âmbito da saúde mental’ e ‘Expectativas em relação à rede de atenção à saúde mental’.

			representações sociais no cuidado de pessoas acometidas de doença mental.		
03	Usuários de substâncias psicoativas: desafios à assistência de enfermagem na Estratégia Saúde da Família	MILITÃO et al, 2021.	Analisar a assistência de Enfermagem ao usuário de substâncias psicoativas na Estratégia Saúde da Família.	Estudo descritivo e qualitativo realizado com sete enfermeiros da Estratégia Saúde da Família de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas guiadas por um roteiro semiestruturado e a Análise Temática de Conteúdo foi utilizada para o seu tratamento.	A assistência prestada pelos entrevistados é pautada na demanda espontânea, sem estratégias de busca ativa, com a valorização de práticas orientadas pela medicalização da pessoa e o encaminhamento aos serviços especializados. A inclusão da família no processo de reabilitação, o atendimento imediato e o exercício da escuta terapêutica foram mencionados como estratégias que podem ser adotadas para uma assistência integral. Os desafios mencionados referiram-se à falta de formação em saúde mental, à fragmentação do conhecimento acerca da especialidade, à ausência de capacitações e ao desejo do paciente em participar do tratamento.
04	Assistência em saúde mental na Atenção Primária: perspectiva dos profissionais da	CARDOSO et al, 2021.	Apreender as percepções dos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde	Estudo descritivo, qualitativo, realizado com 29 profissionais de saúde, mediante entrevistas abertas e individuais. Adotou-se o software IRaMuTeQ® para organização dos dados,	Da análise de conteúdo, emergiram-se três classes: “Percepções sobre o atendimento de saúde realizado no município”, “O paradigma biomédico na assistência de saúde mental”,

	Estratégia Saúde da Família		sobre a assistência em saúde mental.	após a qual foram submetidos ao processo de análise de conteúdo de modalidade temática.	“Elementos para a construção de um novo fazer profissional em saúde mental”.
05	A percepção dos profissionais sobre as ações de saúde mental na rede de atenção psicossocial em Belo Horizonte	COELHO et al, 2021.	Compreender a construção das ações de saúde mental na rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte, sob a ótica dos profissionais em uma perspectiva histórica.	Trata-se de uma abordagem qualitativa baseada na história oral, fundamentada na Sociologia Compreensiva do Cotidiano.	Os dados encontram-se organizados em duas categorias temáticas: “A transição do modelo de cuidado: criação dos CERSAM” e “Dificuldades para a assistência ao paciente em sofrimento mental”. O movimento da Reforma Psiquiátrica em Belo Horizonte permitiu que os primeiros CERSAMs fossem construídos pautados nos ideais do cuidar em liberdade e centrados no indivíduo com sofrimento psíquico. Ademais, destacou-se a crescente procura pelos serviços seguidos de fragilidades relacionadas ao quantitativo de profissionais nos serviços da rede de saúde, o que constitui lacunas assistenciais.
06	O cuidado aos portadores de sofrimento mental na atenção primária: uma prática interdisciplinar e multiprofissional	ALMEIDA DR, SOARES JNC, DIAS MC et al, 2020.	Conhecer como é realizado o cuidado ao Portador de Transtorno Mental (PTM) nas Estratégias de Saúde da Família, verificando se os profissionais estão seguros da sua atuação.	trata-se de um estudo qualitativo, embasado na análise do discurso, realizado nas Estratégias da Saúde da Família de uma cidade da região norte de Minas Gerais; a coleta de dados realizou-se através de um roteiro de entrevista semiestruturada.	Os profissionais se sentem inseguros para atuarem nessa área de concentração sendo levantados como dificultadores a deficiência na teoria científica e a desarticulação da rede, porém contraditório a esses surge uma nova expectativa: “o matriciamento” uma ferramenta implantada como apoio para a assistência que vem se tornando a principal

					arma para um cuidado mais holístico.
07	Práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Estratégia Saúde da Família	SILVA FILHO, J.A. et al, 2019.	Compreender as práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros no âmbito da Estratégia Saúde da Família.	Pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa. Participaram do estudo 10 enfermeiros atuantes nas Estratégias Saúde da Família de um município da região Centro-Sul do Estado do Ceará.	A partir dos dados emergiram as categorias: Compreensão dos enfermeiros sobre o cuidado em saúde mental na Estratégia Saúde da Família e Práticas do enfermeiro no cuidado à Saúde Mental na Estratégia Saúde da Família. Os enfermeiros não se sentem preparados para trabalhar com saúde mental, culminando na oferta de ações superficiais, sem considerar as necessidades reais dos usuários. É apontado, mesmo que poucas vezes, o acolhimento, a escuta, a preocupação com o retorno dos usuários as unidades e o referenciamento dos pacientes para os serviços especializados.
08	Saúde mental na atenção básica: atuação do enfermeiro na rede de atenção psicossocial	NUNES et al, 2020.	Descrever e analisar a atuação do enfermeiro especialista em saúde mental na Estratégia Saúde da Família.	Estudo qualitativo, com 20 enfermeiros que atuam nas Unidades Básicas de Saúde da Família de Teresina, Piauí. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas no período de março a maio de 2017 e analisadas pelo método de análise de conteúdo.	Constatou-se que as concepções do processo saúde doença mental estiveram fundamentadas no modelo biológico, havia pouca comunicabilidade entre saúde mental e rede básica, os enfermeiros não se sentiam capacitados para trabalhar saúde mental e havia poucas ações de saúde mental na Atenção Básica.
09	Estratégia saúde da família: ações no	SILVA SM et al, 2017.	Analisar as atividades de atenção à saúde mental	Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi realizada entre abril e	Os profissionais apresentaram dificuldades para implantar a assistência aos portadores de

	campo da saúde mental		desenvolvidas por equipes de uma unidade de atenção primária à saúde em Fortaleza, Ceará, Brasil.	maio de 2013, através de entrevista semiestruturada, com sete profissionais da Estratégia Saúde da Família. Utilizou-se para tratamento dos dados a análise de conteúdo.	transtorno mental por falta de horários na agenda, carência de treinamento, bem como desafios na implementação do apoio matricial. Conclusão: faz-se necessário utilizar-se de dispositivos e estratégias de ação com competência técnica, ética e humanística para habilitar os profissionais da estratégia saúde da família na atenção à saúde dos portadores de transtorno mental.
10	Saúde mental na Estratégia Saúde da Família: a percepção dos profissionais	SOUZA et al, 2017.	Analisar o manejo das necessidades de saúde mental na atenção primária à saúde de acordo com a percepção dos profissionais da Estratégia Saúde da Família.	Estudo qualitativo, descritivo exploratório, desenvolvido no território de abrangência de cinco equipes de saúde da família. Os participantes foram cinco enfermeiras, cinco coordenadores e 17 agentes comunitários de saúde. Os dados foram coletados utilizando observação, entrevistas grupais, entrevistas individuais semiestruturadas e grupos focais. Fez-se a análise de conteúdo com o auxílio de um Software de análise textual, e a interpretação baseou-se nas estruturas analíticas correspondentes.	São inúmeras e desafiadoras demandas de saúde mental têm sido acolhidas nesse <i>setting</i> , para as quais as equipes identificaram recursos de atendimento; no entanto, apontaram dificuldades, sobretudo relacionadas à operacionalização e integração destes recursos. Destaca-se a necessidade de uma rede de cuidados sensível a tais demandas, mais articulada e gerida de modo eficaz.
11	Saúde mental no trabalho do Enfermeiro da	SILVA, A. P. M. et al, 2015.	Compreender como se desenvolve a preparação e qual o conhecimento	pesquisa qualitativa e exploratória, realizada com oito enfermeiros que atuavam na Atenção Primária à Saúde do meio urbano de Montes	Os entrevistados relataram que se sentiam preparados para lidar com seus pacientes e que conheciam os principais transtornos, mas

	Atenção Primária de um município no Brasil		que os enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da Família de Montes Claros - Minas Gerais apresentam sobre Saúde Mental para atendimento a pacientes com transtornos psíquicos.	Claros. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2011, por meio de entrevistas, que foram gravadas e, em seguida, transcritas. Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise do conteúdo.	poucos foram capazes de detalhar esse conhecimento. As capacitações e curso de residência foram citados como preparação, mas a insegurança e tempo disposto para lidar com esses pacientes foram impasses para um bom cuidado.
12	A situational analysis of primary health care centers in Brazil: challenges and opportunities for addressing mental illness and substance use-related stigma.	BOBBILI SJ, CARRARA BS, FERNANDES RHH, et al, 2022.	Analysis are twofold: (1) to understand the current mental health and substance use service delivery context and (2) identify challenges and opportunities for addressing MISUP-related stigma in PHC centers in Ribeirão Preto, Brazil.	Environmental scans of four Family Health Units were conducted in early 2018 to explore population needs and service delivery for individuals with MISUP. In addition, a symposium was organized in October 2018 to consult with diverse stake- holders and gather local perspectives about MISUP-related stigma conveyed in PHC settings. NVivo 12 software was used to conduct a thematic analysis of the qualitative data collected from the environmental scans and the symposium consultation.	Themes identified at the national level in the socioecological framework indicate that political support for national policies related to reducing stigma is limited, particularly regarding social inclusion and the decentralization of mental health services. Themes at the regional, organizational, and interpersonal levels include insufficient mental health expertise and the limited involvement of those with lived experience in decision-making. Suggestions for stigma interventions were provided, including increased contact with individuals with lived experience outside of client-patient interactions, capacity building for

					professionals, and public education campaigns.
13	Factors Associated With Primary Family Caregivers' Perceptions on Quality of Family-Centered Care in Mental Health Practice	HSIAO, C. H.; LU, H. L, et al, 2019.	This study aimed to examine the quality of family-centered care perceived by primary family caregivers and its influencing factors in mental healthcare practice.	A convenience sample of 121 mental health nurses and 164 primary family caregivers of patients with schizophrenia was recruited from acute psychiatric wards and chronic psychiatric rehabilitation wards in three psychiatric hospitals in Taiwan. Structured questionnaires for mental health nurses were designed to examine nurses' attitudes toward schizophrenia and the importance of families in nursing care. Primary family caregivers were assessed to determine their perceptions of quality of family-centered care. At least one primary family caregiver of patients was matched to a nurse who took major responsibility for the patient during the hospitalization. Data were analyzed with descriptive statistics, Pearson's product-moment correlations, independent t-test, one-way analysis of variance, and stepwise regression analyses.	Quality of family-centered care perceived by primary family caregivers regarding the provision of general and specific information, as compared to enabling and partnership, coordinated and comprehensive care, and respectful and supportive care, was relatively inadequate. Younger and more educated primary family caregivers, having relatives with schizophrenia in acute wards, less supportive nurses' attitudes toward schizophrenia, and the importance of family in nursing care were correlated with poor primary family caregivers' perceptions of quality of family-centered care. Nurses' supportive attitudes toward schizophrenia and chronic psychiatric rehabilitation wards where patients received care were key factors in determining better quality of family-centered care.
14	Saúde mental na atenção primária:	BARROS S, NÓBREGA	Analisar percepções da equipe de profissionais	Estudo qualitativo, de referencial teórico marxista e método dialético. Participaram 99	Obtiveram-se três categorias empíricas: Treinamento em Saúde Mental; Percepção do

	processo saúde-doença, segundo profissionais de saúde	MPSS, SANTOS JC et al, 2019.	da Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre o processo saúde-doença mental e identificar ações de saúde desenvolvidas pela equipe para pessoas com transtorno mental.	profissionais de nível médio e superior da ESF, município de São Paulo. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas, cujos dados foram submetidos ao software ALCESTE e Análise de Conteúdo Temática.	profissional da ESF sobre o processo saúde-doença mental; e Ações de saúde desenvolvidas pela equipe de ESF junto às pessoas com transtorno mental. Identificaram-se ações que convergem e divergem do modelo de atenção psicossocial.
15	A percepção e a prática dos profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre a Saúde Mental	PEREIRA RMP, AMORIM FF, GONDIM MFN, 2020.	Conhecer a percepção e a prática dos profissionais sobre a Saúde Mental na APS para contribuir no esclarecimento das dificuldades percebidas.	Trata-se de um estudo transversal qualitativo em profissionais das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) de Itumbiara, GO, Brasil, por meio de questionário semiestruturado, sendo realizada análise de conteúdo conforme técnica de Bardin.	Foram identificadas barreiras como incapacidade em lidar com demandas de Saúde Mental, receio no contato com usuário, falta de processos de trabalho específicos para a Saúde Mental e incompreensão de como realizar o acompanhamento e a interlocução entre os serviços de saúde de forma a garantir a integralidade. O entrave principal se dá em como fazer, necessitando intervenções efetivas de Educação Permanente.
16	Práticas em saúde mental na estratégia saúde da família: um estudo exploratório	LIMA et al, 2015.	Conhecer os procedimentos, as ações e condutas adotadas em saúde mental no âmbito da atenção básica.	Pesquisa qualitativa exploratória desenvolvida com duas equipes da Estratégia de Saúde da Família, em Juazeiro do Norte-CE, entre maio e junho/2009, através da observação não participante e de entrevistas semiestruturadas.	As ações voltadas à saúde mental relacionam-se à prescrição de psicotrópicos, ao encaminhamento de casos ao ambulatório e às visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família assume papel tímido, com consultas

					individuais e poucas atividades em grupo.
17	O processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental: análise reflexiva	NASCIMENT O MGG, NADALETI NP, NADALETI SC, et al, 2017.	Refletir acerca do processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental, de qualquer natureza, da população atendida na Estratégia de Saúde da Família (ESF).	Realizada uma reflexão voltada para o processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental da população da ESF.	A reflexão apresenta-se em duas vertentes: a primeira, em ‘O processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde no sofrimento mental’, seguida do ‘Processo de trabalho do enfermeiro: abordagem familiar e apoio matricial’.
18	Atenção à saúde mental na atenção primária de saúde: uma revisão sistemática	STERLING, GONÇALVES , HAAS, 2021.	Verificar evidências científicas referentes à atenção à saúde mental na atenção primária à saúde.	A busca por artigos científicos foi conduzida por dois pesquisadores independentes nas bases de dados Medline (Pubmed), LILACS, SciELO, Bireme, Web of Science e Scopus, sem restrição de idioma, período e localização. Foram incluídos na pesquisa estudos que obtiveram pontuação $\geq$ a 6 pontos segundo o protocolo para pontuação qualitativa proposto por Pithon et al. (2015).	Os estudos admitidos apontam para pacientes que obtiveram cuidados de saúde mental apenas do médico da atenção primária, bem como, avaliação de feedback consideraram os aplicativos úteis. Vinte e quatro (68,5%) dos pacientes relataram o uso de Breathe2Relax e 24 (68,5%) relataram o uso de autoajuda para Gerenciamento de Ansiedade. Foi apontado um maior foco no cuidado centrado no paciente, requer uma maior integração entre atenção primária e o setor de saúde mental para assim, haver uma redução da fragmentação do cuidado e das disparidades nos resultados da saúde. Os aplicativos relacionados à saúde mental são aplicáveis e

					relevantes para os pacientes em ambientes integrados de atenção primária em sistemas de saúde de rede de segurança.
19	Concepções e intervenções em saúde mental na ótica de Profissionais da estratégia saúde da família	DRESCHER A, BOTH JE, HILDEBRAN DT LM et al. 2016.	Compreender as percepções de profissionais da saúde vinculados às Estratégias de Saúde da Família sobre doença mental e acerca do atendimento a pessoas em sofrimento psíquico.	Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, no qual participaram nove profissionais de saúde vinculados a duas equipes com Estratégia de Saúde da Família de um município do Norte do Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados de acordo com a Técnica de Análise de Conteúdo, na modalidade análise temática.	Os entrevistados relacionam a doença mental com infração de regras, fuga dos padrões de normalidade, dependência para cuidados, incapacidade para a realização de atividades diárias. A assistência às pessoas com doença mental envolve visita domiciliária, consulta médica e de enfermagem, prescrição de medicamentos e encaminhamentos a serviço especializados.
20	Saúde Mental na atenção primária: desafios para a resolutividade das ações	ROTOLI, A. et al, 2019.	Identificar os desafios enfrentados pelos profissionais para agregar resolutividade às ações de saúde mental desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária.	Estudo qualitativo realizado com 30 profissionais, sendo 17 enfermeiras, quatro médicos, cinco psicólogos e quatro assistentes sociais. Dados coletados em três municípios do Rio Grande do Sul, Brasil, em abril de 2018 através de entrevistas semiestruturadas, posteriormente submetidos à análise temática.	Os desafios apontados para agregar resolutividade às ações estão relacionados com a lacuna de conhecimentos específicos para sustentar o que os profissionais desenvolvem; com a organização dos serviços e a participação dos gestores; e com a ambivalência da pessoa com transtorno mental em relação à aceitação e continuidade do tratamento.

Quadro 2 - Artigos incluídos na revisão de escopo, considerando: título, autores, objetivo e metodologia. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 2024.

Discussão

Essa revisão de escopo teve como propósito identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde (APS). Apesar dos estudos selecionados estarem limitados a APS, foi possível encontrar ações desenvolvidas por enfermeiros, além de explorar as relações enfermeiro-paciente, que no campo da APS, essa relação estende-se também aos familiares e comunidade, ou seja, uma das ações fundamentais é a relação de cuidado enfermeiro-paciente. Com isso, estruturam-se as duas categorias: Ações de cuidado enfermeiro-paciente na Atenção Primária em Saúde e Desafios das ações de Saúde Mental na Atenção Primária (APS), que se seguem abaixo.

Ações de cuidado enfermeiro-paciente na Atenção Primária em Saúde

A APS configura-se como um espaço potente para o desenvolvimento de programas e ações, uma dessas ações, direcionadas para o campo da saúde mental e atenção psicossocial, à pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador, ao buscar suporte para atendimento na APS, carrega consigo um arsenal de experiências vividas e expectativas em relação ao seu atendimento, isto é, arsenal composto por um histórico único de experiências prévias, podendo incluir episódios anteriores de tratamento favoráveis e desfavoráveis, estigmatização, desafios pessoais e familiares (GIOVANELLA et al., 2021; SILVA SM et al, 2017).

Nesse sentido, compreender esse arsenal de vivências da pessoa em sofrimento psíquico e suas famílias, torna-se essencial para ofertar um acolhimento personalizado e sensível em relação às demandas em saúde mental apresentadas, ou seja, permitir que pacientes e suas famílias expressem suas expectativas, ajuda o profissional a entender as motivações para a busca desse atendimento na APS, além de construir uma relação de confiança (COELHO et al, 2021).

Essa relação caracteriza-se por ser baseada na comunicação aberta, apoio emocional tendo como pilares essenciais a educação e colaboração de ambos envolvidos. Esse relacionamento é fundamental para garantir um cuidado eficaz, respeitoso e centrado no paciente e suas famílias, promovendo seu bem-estar mental e emocional, ou seja, essa relação caracteriza-se como componente central para a eficácia do cuidado e pode impactar nos resultados de saúde dos envolvidos. Uma relação de qualidade entre enfermeiro-paciente e seu familiar-cuidador na APS não apenas melhora a experiência do paciente, mas também pode levar a melhores resultados de saúde e maior satisfação com o cuidado recebido (CARDOSO et al, 2021).

Destaca-se alguns aspectos que são componentes chave dessa relação como: confiança e vínculo como dispositivo central para o compartilhamento de informações, sentimentos e preocupações lançando mão de uma comunicação aberta, com honestidade e suporte às necessidades do indivíduo e seu familiar-cuidador. Outros componentes primordiais para alicerçar essa relação são a escuta ativa e a empatia pelo sofrimento do próximo afim de validar as queixas trazidas, acolhê-las com propósito de ofertar apoio a situação descrita pelo paciente e suas famílias (SILVA FILHO, J.A. et al, 2019).

Nesse contexto, a escuta qualificada com clareza e simplicidade afim de elucidar diagnósticos, tratamentos e planos de cuidado, proporciona a melhor compreensão do paciente e suas famílias para que ambos possam participar ativamente do processo de cuidado instituído, para que obtenham entendimento necessário e concordem com as ações instituídas a fim de instrumentalizar o paciente a tomar decisões sobre seu próprio cuidado e promover sua autogestão como dispositivo crucial para o empoderamento sobre sua saúde (SILVA FILHO, J.A. et al, 2019).

Diante disso, auxiliar o paciente a promover sua autonomia diante das mais variadas ações cotidianas, o instrumentaliza a sentir-se pertencente à sociedade, ou seja, incentivá-lo a gerenciar suas expectativas de maneira realista sobre seu tratamento em saúde, a fim de ajudá-lo a lidar com os anseios que a vida cotidiana proporciona (NUNES et al, 2021).

O enfermeiro nesse processo de cuidado, ao incluir às famílias, ao elucidar o plano de cuidados instituídos ao paciente, minimiza anseios do familiar-cuidador, isto é, integra-o ao processo de cuidado e esclarece eventuais dúvidas e acaba por fortalecer o vínculo enfermeiro-paciente-família e comunidade (NASCIMENTO MGG, NADALETI NP, NADALETI SC, et al, 2017; BARROS S, NÓBREGA MPSS, SANTOS JC et al, 2019.)

Assim, ao estimular a participação ativa do paciente e suas famílias no plano de cuidado instituído, ajuda a garantir que as intervenções sejam relevantes e alinhadas com as necessidades e preferências apresentadas, ou seja, nesse processo, é importante que o Enfermeiro reconheça e considere as especificidades culturais, sociais e pessoais de cada paciente e seu contexto familiar, os ajudando a fornecer um cuidado mais individualizado e eficaz de acordo com suas necessidades em saúde (NÓBREGA MPSS, SANTOS JC et al, 2019).

Nesse sentido, ao ajustar o plano proposto, tendo em vista a necessidade de flexibilização diante das mais variadas situações da vida cotidiana do paciente e suas famílias, proporciona fortalecimento do vínculo enfermeiro-paciente e garante maior eficácia no tratamento proposto e maior engajamento do paciente e suas famílias no processo de cuidado instituído (NÓBREGA et al,

2020; HSIAO, LU & TSAI, 2019). Essas ações são fundamentais para garantir um atendimento holístico e integrado na APS, ajudando a promover o bem-estar mental e a qualidade de vida do paciente e seu familiar-cuidador (ALMEIDA DR, SOARES JNC, DIAS MC et al, 2020; STERLING, GONÇALVES E HAAS, 2021).

Todas ações apontadas, exigem do profissional Enfermeiro um arsenal de ferramentas que nem sempre os profissionais da APS as dispõem, por uma série de fatores desafiante, dentre esses, certa resistência e medo em assistir a pessoa em sofrimento psíquico, além de pouco arcabouço teórico para absorver as demandas de saúde mental no território, estigmas relacionados à pessoa em sofrimento psíquico, conhecimento ineficiente da rede de atenção psicossocial, entre outros (DRESCHER A, BOTH JE, HILDEBRANDT LM et al., 2016).

Em suma, a atenção à saúde mental na APS é essencial para promover o bem-estar tanto dos pacientes quanto de seus familiares. A construção de uma relação de confiança entre enfermeiros, pacientes e seus familiares, baseada em comunicação aberta, escuta ativa e empatia, é fundamental para oferecer um cuidado individualizado que se adapte às necessidades apresentadas pelo paciente e seu familiar-cuidador.

Contudo, os enfermeiros enfrentam desafios significativos, como a falta de formação específica e estigmas associados ao sofrimento psíquico, que podem dificultar a implementação dessas práticas. Portanto, é vital investir em capacitação e suporte para os profissionais de saúde, garantindo que eles estejam preparados para lidar com as complexidades da saúde mental, promovendo assim um atendimento integral e humanizado, capaz de atender às necessidades e expectativas de todos os envolvidos.

Desafios das ações de Saúde Mental na Atenção Primária (APS)

Ao final do ano 1989, tramitava no Congresso Nacional o projeto de lei que resultou, 12 anos depois, na lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. A referida lei reformulou, criou condições e instituiu novas formas de cuidar do indivíduo em sofrimento mental, visando sua inclusão na sociedade e protagonizou uma nova forma de pensar sobre a saúde mental e cuidado em liberdade (AMARANTE; NUNES, 2018; BERLINCK; MAGTAZ; TEIXEIRA, 2008).

Em 2011 foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (Portaria GM/ MS no 3.088 de 23 de dezembro de 2011), que tem por objetivo principal a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em seus diferentes níveis de complexidade; promoção do acesso das

pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção (BRASIL, 2002; (BRASIL, 2011; AMARANTE; NUNES, 2018).

Historicamente, os territórios caracterizam-se como espaços privilegiados para que as equipes da APS construam um processo de trabalho territorial, prestando assistência às necessidades de saúde apresentadas, inclusive absorvendo as demandas em saúde mental existentes. Cabe salientar que as ações em saúde mental devem ser construídas em equipe, pautadas nas necessidades em saúde apresentadas pelas comunidades e alicerçadas no cuidado em liberdade com a manutenção do vínculo enfermeiro-paciente e seu familiar-cuidador (LIMA et al, 2015; SILVA SM et al, 2017).

Sabe-se que o enfermeiro, no campo da APS, é o profissional que atua nos mais diversos dispositivos da rede de atenção psicossocial, ocupando importante papel nos cuidados à população adstrita. No entanto, o atendimento à saúde mental torna-se um desafio ao enfermeiro da APS, exigindo não apenas habilidades técnicas e conhecimento especializado, mas também requer um arsenal de ferramentas a fim de lidar com as especificidades da área, bem como com o estigma vivenciado pela pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador (BOBBILI SJ, CARRARA BS, FERNANDES RHH, et al 2022).

Em um estudo conduzido com profissionais da APS, em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF), apontam desafios como: a incapacidade em absorver das demandas em saúde mental existentes no território, falta de conhecimento da rede de atenção psicossocial, estigma imposto pela sociedade em relação à loucura, receio no contato com paciente em sofrimento psíquico, incompreensão de como realizar o cuidado em saúde mental e o pouco conhecimento teórico na área como barreiras apontadas na referida pesquisa. O entrave principal aponta a necessidade de intervenções efetivas de Educação Permanente (PEREIRA RMP, AMORIM FF, GONDIM MFN, 2020; ANA PAULA MAIA DA SILVA et al, 2015).

Pacientes em sofrimento psíquico acabam por atrair o olhar dos profissionais atuantes da APS pela ótica do estigma e preconceito, acabando por gerar barreiras e entraves no acesso à essa referida população. Na APS, em seu contexto, cuidados adequados, acolhimento e manejos apropriados, tornam-se fundamentais. Torna-se primordial ações conjuntas e articuladas de acordo com as demandas apresentadas, e caso não seja possível, é imprescindível conhecimento da rede de atenção psicossocial para que os encaminhamentos sejam realizados, para que paciente e seu familiar-cuidador possam sanar suas necessidades de atendimento com maior resolutividade (ROTOLI, A. et al, 2019).

Para que o profissional saiba o melhor encaminhamento a ser realizado, torna-se necessária capacitação das equipes das APS, para que saibam lidar com os anseios trazidos pela pessoa em sofrimento psíquico e seus familiares, uma vez que o cuidado em saúde mental acaba por gerar frustração, diferentemente, do cuidado clínico que busca a cura efetiva da comorbidade apresentada, que no caso da saúde mental, esse cuidado torna-se diferente, pois muitas vezes não é factível, podendo levar a sentimentos como impotência, autodepreciação e culpa (PEREIRA RMP, AMORIM FF, GONDIM MFN, 2020).

Em saúde mental, o objetivo pode não ser necessariamente a "cura" no sentido absoluto, mas sim proporcionar um tratamento eficaz, promover a recuperação e ajudar os pacientes a viverem de maneira saudável e significativa (MILITÃO et al, 2021). O cuidado em saúde mental no território tem caráter multifacetado, isto é, para que o profissional consiga absorver as demandas existentes, precisa sentir-se capacitado para tal. Assim, ações como a educação permanente em saúde se fazem necessárias. A educação permanente em saúde mental é essencial para melhorar a prática profissional, proporcionar um atendimento de qualidade e promover a recuperação e o bem-estar dos pacientes (PEREIRA RMP, AMORIM FF, GONDIM MFN, 2020).

Desafios são inerentes ao processo de trabalho do enfermeiro na APS, contudo, destaca-se que para superar esses desafios como forma de amenizar os obstáculos vivenciados e possibilitar a oferta de atendimento de qualidade e com caráter resolutivo, ações como: expansão dos espaços para discussões de casos, investimento em ações de matriciamento, capacitações em ações de saúde mental e melhor conhecimento da rede de atenção psicossocial são essenciais. Além disso é fundamental que os profissionais estejam orientados pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Reforma Psiquiátrica, sem faltar a motivação dos profissionais que atendem pacientes em sofrimento psíquico e suas famílias nos territórios e comunidades (ROTOLI, A. et al, 2019; NASCIMENTO MGG, NADALETI NP, NADALETI SC, et al, 2017).

Os enfermeiros enfrentam desafios substanciais ao lidar com pacientes que sofrem de transtornos mentais, incluindo a necessidade de adaptar suas práticas às especificidades e complexidades dos casos, lidar com a estigmatização e garantir uma adesão eficaz ao tratamento. Além disso, é fundamental reconhecer e respeitar as limitações no cuidado, abordando as lacunas existentes e trabalhando para superá-las.

Para enfrentar esses desafios e melhorar a qualidade do atendimento, a implementação de ações educativas em saúde mental se torna essencial. A educação permanente em saúde para os profissionais da APS é uma ferramenta indispensável para aprimorar o entendimento sobre os

transtornos mentais, desenvolver habilidades de manejo e fortalecer a capacidade de oferecer um cuidado centrado nas necessidades apresentadas pelo paciente.

A educação em saúde caracteriza-se por contemplar não apenas a atualização sobre novas práticas e evidências, mas também estratégias para lidar com as questões emocionais e comportamentais dos pacientes e suas famílias. Programas de formação devem incluir a promoção de habilidades interpessoais, o manejo de crises e o desenvolvimento de estratégias para melhor adesão ao tratamento.

Além disso, é crucial fomentar a educação e a conscientização nas comunidades para reduzir o estigma associado aos transtornos mentais e promover um ambiente de suporte e compreensão. A integração de práticas profissionais e a colaboração interprofissional também são componentes chave para a melhoria contínua do cuidado.

Em suma, o cuidado em saúde mental exige um compromisso contínuo com a educação e o aprimoramento profissional, bem como a implementação de estratégias eficazes para superar os desafios encontrados. O enfermeiro, ao desempenhar um papel ativo e informativo, contribui significativamente para a promoção da saúde mental e para a criação de um sistema de cuidado mais inclusivo e eficaz. Acredito que suas ações primordiais são a escuta e acolhimento capazes de amenizar as angústias e sofrimentos da pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador.

Conclusão

Esse estudo teve como propósito identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde (APS). Pode-se perceber que inúmeras ações em saúde mental são desenvolvidas no campo da APS, como supracitado acima. Tais ações tornam-se essenciais a fim de garantir um cuidado acessível, eficaz e centrado na pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador.

Durante a jornada profissional, o enfermeiro acaba por vivenciar desafios e obstáculos associados ao cuidado de pessoas com sofrimento psíquico e suas famílias exigindo desse profissional uma abordagem integrada, com formação adequada e colaboração entre diferentes profissionais e diversos serviços existentes na rede atenção psicossocial. A superação desses desafios é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover o cuidado em saúde mental centrado nos princípios do SUS e no cuidado em liberdade preconizado pela Reforma Psiquiátrica Brasileira.

É fato que com esse estudo, a discussão sobre o tema não é esgotada. Cabe ressaltar que apesar do enfermeiro ser um profissional que pode atuar nos mais diferentes níveis de atenção, a saúde

mental transpassa por todas as áreas de atuação. É natural enfrentar desafios, conhecer as limitações no cuidado à essa clientela tão específica, contudo, ações em educação permanente em saúde se tornam necessárias, a fim de instrumentalizar o profissional que atuantes nos mais diferentes níveis de complexidade do cuidado, existindo e coexistindo próximo às comunidades.

Referências

1. ALMEIDA, D. R.; SOARES, J. N. C.; DIAS, M. C.; ROCHA, F. C.; ANDRADE, G. R. N.; ANDRADE, D. L. B. Care for carriers of mental disorder in primary care: an interdisciplinary and multiprofessional practice. **Rev. Fun Care Online**, jan./dez. 2020, v. 12, p. 420-425. DOI: <http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v12.8388>.
2. AMARANTE, P.; NUNES, M. O. A reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 6, p. 2037-2074, 2018.
3. BOBBILI, S. J.; CARRARA, B. S.; FERNANDES, R. H. H.; VENTURA, C. A. A. A situational analysis of primary health care centers in Brazil: challenges and opportunities for addressing mental illness and substance use-related stigma. **Prim. Health Care Res. Dev.**, v. 23, e37, p. 1–9, 2022. DOI: 10.1017/S1463423622000251.
4. BARROS, S.; NÓBREGA, M. P. S. S.; SANTOS, J. C.; FONSECA, L. M.; FLORIANO, L. S. M. Mental health in primary health care: health-disease according to health professionals. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 72, n. 6, p. 1609-1617, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0743>.
5. BERLINCK, M. T.; MAGTAZ, A. C.; TEIXEIRA, M. A Reforma Psiquiátrica Brasileira: perspectivas e problemas. **Rev. Latinoam. Psicopat. Fund.**, v. 11, n. 1, p. 21-27, 2008.
6. COSTA, J. C.; NITSCHKE, R. G.; THOLL, A. D.; HENCKEMAIER, L.; MICHELIN, S. R.; SILVA, A. P. M. Imaginário da promoção da saúde da família: olhar do familiar no cotidiano da Atenção Primária. **Cienc. Cuid. Saúde**, v. 16, n. 1, p. 83-90, jan.-mar. 2017.
7. CARDOSO, L. C. B.; et al. Mental health assistance in Primary Care: the perspective of professionals from the Family Health Strategy. **Rev. Bras. Enferm**, v. 75, n. Suppl. 3, e20190326, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0326>. Acesso em: 11 ago. 2024. Epub 26 nov. 2021. ISSN 1984-0446.
8. COELHO, N. A.; NASCIMENTO, J.; BARRETO, B. I.; REZENDE, L. C.; PENNA, C. M. M.; BRITO, M. J. M. A percepção dos profissionais sobre as ações de saúde mental na rede de atenção psicossocial em Belo Horizonte. **REME - Rev. Min. Enferm.**, v. 25, e-1416, 2021. DOI: 10.5935/1415-2762.20210064.
9. DRESCHER, A.; BOTH, J. E.; HILDEBRANDT, L. M.; et al. Concepções e intervenções em saúde mental na ótica de Profissionais da estratégia saúde da família. **Rev. Enferm. UFPE on line**, v. 10, n. 4, p. 3548-3559, 2016. DOI: 10.5205/reuol.9681-89824-1-ED.1004sup201606.
10. FILHO, J.; MARQUES, A.; SILVA, C.; NÓBREGA, R.; PINTO, A. Práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Estratégia Saúde da Família. **Nursing Edição Brasileira** [Internet]. 1º mar. 2020 [citado 11 ago. 2024]; v. 23, n. 262, p. 3638-3642. Disponível em: <https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/485>.
11. GIOVANELLA, L.; BOUSQUAT, E. M.; SCHENKMAN, S.; ALMEIDA, P. F.; SARDINHA, L. M. V.; VIEIRA, M. L. F. P. Cobertura da Estratégia Saúde da Família no Brasil: o que nos mostram as Pesquisas Nacionais de Saúde 2013 e 2019. **Ciênc. Saúde Colet.**, v. 26, supl. 1, p. 2543-2556, jun. 2021.

12. HOLMES, A.; CHANG, Y. P. Effect of mental health collaborative care models on primary care provider outcomes: an integrative review. **Fam. Pract.**, v. 39, n. 5, p. 964-970, 2022. DOI: 10.1093/fampra/cmac026.
13. HSIAO, C.-Y.; LU, H.-L.; TSAI, Y.-F. Fatores associados às percepções dos cuidadores familiares primários sobre a qualidade do cuidado centrado na família na prática de saúde mental. **J. Nurs.**, v. 51, p. 680-688, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1111/jnu.12526>.
14. LIMA MARTINS, Á. K.; ALVES E SOUZA, Â. M.; CUNHA VIEIRA, N. F.; NEYVA DA COSTA PINHEIRO, P.; BATISTA BRAGA, V. A. Práticas em saúde mental na estratégia saúde da família: um estudo exploratório. **Rev. Eletr. Cuidado Fundam**, v. 7, n. 1, p. 1905-1914, jan.-mar. 2015. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil.
15. MAIA DA SILVA, A. P.; PEREIRA COELHO, B.; SOUZA E SOUZA, L. P.; ALMEIDA E SILVA, K. M.; PEREIRA DA SILVA, E.; SANTOS PINTO, I. et al. Saúde mental no trabalho do Enfermeiro da Atenção Primária de um município no Brasil. **Rev. Cubana Enferm.**, v. 31, n. 1, p. 1-9, mar. 2015. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192015000100008&lng=es.
16. MARCOLINO, T.Q.; FANTINATTI, E.N.; GOZZI, A.P.N.F. Comunidade de prática e cuidado em saúde mental: uma revisão sistemática. **Trab. educ. saúde**, Rio de Janeiro, v.16, n.2, p.643-58, mai.-ago. 2018.
17. MILITÃO, L. de F.; et al. Usuários de substâncias psicoativas: desafios à assistência de enfermagem na Estratégia Saúde da Família. **Esc. Anna Nery**, v. 26, e20210429, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0429pt>. Acesso em: 11 ago. 2024. Epub 09 maio 2022. ISSN 2177-9465.
18. NASCIMENTO, M. G. G.; NADELETI, N. P.; NADELETI, S. C.; et al. O processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental da população atendida na ESF: uma análise reflexiva. **Rev. Eletr. Cuidado Fundam.**, v. 7, p. e2097, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19175/recom.v7i0.2097>.
19. NÓBREGA, M. P. S. S.; FERNANDES, C. S. N. N.; ZERBETTO, S. R.; SAMPAIO, F. M. C.; DUARTE, E.; CHAVES, S. C. S.; MOREIRA, W. C. Nurses' attitudes facing the family involvement in caring for people with mental disorder. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 73, supl. 1, p. 1-8, 2020.
20. NUNES, V. V.; FEITOSA, L. G. G. C.; FERNANDES, M. A.; ALMEIDA, C. A. P. L.; RAMOS, C. V. Saúde mental na atenção básica: atuação do enfermeiro na rede de atenção psicossocial. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 73, supl. 1, p. 1-7, 2020.
21. OLIVEIRA, E. C.; MEDEIROS, A. T.; TRAJANO, F. M. P.; CHAVES NETO, G.; ALMEIDA, S. A.; ALMEIDA, L. R. O cuidado em saúde mental no território: concepções de profissionais da atenção básica. **Esc. Anna Nery**, v. 21, n. 3, p. 1-7, 2017.
22. PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, n. n71, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
23. PEREIRA, R. M. P.; AMORIM, F. F.; GONDIM, M. F. N. A percepção e a prática dos profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre a Saúde Mental. **Interface (Botucatu)**, v. 24, supl. 1, e190664, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.190664>.
24. PETERS, M. D. J.; GODFREY, C.; MCINERNEY, P.; BALDINI, S. C.; KHALIL, H.; PARKER, D. Scoping reviews. In: AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Eds.). **Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual**. Australia: Joanna Briggs Institute, 2020.
25. RAYYAN – Intelligent Systematic Review [Internet]. **Rayyan.ai**. 2022. Disponível em: <https://www.rayyan.ai>. Acesso em: 17 mar. 2022.

26. ROTOLI, A.; et al. Mental health in Primary Care: challenges for the resoluteness of actions. **Esc. Anna Nery**, v. 23, n. 2, e20180303, 2019. Acesso em: 8 ago. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0303>.
27. SILVA, S. M.; DA SILVA, A. M.; SOUZA, A. R.; MOURA, A. D. A.; LIMA, G. G.; FEITOZA, A. R.. Estratégia saúde da família: ações no campo da saúde mental [Family health strategy: mental health care actions] [Estrategia salud de la familia: acciones en el área de salud mental]. **Rev. Enferm. UERJ**, Rio de Janeiro, v. 25, p. e16926, 2017. DOI: 10.12957/reuerj.2017.16926. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/16926>. Acesso em: 11 ago. 2024.
28. SOUZA, J. de; et al. Mental health in the Family Health Strategy as perceived by health professionals. **Rev. Bras. Enferm** [online]. 2017, v. 70, n. 5, p. 935-941. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0492>. Acesso em: 11 ago. 2024. ISSN 1984-0446.
29. STERLING, R. A. M.; GONÇALVES, L. F.; HAAS, P. Atenção à saúde mental na atenção primária de saúde: uma revisão sistemática. **RSD**, v. 10, n. 3, e43210313394, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i3.13394>. ISSN 2525-3409.
30. TAVARES, J. H.; SILVA, S. D.; PINHEIRO, E. P. F.; VASCONCELOS, J. S.; RODRIGUES, D. P.; OLIVEIRA, M. A. F. Saúde mental: representações sociais dos enfermeiros da estratégia saúde da família. **Rev. Eletr. Cuidado Fundam**, v. 15, e11984, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcf.v15.11984>. Acesso em: 11 de agosto de 2024.

TÓPICO 2 - FAMÍLIA E SAÚDE MENTAL NA APS

A Reforma Sanitária Brasileira, fortalecida sobretudo nas décadas de 1980 e 1990, representou um marco histórico na construção de um novo modelo de saúde, ancorado nos princípios democráticos da redemocratização do país. Inspirada em experiências internacionais e impulsionada pelos movimentos sociais e pela 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), essa reforma ampliou a concepção de saúde, deslocando-a de uma visão restrita à ausência de enfermidades para um processo complexo e determinado por condições sociais, econômicas, políticas e culturais. Esse entendimento foi consagrado na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentado na universalidade, integralidade e equidade (BRASIL, 1990; CAMPOS; MELO, 2022).

Até então, prevalecia um modelo médico-centrado, curativista e hospitalocêntrico, que negligenciava as dimensões comunitárias e familiares. Com o SUS, consolidou-se uma mudança paradigmática, priorizando práticas territoriais, interdisciplinares e coletivas, articuladas à promoção da saúde e à prevenção de agravos (OLIVEIRA et al., 2017; GOMES; GUTIÉRREZ; SORANZ, 2020). Nesse contexto, a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994 — posteriormente expandido e reformulado como Estratégia Saúde da Família (ESF) pela Portaria nº 648/GM de 2006 e reafirmada na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2011 e PNAB/2017) — constituiu-se como eixo central da atenção primária, consolidando a ESF como principal porta de

entrada do SUS e como espaço privilegiado de coordenação do cuidado (BRASIL, 2017; SILVA, 2019).

No campo da saúde mental, a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 3.088/2011, articulou a ESF às demais modalidades de atenção, reforçando sua função estratégica na detecção precoce, acompanhamento contínuo e articulação comunitária. Essa diretriz dialoga com os fundamentos da Reforma Psiquiátrica Brasileira, legitimada pela Lei nº 10.216/2001, que estabeleceu a substituição progressiva do modelo manicomial por uma rede territorializada, comunitária e de base psicossocial (BRASIL, 2001). As Conferências Nacionais de Saúde Mental, em diferentes edições, reforçaram a necessidade de consolidar práticas humanizadas, inclusivas e em defesa dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico e de seus familiares.

A integração entre família, APS e RAPS revela-se como eixo fundamental para a efetivação dos princípios da Reforma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária. Reconhecer a família como parte viva da rede de cuidado, fortalecer a responsabilização da APS na saúde mental e enfrentar os entraves estruturais, políticos e organizacionais que limitam essa atuação são movimentos indispensáveis para que o cuidado psicossocial se traduza, de fato, em produção de vida, autonomia e cidadania no território (FERREIRA et al., 2022).

Diante do exposto, alguns desses entraves anteriormente mencionados, estão relacionados a capacidade de resposta da APS à saúde mental. A avaliação de dados do PMAQ e de informações da Coordenação Nacional de Saúde Mental demonstra a existência de vazios assistenciais, desigualdade na oferta de serviços e descontinuidades importantes na integração entre APS e RAPS. O enfraquecimento de dispositivos estratégicos, como o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), a precarização do trabalho, o subfinanciamento e as recentes mudanças nas políticas públicas impactam diretamente a efetividade da atenção psicossocial no território. Observa-se, ainda, que em contextos de crise econômica e sanitária, como o vivenciado na pandemia, a APS perde potência como ordenadora da rede, justamente quando a demanda em saúde mental se intensifica, afetando de modo mais agudo as populações socialmente vulnerabilizadas (DIMENSTEIN, MACEDO E FONTENELE, 2022).

Ao articular esses achados com o debate anterior, torna-se evidente que a consolidação da atenção psicossocial no SUS depende não apenas de marcos legais e diretrizes normativas, mas da forma como o cuidado é efetivamente produzido no cotidiano dos serviços (MORAIS et al, 2021).

Dessa forma, a efetividade da atenção psicossocial no território passa, necessariamente, pelo reconhecimento da família como parte constitutiva da rede de cuidado. É no espaço doméstico e nas

relações cotidianas que se sustentam, negociam e, muitas vezes, se tensionam as estratégias terapêuticas construídas nos serviços, revelando que o cuidado extrapola o âmbito institucional e ganha concretude nas dinâmicas familiares. Assim, compreender a família como sujeito implicado no processo de cuidado — e não apenas como acompanhante do usuário — permite ampliar o olhar profissional para as condições reais de vida, para os vínculos, conflitos, afetos e arranjos que influenciam diretamente a adesão, a autonomia e a continuidade do tratamento (FERREIRA et al., 2022).

Nesse cenário, a família assume papel estruturante no cuidado. Para além de uma unidade biológica, deve ser reconhecida como uma construção social plural, atravessada por transformações históricas e culturais. Arranjos nucleares, monoparentais, recompostos, estendidos, homoafetivos, adotivos e aqueles formados por reprodução assistida expressam a diversidade contemporânea (PRADO, 2017; GIDDENS, 2020). Essa perspectiva plural, também reforçada nos manuais e diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), orienta os profissionais a compreenderem as especificidades de cada grupo familiar como condição essencial para o cuidado integral.

Diante do exposto, e das múltiplas formas legítimas e plurais formas de organização familiar, estamos diante de um “novo normal”, isto é, a família antes considerada “normal”- nuclear, é apenas uma das possibilidades de organização familiar (WALSH, 2016).

No âmbito da saúde mental, a família pode desempenhar papéis múltiplos e ambivalentes. Pesquisas apontam diferentes modos de cuidado: o cuidado de vigilância, caracterizado pelo acompanhamento constante e prevenção de crises, mas que pode gerar sobrecarga; o cuidado parental, centrado no apoio e orientação para atividades cotidianas; o cuidado superprotetor, que restringe a autonomia em nome da segurança; e o cuidado permissivo, que, pela ausência de supervisão, compromete o manejo do adoecimento (BAUMRIND, 1967; MENEZES; LOPES, 2019).

Além disso, os familiares são, muitas vezes, os primeiros a identificar sinais de sofrimento, o que lhes confere papel central no reconhecimento precoce do adoecimento e na busca por atendimento (GONÇALVES; SOUZA, 2021). Os familiares não apenas acompanham o tratamento, mas participam ativamente da construção de estratégias de enfrentamento, reorganizando rotinas, afetos e projetos (FERREIRA et al., 2022).

Entretanto, essa corresponsabilização também expõe contradições. A sobrecarga emocional, social e financeira pode fragilizar o núcleo familiar, especialmente quando não há suporte adequado da rede pública. O estigma social associado ao sofrimento psíquico e a escassez de recursos em determinadas regiões do país tornam ainda mais desafiador o exercício do cuidado. Por isso, é

imprescindível que as políticas públicas assegurem apoio contínuo às famílias, fortalecendo práticas de educação em saúde, grupos de apoio e acompanhamento multiprofissional (DIMENSTEIN, MACEDO E FONTENELE, 2022).

Em síntese, a literatura, os marcos normativos e os manuais do Ministério da Saúde convergem para a compreensão de que a família é elemento central na consolidação da atenção psicossocial no âmbito do SUS. Ao mesmo tempo em que oferece suporte afetivo e contribui para a adesão terapêutica, sua participação ativa nos planos de cuidado garante maior efetividade, continuidade e humanização da atenção. Assim, a integração entre família, serviços comunitários e rede de atenção constitui não apenas uma estratégia assistencial, mas também um compromisso ético e político com a defesa da vida e da cidadania.

TÓPICO 3 - REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO

Este capítulo do referencial teórico estabelece a fundação necessária para a pesquisa, incluindo princípios e conceitos essenciais. Nele, são detalhadas as etapas, lógicas e coerências que sustentam e desenvolvem a tese. O referencial deve alinhar-se com a abordagem do problema e o raciocínio empregado, de modo que sustente adequadamente a análise dos resultados. Além disso, atua como um guia para as reflexões do pesquisador, proporcionando uma estrutura que orienta o desenvolvimento da pesquisa e assegura a profundidade e consistência da análise. Para isso, será organizado em três seções: 1) Aspectos biográficos de Alfred Schutz; 2) Concepções teórico filosóficas na sociologia fenomenológica de Alfred Schutz; 3) Aplicações no campo da pesquisa em saúde/enfermagem.

1) ASPECTOS BIOGRÁFICOS DE ALFRED SCHUTZ

Antes de explanar sobre o referencial teórico-metodológico de Alfred Schutz, considera-se importante trazer aspectos biográficos desse pensador.

Alfred Schutz nasceu em Viena em 1899. Aos 18 anos foi enviado para o campo de batalha na fronteira italiana. O retorno doloroso a um império em crise forçou-o a tomar decisões pragmáticas. Optou por estudar Direito, concluindo o curso no final de 1921, e iniciou um emprego como consultor em uma empresa bancária. Essas escolhas práticas substituíram seus projetos anteriores, mais incertos, de se tornar maestro de orquestra ou escritor (SOUZA, 2012).

A carreira de Alfred Schutz como consultor econômico se firmou significativamente. Formado em Direito Internacional pela universidade, ele elaborou relatórios sobre a situação político-

econômica da Europa Central e colaborou com o jornal *Neue Freie Presse* na seção econômica. Em 1929, foi contratado pelo banco privado Reitler, onde suas funções o levaram a viajar frequentemente pela Europa, solidificando sua reputação como analista econômico (SCHUTZ, 2018).

Entretanto, esse avanço profissional ocorreu em meio ao crescimento do nazismo e ao antissemitismo, além da crise política e econômica que ameaçava toda a região germânica. Esses fatores trouxeram desafios consideráveis que refletiam o clima conturbado da época. Motivado por seu interesse intelectual, Schutz se envolveu em grupos de estudo em Viena. Um desses grupos era o *Geistkreis*, fundado por Friedrich von Hayek, onde os participantes discutiam temas fora de sua área de conhecimento prévio—por exemplo, um médico poderia falar sobre ópera. Outro grupo importante era o *Mises Seminar*, focado nas questões teóricas e metodológicas das ciências sociais. Nesse ambiente intelectual ativo, Schutz proferiu cinco conferências entre 1928 e 1930 (SOUZA, 2012).

Durante uma participação discreta na vida intelectual vienense entre 1924 e 1927, Alfred Schutz escreveu sua primeira obra significativa intitulada *Theorie der Lebensformen*, embora esta só fosse publicada postumamente em 1981 (SCHUTZ, 2018).

Ao longo dos seus anos acadêmicos, Schutz dedicou-se intensamente às obras de Max Weber e Edmund Husserl, cujas ideias formaram os pilares fundamentais dos seus escritos. Em 1932 ele lançou seu único livro durante sua vida chamado “*Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt*” (A fenomenologia do mundo social). Esta obra reúne os conceitos centrais utilizados por Schutz dentro da sociologia fenomenológica. Este trabalho reúne a estrutura conceitual essencial utilizada por Schutz em sua abordagem de sociologia fenomenológica. Cabe ressaltar que a preocupação central de Alfred Schutz em *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt* é descrever os processos sociais envolvidos em na transição da duração ao mundo espaço temporal e na constituição dos contextos de experiência e de ação. A transição da duração ao mundo espaço temporal refere-se à conformação da experiência individual, que, embora seja pessoal, é fundamentalmente social, pois é tecida cooperativamente no processo social. Por outro lado, a conformação dos contextos de experiência constitui a base da ação social, representando o espaço intersubjetivo onde as condutas são reguladas e coordenadas (SOUZA, 2012).

Em face à iminente ocupação nazista da Áustria em 1938, Alfred Schutz imigrou para Paris no ano seguinte, buscando maior segurança, ele se exilou nos Estados Unidos com sua família estabelecendo-se em Nova York-. Durante essa nova fase, ele continuou atuando no setor financeiro enquanto lecionava na *University in Exile* — uma instituição criada por Alvin Johnson para abrigar intelectuais europeus forçados pela guerra (SCHUTZ, 2018).

Ao longo de sua vida, Alfred Schutz publicou um total de trinta textos, predominantemente em inglês, alguns também nas línguas francesa, alemã e espanhol. Após sua morte, três volumes dos “*Collected Papers*” foram publicados entre 1962 e 1966, compilando grande parte dos seus escritos (SCHUTZ, 2018). Cabe salientar que Schutz nos anos de 1932 construiu a obra “A construção significativa da realidade social” o que lhe permitiu conhecer pessoalmente Husserl e ambos comunicavam-se via cartas até o óbito de Husserl (SOUZA, 2012).

Na década de 1950, a produção intelectual de Alfred Schutz cresceu consideravelmente. Em 1957, no entanto, sua saúde começou a deteriorar-se. Nos seus últimos esforços, Schutz dedicou-se à criação de um arquivo sobre Edmund Husserl na New School e à organização e compilação de seus diversos trabalhos. Alfred Schutz faleceu em 20 de maio de 1959, em Nova Iorque (SOUZA, 2012).

2) CONCEPÇÕES TEÓRICO-FILOSÓFICAS DA SOCIOLOGIA FENOMENOLÓGICA DE ALFRED SCHUTZ

Entre o final do século XIX e o início do século XX, a filosofia e as ciências sociais passaram por transformações significativas que impactaram profundamente a compreensão do ser humano e da sociedade. As três correntes principais desse período são a Fenomenologia de Edmund Husserl, o Intuicionismo de Henri Bergson e a Sociologia Compreensiva de Max Weber. Cada uma delas trouxe novas perspectivas e métodos de análise para melhor compreender a realidade e a experiência humana (OLTRAMARI; NAUJORKS, 2022).

Alfred Schutz, enquanto sociólogo, utilizou-se dos conhecimentos da área da sociologia - com destaque aos estudos da sociologia compreensiva de Max Weber (1864-1920) e utilizou-se de conceitos elementares da fenomenologia de Edmund Husserl (1859-1938) como arcabouço para desenvolvimento de sua sociologia fenomenológica (SCHNEIDER *et al*, 2017).

Dessa maneira, desticarei em seguida alguns elementos do referencial de Weber e Husserl para a constituição da fenomenologia social.

Weber alicerça sua sociologia compreensiva a partir da teoria da Ação Social (ação individual e a interdependência dos indivíduos) com enfoque nos conceitos de ação (como expressão da motivação individual) e relação social (interação dos sujeitos com compartilhamento de objetivos) (SCHUTZ, 2003).

Para Weber, a análise da ação social envolve compreender o significado que o agente atribui à sua própria ação e como isso se relaciona com o comportamento dos outros. Schutz desenvolveu e

expandiu esse conceito, enfatizando a importância de entender a ação social a partir da perspectiva dos próprios indivíduos e como esses significados são moldados por suas experiências e contextos (SCHUTZ, 2018).

Weber define ação social como qualquer comportamento humano que tenha um significado subjetivo para o indivíduo e que seja orientado no relacionamento com outras pessoas. Isso implica que a ação social é influenciada pelas expectativas e pela interação com outros indivíduos. A interdependência entre indivíduos é, portanto, um aspecto central de sua análise, refletindo a ideia de que o comportamento de uma pessoa pode ser melhor entendido dentro de um determinado contexto (ALVES, 2021).

Para Weber, a relação social é um componente essencial da vida social. A interação social é mais do que um simples encontro de pessoas, isto é, envolve um compartilhamento de objetivos e significados. Weber distingue quatro tipos ideais de ação social, que são formas pelas quais os indivíduos podem se relacionar e agir dentro da sociedade, como: a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores, a ação afetiva e a ação tradicional (WEBER, 2004).

Em relação a ação racional com relação a fins, essa ação é orientada por objetivos específicos e busca a eficiência na realização desses objetivos. Os indivíduos escolhem os meios mais adequados para atingir seus fins, levando em consideração a eficiência e a racionalidade, isto é, uma empresa que planeja suas ações a fim de expandir suas margens de lucro. Já no que tange a ação racional com relação a valores, a escolha dos meios é guiada por um sistema de valores ou crenças. Os indivíduos agem de acordo com princípios éticos ou morais, independentemente da eficácia dos meios para alcançar um resultado específico. Nesse aspecto, um exemplo a ser citado é que uma pessoa pode optar por não trabalhar em uma empresa que não compartilha seus valores éticos, mesmo que isso signifique ganhar menos dinheiro. Na ação afetiva é movida por sentimentos e emoções. Os indivíduos agem com base em seus estados emocionais, e a racionalidade é secundária. Um exemplo desse aspecto a ser citado é agir por impulso com base nas emoções diante de determinada situação. E por fim a ação tradicional é guiada por hábitos e rotinas estabelecidas ao longo do tempo. Os indivíduos agem de acordo com o que sempre foi feito, sem questionar ou refletir profundamente sobre a razão por trás dessas práticas (WEBER, 2004).

Diante do exposto, para Weber, esses tipos ideais não são categorias rígidas ou mutuamente exclusivas, mas sim modelos teóricos que ajudam a entender e analisar a complexidade das ações humanas na sociedade. Cada tipo de ação social tem suas próprias lógicas e motivações, e compreender esses diferentes tipos pode oferecer uma visão mais profunda sobre como as pessoas

interagem e formam a vida social. Cabe salientar que Alfred Schutz ao desenvolver sua Sociologia Fenomenológica, abordou conceitos fundamentais da obra de Max Weber com o objetivo de expandir e aprofundar a compreensão da experiência social, mas sem o intuito de refutá-los. Em vez disso, Schutz se concentrou em explorar e aplicar esses conceitos para construir uma abordagem fenomenológica que integrasse a perspectiva subjetiva e intersubjetiva com a análise sociológica (TISSOT; NASI; BARROSO, 2023).

Nesse sentido, toda a conduta que é prevista, ou seja, baseada em um projeto pré-concebido, é descrita como uma ação. Essa ação pode se manifestar de duas formas: aberta, através de movimentos corporais visíveis, ou encoberta, por meio de um desempenho mental e reflexivo. A intenção de uma ação pode ser a de se concretizar ou não, dependendo de sua realização efetiva e do contexto em que é realizada. Ações que possuem um significado atribuído por definições pessoais são caracterizadas como comportamento motivado. Com base no exposto, Schutz explora o caráter da motivação por meio da teoria da motivação (TISSOT; NASI; BARROSO, 2023).

Deste modo, Alfred Schutz defende que toda ação humana é baseada em uma intenção, ou seja, os indivíduos agem com base em motivos que visam alcançar metas futuras, os quais ele denomina como "*motivos com a finalidade de*" ou "*motivos para*". Esses motivos orientam a ação em direção a objetivos que ainda não foram alcançados, refletindo um planejamento e uma intencionalidade voltados para o futuro. Apesar de os indivíduos possuírem razões para suas ações, ligadas às experiências passadas e à personalidade desenvolvida ao longo de suas vidas, Schutz os classifica como "*motivos porque*". Esses são os fatores que influenciam o comportamento com base em um entendimento retrospectivo das razões subjacentes (SCHUTZ, 2018).

Enquanto os "*motivos para*" estão relacionados ao planejamento e à busca de objetivos futuros, os "*motivos porque*" referem-se a influências passadas e à construção da personalidade que moldam as ações. Schutz argumenta que, ao agir, o indivíduo pode não estar totalmente consciente de seus "*motivos porque*" no momento da ação. No entanto, é possível compreender esses motivos de forma retrospectiva, após a ação ser realizada. Essa compreensão retrospectiva permite que o indivíduo faça sentido das suas ações, ligando-as a fatores históricos e pessoais que influenciaram seu comportamento (SCHUTZ, 2018).

A identificação dos "*motivos para*" e "*porque*" da ação de um indivíduo permite a descrição da tipificação da ação, ou seja, de um esquema conceitual que reúne as vivências conscientes de uma pessoa ou de um grupo no mundo social (SCHUTZ, 2012; JESUS et al, 2013). Isso corresponde a uma idealização, no sentido de ideia, não de uma pessoa em particular, mas de um tipo social

constituído pelo estoque de conhecimento que se tem sobre o mundo e que determina esquemas interpretativos do mundo social (MACHINESKI, SCHNEIDER, CAMATTA, 2013).

A Teoria da Motivação de Schutz oferece uma perspectiva adicional que se integra à tipificação da ação social de Weber, fornecendo uma compreensão mais profunda de como as intenções futuras e as influências passadas interagem para moldar o comportamento humano. Schutz destaca que, embora os indivíduos possam não estar totalmente conscientes dos motivos subjacentes durante a ação, a reflexão retrospectiva permite uma compreensão mais completa das razões que orientaram suas ações (TISSOT; NASI; BARROSO, 2023).

Neste sentido, Schneider et al. (2017) argumentam que, ao examinar as ações sociais, a sociologia fenomenológica permite a visualização de uma estrutura comum de significados atribuídos a ações específicas. Isso significa que a tipificação das ações emergem a partir das experiências vivenciadas e das construções de significado que os indivíduos elaboram em seu cotidiano. Assim, a abordagem fenomenológica busca entender como os significados são construídos e compartilhados dentro de um determinado contexto social, refletindo como os indivíduos interpretam suas ações e as ações dos outros.

Penso que a relação entre a abordagem fenomenológica e a tipificação das ações sociais são fundamentais a fim de compreender a dinâmica das ações humanas. A tipificação emerge a partir da interpretação dos significados atribuídos às ações, que são moldados pelas experiências individuais e pelas práticas sociais compartilhadas. A análise fenomenológica proporciona uma base para entender essas experiências e significados, oferecendo uma visão rica e detalhada das razões subjacentes que orientam a conduta humana.

Na ótica de Alfred Schutz, a análise das ações sociais é profundamente enraizada na experiência cotidiana e nas interações sociais que os indivíduos mantêm em seu mundo diário. Schutz enfatiza que vivemos em um mundo cotidiano em que nossas ações são guiadas por intenções e objetivos que são moldados por nossas experiências passadas e pelo contexto social em que estamos inseridos. Para realizar uma ação social, é fundamental engajar-se em relações com outros indivíduos, compartilhando experiências e perspectivas sobre diversos assuntos (SCHUTZ, 2018).

Esse compartilhamento de experiências é uma relação social que pode ser direta ou indireta. Para realizar uma ação social, os indivíduos frequentemente interagem e compartilham suas experiências com outros. Esse compartilhamento pode ocorrer de forma direta, por meio de conversas e interações face a face, ou de forma indireta, através de referências culturais, normas sociais e práticas estabelecidas. Essas interações permitem que os indivíduos negociem significados, alinhem

suas intenções e construam uma compreensão comum sobre o que está sendo realizado. Em relação a interação social direta, “eu e tu” compartilhamos a mesma dimensão de tempo e de espaço, já no que tange a relação social indireta, somente há o compartilhamento da mesma dimensão de tempo e não a mesma dimensão de espaço, sendo assim, uma relação de anonimato entre contemporâneos (MACHINESKI, SCHNEIDER, CAMATTA, 2013).

Na ótica de Schutz, a vida cotidiana é um campo dinâmico onde as ações sociais são moldadas por intenções e pela interação contínua com outros indivíduos. O compartilhamento de experiências e perspectivas é crucial para a realização e a compreensão das ações, seja através de relações sociais diretas ou indiretas. Essa abordagem oferece uma visão profunda da forma como a vida cotidiana e as interações sociais influenciam a motivação e a execução das ações humanas, enriquecendo nossa compreensão da sociologia e da teoria social (SCHUTZ, 2018).

Além da influência de Max Weber, Alfred Schutz também se apropriou do pensamento fenomenológico de Edmund Husserl para fundamentar sua abordagem sociológica. A fenomenologia de Husserl surgiu em um contexto de profundas transformações sociais, culturais e políticas, refletindo um período de grande difusão e desenvolvimento das ciências humanas e sociais. Esse contexto foi crucial para o surgimento e a consolidação das ideias fenomenológicas, que buscavam uma compreensão mais precisa e subjetiva da experiência humana (OLTRAMARI; NAUJORKS, 2022).

A incorporação da fenomenologia de Husserl por Schutz permitiu uma análise mais profunda da experiência vivida e das motivações subjacentes às ações sociais. Em um contexto de transformação social e intelectual, a abordagem fenomenológica ofereceu ferramentas para descrever e compreender a realidade nua e crua das ações humanas, destacando a importância de se atentar às perspectivas subjetivas e às interpretações individuais (SCHUTZ, 2018).

Na fenomenologia de Husserl, os conceitos de consciência, intencionalidade, atitude natural, redução fenomenológica, redução eidética e essência são fundamentais nesse referencial (SCHUTZ; LUCKMANN, 2023).

Esses conceitos fundamentais da fenomenologia de Husserl fornecem uma base para a análise profunda da experiência subjetiva e dos fenômenos. A consciência e a intencionalidade explicam como os indivíduos experienciam e direcionam sua atenção ao mundo. A atitude natural é suspensa através da redução fenomenológica para focar na experiência pura, enquanto a redução eidética busca identificar as essências universais dos fenômenos. Juntos, esses conceitos permitem uma compreensão detalhada e precisa da estrutura da experiência e da realidade vivida, fundamental para

a aplicação da fenomenologia na pesquisa social e na análise da ação humana (SCHUTZ; LUCKMANN, 2023).

Desse modo, Schutz apropriou-se também de conceitos básicos da fenomenologia de Husserl como: intencionalidade, intersubjetividade e mundo-vida, tendo como eixo a volta ao núcleo essencial (SCHNEIDER *et al*, 2017; CAPALBO 1998).

No que tange o conceito de intencionalidade, Alfred Schütz mantém uma continuidade com o pensamento de Edmund Husserl. Husserl define a intencionalidade como a característica da consciência de sempre estar direcionada a um objeto ou conteúdo, seja este um objeto físico, uma ideia ou uma emoção. Em outras palavras, a consciência é sempre "intencional" porque está sempre voltada para algo além de si mesma. Schutz adotou essa ideia para explicar como as ações e intenções dos indivíduos são dirigidas para o mundo e para objetivos específicos. Para ele, a intencionalidade é o movimento da consciência que se estende para o mundo externo, buscando dar clareza e significado às coisas e experiências. Isso significa que, ao agir, os indivíduos não apenas reagem a estímulos externos, mas estão constantemente buscando compreender e transformar sua realidade de acordo com seus propósitos e objetivos (SCHUTZ; LUCKMANN, 2023).

Em relação ao conceito de intersubjetividade, segundo Schutz, refere-se ao compartilhamento e à comunicação entre consciências individuais. Esse conceito está relacionado à forma como os indivíduos se comunicam e interagem dentro da realidade cotidiana. É a base das relações sociais e da troca de significados entre os sujeitos. Schutz entendeu a intersubjetividade como fundamental para a construção de um mundo comum, onde os indivíduos trocam e negociam significados e experiências. Essa comunicação é baseada na reciprocidade e nas interações sociais, permitindo que os indivíduos compreendam e se ajustem às ações e intenções dos outros. A intersubjetividade é essencial para a formação de uma realidade social compartilhada e para a coordenação das ações dentro do contexto social (SCHUTZ, 2018).

De acordo com Nasi (2009) e Capalbo (1998), a intersubjetividade é vista como a base das relações de troca entre os sujeitos humanos. Estas relações são fundamentais para entender como os indivíduos se comunicam e colaboram dentro da realidade cotidiana, isto é, o mundo da vida.

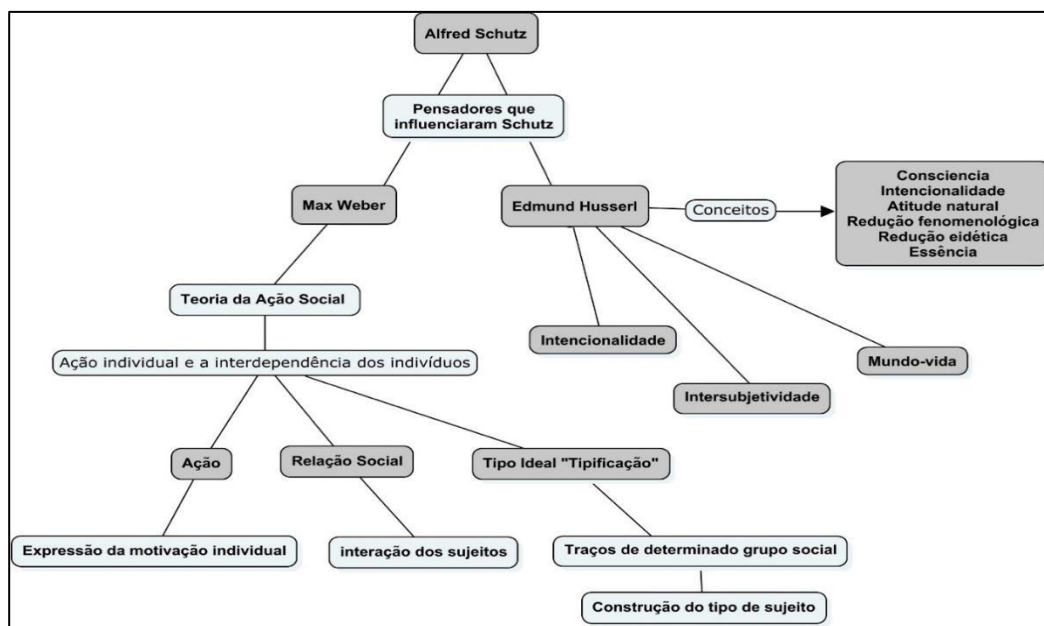
O mundo da vida (*Lebenswelt*), para Schutz, é o mundo cotidiano em que nossas ações e intenções são vivenciadas e refletidas. É o cenário da vida diária onde os indivíduos interagem e experimentam fenômenos de forma intersubjetiva (SCHUTZ; LUCKMANN, 2023).

Schutz (2012) descreve o mundo da vida como o contexto em que o significado das ações é construído e onde a realidade social se manifesta. Esse mundo é intersubjetivo porque os seres

humanos estão constantemente envolvidos em relações sociais, e essas relações moldam suas experiências e a forma como interpretam o mundo.

Os conceitos supracitados são centrais para a compreensão da sociologia fenomenológica de Schutz e ajudam a explicar como as ações e intenções dos indivíduos estão entrelaçadas com suas experiências e relações sociais, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Esquema dos principais conceitos de Alfred Schutz.



Fonte: Alfred Schutz (2003). Uso do Software Cmap Tools.

Em suma, a sociologia fenomenológica de Alfred Schutz ao trazer à tona as vivências e interpretações individuais, as relações sociais estabelecidas no mundo da vida, e a rede de motivações e intencionalidades, valoriza a dimensão intersubjetiva do cuidado, enfatizando a importância das relações sociais e das experiências cotidianas na compreensão e promoção da saúde mental. Assim, as pesquisas fenomenológicas em saúde mental têm contribuído para uma visão mais profunda e integrada ao bem-estar psíquico, explorando as potencialidades e desafios do ser humano em seu contexto de vida. De acordo com o exposto, estrutura-se o tópico a seguir.

3) APLICAÇÃO NO CAMPO DA PESQUISA EM SAÚDE/ENFERMAGEM

A investigação fenomenológica busca captar a essência das experiências vividas pelos indivíduos, focando em como eles percebem e interpretam o mundo ao seu redor. No campo da saúde, essa abordagem oferece uma alternativa valiosa para explorar a complexidade das experiências

relacionadas ao processo saúde-doença. Em vez de se concentrar apenas em dados quantitativos ou diagnósticos, a pesquisa fenomenológica investiga as vivências subjetivas dos pacientes, profissionais de saúde e outros envolvidos no processo de cuidado (SCHNEIDER *et al*, 2017).

Uma investigação fenomenológica no campo da saúde visa entender as percepções e perspectivas dos indivíduos sobre seu estado de saúde, suas experiências de doença e os impactos do tratamento. Isso inclui explorar como os pacientes vivenciam sintomas, como interpretam as informações recebidas dos profissionais de saúde e como essas interpretações influenciam sua adesão ao tratamento e seu bem-estar geral. A pesquisa fenomenológica se concentra em captar a experiência subjetiva, considerando como as pessoas fazem sentido de suas condições e como essas experiências moldam sua visão sobre o cuidado e a recuperação (TISSOT; NASI; BARROSO, 2023).

A fenomenologia social de Alfred Schutz fornece uma base teórica rica para o desenvolvimento da prática e da pesquisa em Enfermagem, particularmente no que diz respeito ao cuidado e à interação entre profissionais de saúde e pacientes. Essa abordagem oferece uma compreensão profunda das experiências subjetivas e das interações sociais, fundamentais para uma prática de Enfermagem (SCHUTZ, 2018).

Na prática de Enfermagem, o ato de cuidar é entendido como uma interação complexa entre o enfermeiro e o paciente, onde ambas as partes são sujeitos ativos no processo. Essa interação ocorre dentro de um ambiente e contexto social que influenciam e moldam as experiências de saúde e doença (BARBOSA *et al*, 2023).

Na Enfermagem, a dimensão intersubjetiva do cuidado é crucial. A fenomenologia social de Schutz valoriza a relação entre enfermeiro e paciente como a mais originária das relações humanas, baseando-se na compreensão mútua e na comunicação compartilhada. O cuidado é visto não apenas como um conjunto de ações técnicas, mas como um processo que envolve uma interação profunda e significativa entre o profissional de saúde e o paciente (TISSOT; NASI; BARROSO, 2023).

O cuidado profissional estabelece uma relação social diferenciada entre o profissional e o paciente. Essa relação não é apenas uma interação casual, mas uma interação formal e estruturada que é regida por normas e práticas específicas da profissão (BESSA *et al*, 2023).

Nesse sentido, um dos conceitos de Schutz, ao praticar o cuidado promove-se a interação social com o outro e deixá-lo expor suas vivências e experiências prévias, valoriza a interação entre ambos e auxilia o enfermeiro a estruturar um plano de cuidados, isto é, se faz necessário conhecer o mundo da vida daquele paciente para que o plano de cuidados instituído faça sentido diante da realidade vivenciada pelo paciente (SCHUTZ, 2018).

O cuidado profissional é uma prática complexa que vai além do simples atendimento técnico. Ele é caracterizado por uma relação social específica entre o profissional e o paciente, que é informada por conhecimentos técnico-científicos, intersubjetividade, e a situação biográfica do profissional. Esse cuidado não só abrange a aplicação de conhecimentos e técnicas especializadas, mas também se baseia na capacidade de entender e se conectar com os pacientes de maneira empática e contextualizada a fim de compreender o mundo da vida na qual o paciente está inserido. Ao integrar essas dimensões, o cuidado profissional visa proporcionar uma assistência holística e humanizada (TISSOT; NASI; BARROSO, 2023).

O enfermeiro ao considerar o mundo da vida dos pacientes, podem ter uma visão mais holística e integrada das suas necessidades e desafios. Isso pode incluir entender como os pacientes lidam com a doença em suas rotinas diárias, como a condição de saúde afeta suas relações sociais e atividades, e como o cuidado pode ser adaptado para se integrar melhor em seu contexto de vida (BESSA et al, 2023; LOPES; TOLEDO, 2020).

Em suma, acredito que o cuidado é a base central do ato de cuidar do outro. Essencialmente o enfermeiro carrega consigo um arsenal de vivências e experiências, através do seu estoque de conhecimento à mão, ao acolher um paciente portador de sofrimento psíquico e suas famílias, ao interagir face a face, abre um universo de possibilidades ao entender a realidade vivenciada por aquele paciente e suas famílias. O enfermeiro, ao utilizar seu arsenal de vivências, experiências e conhecimentos, é capaz de oferecer um cuidado que é sensível às realidades e necessidades individuais dos pacientes que faça sentido à realidade cotidiana por eles vivenciada.

5) MÉTODO

Para desenvolver este estudo foi utilizada a seguinte trajetória metodológica: caracterização do estudo, campo de estudo, participantes, coleta de dados, análise de dados e considerações quanto aos aspectos éticos da pesquisa.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo foi um recorte de informações originadas do projeto guarda-chuva intitulado “*Ações de enfermagem voltadas para a saúde mental na Atenção Básica*” (NASI et al., 2018). Esse projeto maior teve por objetivo compreender o significado das ações de enfermagem voltadas para a saúde mental na APS, na perspectiva dos enfermeiros, usuários e familiares atendidos nas Unidades de Saúde (US) da Zona Norte do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como base o referencial teórico-filosófico da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz (SCHUTZ, 2018).

A pesquisa qualitativa tem como característica a representação das opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo. Assim, podem-se representar os significados dados aos fatos da vida real pelas pessoas que os vivenciam e não aos do pesquisador (YIN, 2018). Ela é adequada para pesquisas que buscam “opiniões, atitudes e crenças de uma população” (GIL, 2021).

Conduz-se uma pesquisa qualitativa quando uma questão precisa ser explorada, identificando variáveis que não podem ser medidas facilmente, ou para escutar vozes silenciadas. Também quando se deseja dar poder aos indivíduos para compartilharem suas histórias, ouvir suas vozes e minimizar relações de poder (CRESWELL, 2018).

Nesse contexto, a pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo, sendo uma atividade situada que localiza o observador nesse mundo. Cabe ressaltar, que a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista e interpretativa para o mundo, pois o pesquisador estuda as coisas em seus cenários naturais, tentando entender e/ou interpretar os fenômenos por meio dos significados que as pessoas conferem a eles (DENZIN; LINCOLN, 2018).

Esse tipo de pesquisa permite uma aproximação do sujeito de estudo, levando à busca pela compreensão de suas experiências vividas. Nesse sentido, o pesquisador tem a oportunidade de realizar um aprofundamento nos estudos e dados.

Assim, ressalto a pesquisa fenomenológica, enquanto método de pesquisa, que visa à descrição da experiência vivida e os significados atribuídos a ela, dirigindo-se para o sentido que os sujeitos que a vivenciam como fenômeno (SCHNEIDER et al., 2017). Então, a sociologia fenomenológica de Alfred Schutz tem um delineamento qualitativo por entender que ele se mostra adequada para apreender a realidade que pretendo.

5.2 CAMPO DE ESTUDO

O presente estudo foi realizado na APS, em US vinculadas à Coordenadoria de Saúde Norte (CS-NORTE), situadas na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

As entrevistas foram realizadas com enfermeiros e familiares nas unidades nas Unidades de Saúde: US Nova Brasília, US Santo Agostinho, US Santa Fé, US Jenor Jarros, US Beco dos Coqueiros, US Sarandi e US São Borja.

5.3 PARTICIPANTES

Os participantes do estudo foram os enfermeiros das US, bem como familiares de pessoas portadoras de sofrimento psíquico, residente nas áreas de abrangência dessas unidades.

Quanto aos *critérios de inclusão do estudo*: em relação aos enfermeiros, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: a) fazer parte do quadro funcional do serviço; b) estar atuando no serviço há seis meses ou mais. Foram incluídos familiares com os seguintes critérios: a) ser maior de 18 anos; b) morar na mesma casa que o usuário; c) acompanhar ou ter acompanhado o usuário na terapêutica em saúde mental junto à US; d) estar em condições clínicas que permitam a compreensão dos objetivos da pesquisa.

Os *critérios de exclusão* adotados tiveram como base os enfermeiros que: a) estejam em férias ou licença saúde; e familiares que: a) que optassem por não concluir a entrevista após seu início; c) familiares que apresentassem vínculo muito recente com o usuário, dificultando relatar a experiência de cuidado.

Essa escolha foi realizada de forma intencional, mediante a seleção deliberada de enfermeiros e familiares que possam ter opiniões diferentes em relação ao tema de estudo (YIN, 2017). Assim, mostrou-se importante a escolha de enfermeiros e familiares que apresentaram diferentes perspectivas sobre o problema retratado, a fim de obter possibilidades máximas de amostragem intencional (CRESWELL, 2018).

O número de participantes na pesquisa qualitativa pode variar conforme as necessidades identificadas no decorrer da pesquisa de acordo com os resultados obtidos ao longo da mesma (FLICK, 2021).

Assim, participaram 12 enfermeiros das US e sete familiares de usuários em sofrimento psíquico pertencentes a essas unidades, conforme indicação dos profissionais de saúde.

Contudo, cabe destacar que foi considerado o princípio da saturação de dados para o encerramento de entrevistas, ou seja, a partir da identificação da repetição de informações nas falas dos participantes (MINAYO, 2020), não havendo novas atribuições com a inserção de novos participantes (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2018).

O encerramento da realização de novas entrevistas ocorreu quando o pesquisador, mediante análise preliminar de cada uma delas, observou o não aparecimento de conteúdo substancialmente novo. Desta maneira, o encerramento da realização de novas entrevistas não significa a explicitação total do fenômeno, mas sim a revelação de algumas de suas facetas.

5.4 APROXIMAÇÃO E AMBIENTAÇÃO COM O CAMPO DE PESQUISA

À luz da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz, a etapa de ambientação no campo empírico foi compreendida como um movimento intencional de aproximação ao mundo-vida dos participantes, condição necessária para que a compreensão das vivências pudesse emergir a partir dos significados produzidos no cotidiano. Assim, antes da realização das entrevistas fenomenológicas, busquei inserir-me progressivamente no cenário das Unidades de Saúde do Eixo Norte, participando das reuniões de equipe, momento em que apresentei o projeto de pesquisa, esclareci seus objetivos e convidei os enfermeiros que atendiam aos critérios de inclusão a participarem do estudo.

Essa inserção não se restringiu a encontros formais. Constituiu-se na vivência do cotidiano das unidades, na convivência com os profissionais em suas rotinas de trabalho, na articulação com os Agentes Comunitários de Saúde e no acompanhamento de visitas domiciliares, possibilitando um contato direto com o contexto concreto em que se produzem as ações de cuidado em saúde mental na Atenção Primária. Paralelamente, realizei a busca ativa de familiares que aguardavam atendimento nas unidades, momento em que, mediante diálogo sensível e respeitoso, apresentava a pesquisa e verificava a possibilidade de participação.

Esse percurso favoreceu que eu me tornasse uma presença conhecida no cenário, não como alguém estranho ao contexto, mas como pesquisadora comprometida em compreender, de modo rigoroso, as experiências ali vividas. Tal movimento dialoga com o pressuposto schutziano de que a compreensão do outro exige a imersão em seu mundo social, reconhecendo os sistemas de relevância que orientam suas ações, suas motivações e suas interpretações da realidade cotidiana.

Entretanto, o processo de coleta de dados foi atravessado por importantes desafios contextuais. A pandemia de COVID-19 implicou restrições de acesso às unidades, redução de atendimentos presenciais e fechamento temporário de serviços. Posteriormente, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul provocaram o deslocamento de famílias, interdição de unidades de saúde e a realocação de enfermeiros e demais membros das equipes, impactando diretamente a continuidade do acompanhamento no território. Esses acontecimentos exigiram constante replanejamento da pesquisa, flexibilidade metodológica e sensibilidade para respeitar o tempo e as condições vividas pelos participantes.

Dessa forma, a ambientação no campo não se configurou como uma etapa meramente preparatória, mas como parte constitutiva do próprio caminho metodológico, permitindo a construção de vínculo, confiança e empatia — elementos indispensáveis para a realização da entrevista

fenomenológica e para a apreensão compreensiva das experiências no mundo-vida dos enfermeiros e familiares participantes do estudo.

5.5 COLETA DE DADOS

A coleta de informações ocorreu por meio da entrevista fenomenológica a fim de compreender as perspectivas de familiares e enfermeiros sobre as ações de saúde mental na APS, na perspectiva do referencial schutziano.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, orientadas por um roteiro previamente elaborado (Apêndice I), contendo questões para caracterização dos participantes e perguntas abertas que possibilitaram a enfermeiros e familiares expressarem percepções, opiniões e experiências relacionadas ao objeto do estudo. As entrevistas foram conduzidas por integrantes da equipe de pesquisa — acadêmicas de enfermagem, mestrandas, doutorandas, pós-doutoranda e professora vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem —, sendo gravadas mediante autorização dos participantes e posteriormente transcritas na íntegra. Durante o processo de transcrição, procurou-se preservar as expressões originais dos entrevistados, a fim de garantir fidelidade aos relatos e maior aproximação com o fenômeno investigado.

As entrevistas semiestruturadas são usadas quando os pesquisadores possuem tópicos ou questões amplas que precisam ser abordados durante a entrevista. O entrevistador usa um guia de tópicos para garantir que todas as áreas serão contempladas. A função do entrevistador é estimular o participante a falar livremente sobre todos os tópicos listados (POLIT; BECK, 2021).

Nesse método de coleta de dados, o entrevistador tem uma lista de tópicos para garantir a cobertura de suas questões, e a função desse sujeito é encorajar o entrevistado a falar livremente sobre os tópicos que constam no guia (POLIT; BECK, 2021).

As questões fenomenológicas foram abordadas inicialmente na execução da entrevista, sendo realizadas em mais de um encontro tendo em vista o cuidado na condução da entrevista fenomenológica pelo pesquisador, onde o mesmo coloca em suspensão suas crenças, pré-julgamentos e conceitos já estabelecidos – *epoché* (SCHNEIDER et al., 2007). Nesta perspectiva, no decorrer da coleta de dados foram utilizadas três questões orientadoras aos enfermeiros: 1) “Que ações em saúde mental você vem desenvolvendo na Atenção Primária?”; 2) “O que tem em vista com essas ações?”; 3) “Que ações você vem desenvolvendo voltadas para usuários em sofrimento psíquico?”. Para os familiares: 1) “Me fale sobre o atendimento em saúde mental desenvolvido pelos enfermeiros da

unidade ao seu familiar”; 2) “O que você espera das ações de saúde mental desenvolvidas pelos enfermeiros?”.

Por se tratar de uma pesquisa fenomenológica, as entrevistas ocorreram com interrupções das narrativas apenas em situações que envolveram o esclarecimento sobre algum aspecto relatado pelo participante do estudo. Contudo, os indivíduos se expressaram em tempo livre, o que propiciou a fala integral de suas intenções e expectativas para o delineamento da investigação. Aqui pode-se afirmar que o tempo necessário para cada entrevista foi de, aproximadamente, 40 minutos, sendo desenvolvida em local adequado ou sugerido pelos participantes.

No caso dos **enfermeiros**, foi tomado o cuidado para que as entrevistas não prejudicassem as entrevistas suas atividades assistenciais, sendo realizadas em espaço físico da própria unidade de saúde ou de acordo com sua disponibilidade. Em relação aos **familiares**, foram realizados contatos com cada participante e marcado horário e local, de acordo com suas disponibilidades pessoais. Nesse sentido, essas entrevistas ocorreram no domicílio, nas dependências da US ou outro local de fácil acesso geográfico e previamente acordado com o participante.

Todas as entrevistas foram gravadas e armazenadas em arquivo digital, e posteriormente foram transcritas na íntegra a fim de que a pesquisadora pudesse ler e reler o conteúdo com a finalidade de compreender os dados, responder as questões formuladas e expandir o conhecimento acerca da temática abordada.

Cabe ressaltar, que entrevistas em instância fenomenológica, as informações são obtidas até o instante em que o fenômeno possa se mostrar ao pesquisador, pelos discursos dos sujeitos, isto é, até que haja convergência/divergência, a essência de um fenômeno (MINAYO, 2020).

5.6 ANÁLISE DE DADOS

A sociologia compreensiva tem tido grande influência na construção do conhecimento da realidade. Ela privilegia a compreensão e a inteligibilidade como propriedades específicas dos fenômenos sociais (MINAYO, 2020).

Para a compreensão das perspectivas de familiares e enfermeiros sobre as ações de saúde mental na Atenção Primária trabalhei com as convergências das unidades de significado que emergiram das entrevistas à luz do referencial teórico da Sociologia Fenomenológica de Alfred Schutz (SCHUTZ, 2018).

Dessa maneira, foram realizadas as seguintes etapas (CAMATTA, 2010; NASI, 2009; SCHNEIDER; CAMATTA; NASI, 2007):

- 1) Leitura atenta das falas para captar a situação vivenciada e os *motivos para e motivos porque* dos sujeitos;
- 2) Identificação de categorias concretas que abrigam os atos dos sujeitos;
- 3) Releitura das falas para selecionar e agrupar trechos que contenham aspectos significativos semelhantes das ações dos sujeitos;
- 4) A partir das características típicas das falas, foi estabelecido o significado das ações dos sujeitos, buscando descrever o típico da ação do grupo social – enfermeiros e familiares.

A fim de preservar o anonimato dos participantes foi utilizada a letra F para familiares e E para enfermeiros, seguidos de um número conforme realizamos as entrevistas, por exemplo, F1, F2, F3 e assim subsequentemente.

5.7 CONSIDERAÇÕES BIOÉTICAS

Os preceitos bioéticos foram respeitados e seguidos de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013), que legisla sobre os aspectos éticos de pesquisa envolvendo seres humanos, os indivíduos que aceitaram fazer parte da investigação assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), o qual foram esclarecidos aos participantes: os objetivos da pesquisa, a metodologia, o direito à participação voluntária e à recusa de responder quaisquer das questões, a garantia de privacidade das informações e do uso exclusivo para finalidade científica, a garantia de anonimato dos participantes e do direito de desistirem de participar do estudo a qualquer momento e que as dúvidas seriam esclarecidas, antes de sua assinatura, ficando uma cópia para o entrevistado (GOLDIM, 2020).

Os dados foram utilizados apenas para esta pesquisa, ou seja, para fins científicos. Serão armazenados durante cinco anos e após serão destruídos.

O projeto guarda-chuva intitulado “*Ações de enfermagem voltadas para a saúde mental na Atenção Básica*” (NASI et al., 2018) foi aprovado pela Comissão de Pesquisa da EEUFRGS. O projeto foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da SMS de Porto Alegre, via Plataforma Brasil.

Os pesquisadores estavam atentos a qualquer modificação emocional e/ou postural dos entrevistados e, prontamente, interromperam a entrevista caso mostrou-se necessário. Além disso, cada participante foi informado de que, se desejasse, poderia interromper a entrevista a qualquer momento. Mesmo oferecendo risco mínimo, a realização das entrevistas do estudo pode causar algum

desconforto aos participantes em relação à exposição de suas perspectivas e vivências. Diante disso, em situação de desconforto do participante foi realizada a escuta ativa pela equipe de pesquisadores e, caso necessário, houve o encaminhamento à equipe de matriciamento em saúde mental do território, a qual se constitui como suporte em saúde mental a todos as US do distrito assistencial. Os benefícios do estudo não se deram de imediato aos participantes, mas propuseram um repensar das práticas dos enfermeiros da APS quanto às ações de saúde mental, assim, promovendo a melhoria do cuidado prestado aos pacientes, família e comunidade. Assim, entende-se que os benefícios são maiores que os riscos.

Após o término da pesquisa, os resultados foram disponibilizados um momento para devolutiva dialogada dos resultados aos serviços de saúde da APS, incluindo a chefia da GD Norte, através de uma reunião on-line. Com isto, oportunizou-se um espaço de reflexão e potencializadas as possibilidades de transformação das práticas de cuidado nos cenários assistenciais desta pesquisa e de espaços semelhante a esses.

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo possibilitou compreender que as ações de saúde mental desenvolvidas por enfermeiros e familiares na APS não se organizam prioritariamente por protocolos, rotinas técnicas ou dispositivos formais de cuidado. Ao contrário, estruturam-se a partir de uma racionalidade prática-relacional sustentada pela escuta, pelo vínculo, pelo acolhimento, pela persistência no acompanhamento e pela corresponsabilização familiar e territorial, produzidas no encontro cotidiano entre enfermeiro, usuário e família.

A análise das categorias concretas evidenciou que o cuidado em saúde mental na APS se constitui no mundo da vida, no encontro face a face, na intersubjetividade que se estabelece no território. O enfermeiro atua como articulador do cuidado em momentos de crise, sustentador do vínculo nos períodos de estabilidade, mediador das relações familiares, elo com a rede de atenção psicossocial, referência de escuta e acolhimento e agente de busca ativa e persistência no cuidado. O acompanhamento não se limita a intervenções pontuais, mas configura-se como presença longitudinal, contínua e intencional.

À luz da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz, foi possível evidenciar que esse agir profissional é orientado por *motivos para*, relacionados à intenção de manter o cuidado, prevenir rupturas e proteger o usuário, e por *motivos porque*, ancorados nas experiências prévias, nas memórias do território e no acúmulo de vivências profissionais. O estoque de conhecimento à mão e a *relação nós* mostraram-se centrais para compreender como o enfermeiro decide, age e sustenta o cuidado em situações muitas vezes imprevisíveis e complexas.

Entretanto, os achados também revelam uma dimensão que ultrapassa a descrição das práticas e exige problematização. O cuidado em saúde mental na APS, tal como identificado neste estudo, acontece não porque as condições institucionais sejam plenamente favoráveis, mas apesar de suas limitações. A sobrecarga de trabalho, a insuficiência de recursos humanos, a fragilidade da rede, a dificuldade de manutenção de grupos e ações coletivas e a escassez de tempo para a escuta qualificada compõem o cenário no qual o enfermeiro precisa sustentar esse cuidado.

Emerge, assim, um paradoxo central: um cuidado complexo, ético e relacional, fundamental para a saúde mental no território, encontra-se sustentado predominantemente por tecnologias leves invisíveis e pela disposição subjetiva, ética e relacional do enfermeiro, carecendo de reconhecimento institucional, respaldo organizacional e investimento sistemático em formação e condições de trabalho.

Esse paradoxo revela que a potência do cuidado identificado não deve ser interpretada como virtude estrutural do sistema, mas como expressão da resistência cotidiana dos profissionais frente a condições que nem sempre favorecem a produção desse cuidado. O estudo evidencia, portanto, uma distância entre o que as políticas públicas preconizam para a saúde mental na APS e o modo como esse cuidado se concretiza na prática diária.

Para a enfermagem, os resultados demonstram um papel central e muitas vezes invisibilizado na sustentação do cuidado em saúde mental no território, evidenciando a força das tecnologias leves, da responsabilidade ética e da persistência no vínculo. Para a APS, reafirma-se seu potencial como espaço privilegiado de cuidado em saúde mental, ao mesmo tempo em que se evidencia a necessidade de condições estruturais que sustentem, de forma menos dependente da subjetividade individual, as práticas identificadas.

Em relação aos familiares, a análise das narrativas evidenciou que o cuidado em saúde mental na APS é vivenciado, por eles, como uma experiência marcada simultaneamente por apoio relacional significativo e por sobrecarga cotidiana persistente. O enfermeiro aparece como referência concreta de escuta, orientação e acolhimento no território, mas essa referência ganha centralidade justamente porque outras respostas da rede se mostram frágeis, intermitentes ou insuficientes. Compreende-se que os familiares se aproximam do serviço e do enfermeiro movidos por seus *motivos porque* — medo de crises, exaustão, solidão no cuidado, responsabilidade afetiva — e por *motivos para* — buscar orientação, garantir continuidade do tratamento, encontrar alguém que compartilhe a responsabilidade pelo sofrimento vivido em casa. Essa busca não é apenas por atendimento técnico, mas por reconhecimento, escuta e parceria no enfrentamento do adoecimento psíquico.

Entretanto, o que emerge de forma crítica é que essa parceria se torna, muitas vezes, um mecanismo compensatório das lacunas do sistema. Os familiares relatam a necessidade de insistir por atendimentos, organizar rotinas, acompanhar encaminhamentos, mediar o acesso à rede e sustentar, com recursos próprios, aquilo que deveria estar garantido institucionalmente. Assim, assumem funções de coordenação do cuidado para as quais não foram preparados e que extrapolam a dimensão do cuidado afetivo esperado no âmbito familiar.

Configura-se, portanto, uma situação particular: quanto mais o familiar reconhece no enfermeiro um apoio fundamental, mais a rede de atenção psicossocial passa a ser percebida, em sua experiência cotidiana, a partir da relação com esse profissional. O vínculo estabelecido não substitui a necessidade de serviços articulados, grupos terapêuticos, acompanhamento especializado e fluxos resolutivos. Entretanto, na vivência concreta do cuidado, é essa relação que acaba assumindo, para o

familiar, a função de referência principal, concentrando demandas e expectativas que deveriam ser compartilhadas por toda a rede.

As expectativas expressas pelos familiares — maior presença do enfermeiro, continuidade de grupos, resolutividade nos encaminhamentos, orientação mais frequente — revelam não apenas demandas assistenciais, mas a necessidade de dividir a carga emocional e prática do cuidado. O que está em jogo não é apenas o tratamento do usuário, mas a sobrevivência psíquica de quem cuida.

Dessa forma, o estudo evidencia que o cuidado em saúde mental na APS, sob a perspectiva dos familiares, sustenta-se em uma ética do encontro e da confiança, mas permanece vulnerável por depender excessivamente das tecnologias leves e da implicação pessoal dos profissionais. O familiar encontra apoio, mas não encontra, com a mesma intensidade, a segurança de uma rede estruturada que lhe permita cuidar sem adoecer.

Como contribuição reflexiva, esta investigação explicita que os familiares não são apenas coadjuvantes do cuidado, mas sujeitos centrais na sua sustentação cotidiana. Contudo, permanecem invisibilizados nas políticas, pouco reconhecidos nas práticas e sobrecarregados por responsabilidades que ultrapassam sua capacidade objetiva de manejo.

Reconhece-se como limite o fato de o estudo estar circunscrito a um território específico. Ainda assim, as experiências relatadas permitem problematizar uma questão mais ampla: enquanto o cuidado em saúde mental na APS depender da capacidade dos familiares de organizar, insistir e sustentar o tratamento junto com o enfermeiro, ele continuará sendo potente no plano relacional, porém frágil no plano estrutural.

Como contribuição científica, este estudo amplia a compreensão sobre o cuidado em saúde mental na APS ao demonstrar que ele se sustenta por uma racionalidade fenomenológica prática-relacional, ancorada na intersubjetividade e na longitudinalidade do vínculo, trazendo implicações para o modo como a saúde mental é pensada na organização dos serviços, na formação profissional e nas políticas públicas.

Reconhece-se como limitação o fato de o estudo ter sido realizado em um território específico, o que não permite generalizações, mas possibilita compreensões aprofundadas sobre o fenômeno a partir da experiência concreta dos participantes.

Por fim, este estudo suscita reflexões e abre possibilidades para novas investigações que incluam análises sobre a formação em saúde mental para enfermeiros da APS e estudos acerca da organização do processo de trabalho, de modo a fortalecer institucionalmente práticas que hoje se sustentam, em grande medida, na implicação pessoal e ética dos profissionais.

Essa constatação convoca gestores e formuladores de políticas a reconhecer que apoiar o familiar não é um gesto complementar do cuidado em saúde mental, mas condição central para sua efetividade. Fortalecer esse cuidado implica criar dispositivos institucionais que reduzam a sobrecarga familiar, garantam fluxos assistenciais mais resolutivos e reconheçam, de forma concreta, o familiar como parte integrante e necessitada de cuidado no processo terapêutico.

7) REFERÊNCIAS

- 1) ALMEIDA, D. L.; ALVIM, R. G.; COTA, A. L. S.; PEREIRA, T. S. Saberes em saúde mental e a prática profissional na estratégia saúde da família. *Interface Cient. Saúde Ambient.*, v. 9, n. 3, p. 27–42, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.17564/2316-3801.2022v9n3p27-42>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- 2) ALMEIDA, L. S.; LOPES, M. S.; MOURA, A. A. A articulação da Atenção Primária com a Rede de Atenção Psicossocial: desafios e potencialidades. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, n. 6, p. e20210733, 2022.
- 3) ALVES, C. E. D. R. *A importância da Fenomenologia sociológica de Alfred Schutz para a Sociologia: contribuições para a ideia de socialização*. Niterói-RJ, 2021. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/handle/1/24081>>. Acesso em: 18 ago. 2024.
- 4) ANDRADE, N. M. et al. Assistência de enfermagem na atenção psicossocial: revisão narrativa de literatura. *Revista Saúde e Pesquisa*, Umuarama, v. 16, n. 2, p. e-9054, 2023. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/9054>. Acesso em: 1 out. 2025.
- 5) AUAD, D. et al. Corresponsabilidade no cuidado em saúde mental: desafios e possibilidades na atenção primária à saúde. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 27, e220143, 2023.
- 6) AYRES, J. R. C. M. *Cuidado: trabalho e interação nas práticas de saúde*. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2022.
- 7) BARBOSA, G. M. et al. Experience of hospitalization of the family with children and adolescents in psychological distress. *Rev. Esc. Enferm. USP*, v. 57, e20220457, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0457en>. Acesso em: 18 set. 2024. Epub 30 out. 2023.
- 8) BAUMRIND, D. *Current patterns of parental authority*. *Developmental Psychology Monograph*, v. 1, n. 1, p. 1-103, 1967.
- 9) BESSA, M. M.; DE LIMA, M. V. C.; DE FREITAS, R. J. M. et al. A fenomenologia de Alfred Schutz e sua aplicação no campo da pesquisa em saúde e enfermagem. *Rev. Sustinere*, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 842–857, 2023. DOI: 10.12957/sustinere.2023.72222. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/72222>. Acesso em: 18 ago. 2024.
- 10) BEZERRA, I. C.; JORGE, M. S. B.; SILVA, R. M. da; PESSOA, V. M.; MOREIRA, T. M. M. Capacitação nacional emergencial em saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19: um relato de experiência. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 44, n. esp. 4, p. 267-280, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042020E417>.
- 11) BORGES, C. F.; LUZIO, C. A.; YASUI, S. A difícil tessitura da rede de atenção psicossocial: desafios da integralidade. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 9, p. 3517–3526, 2020.
- 12) BORYSOW, I. C.; FURTADO, J. P. O acolhimento em saúde mental na atenção básica: práticas, desafios e potencialidades. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 31, n. 1, p. e310105, 2021.
- 13) BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012*. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União (DOU), Brasília, 13 jun. 2013. seq. 1, p. 59.
- 14) BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, 1988.
- 15) BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

- Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2001/L10216.htm. Acesso em: 24 ago. 2025.
- 16) BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm. Acesso em: 24 ago. 2025.
 - 17) BRASIL. Ministério da Saúde. *Cuidado em saúde mental: diretrizes e práticas*. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
 - 18) BRASIL. Ministério da Saúde. *Diretrizes para o fortalecimento da atenção psicossocial na Atenção Primária à Saúde*. Brasília: MS, 2023.
 - 19) BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Básica*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica_2022.pdf. Acesso em: 1 set. 2024.
 - 20) BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS*. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.
 - 21) BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Saúde Mental: Atenção Psicossocial e a Reforma Psiquiátrica*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br>. Acesso em: 3 out. 2025.
 - 22) BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. *Recomendações para operacionalização da Política Nacional de Promoção da Saúde na Atenção Primária à Saúde [recurso eletrônico]*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/recomendacoes_politica_nacional_promocao_sau_de_2022.pdf. Acesso em: 1 set. 2024.
 - 23) BRASIL. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2011.
 - 24) BREHMER, L. C. de F.; VERDI, M. I. M. O enfermeiro na Atenção Primária à Saúde e o cuidado em saúde mental: práticas, desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. 2, p. e20200347, 2021.
 - 25) BRITO, J. C.; OLIVEIRA, L. S.; NASCIMENTO, R. R. Desafios e potencialidades da atenção psicossocial na Atenção Primária à Saúde. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, n. 4, p. e20220215, 2022.
 - 26) CAMATTA, M. W. *Ações voltadas para saúde mental na Estratégia de Saúde da Família: intenções de equipes e expectativas de usuários e familiares*. 2010. 207 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
 - 27) CAMATTA, M. W.; NASI, C.; SCHAURICH, D.; SCHNEIDER, J. F. Contribuições da sociologia fenomenológica de Alfred Schütz para as pesquisas em enfermagem: revisão de literatura. *Online Braz J Nurs {Internet}*, 2008. Disponível em: <http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-4285.2008.1446/383>. Acesso em: 20 ago. 2024.
 - 28) CAMPOS, G. W. S.; DOMITTI, A. C. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, p. 1-10, 2020.
 - 29) CAMPOS, G. W. S.; MELO, E. R. *Políticas de saúde no Brasil: história e contexto atual*. São Paulo: Hucitec, 2022.

- 30) CAMPOS, L. L.; MELO, A. K. Noção de família(s) no campo da saúde brasileira: ensaio teórico-reflexivo. *Esc Anna Nery*, v. 26, e20210197, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0197>. Acesso em: 17 ago. 2024.
- 31) CAPALBO, C. *Metodologia das ciências sociais: a fenomenologia de Alfred Schütz*. Londrina: Ed. UEL, 1998.
- 32) CARVALHO, A. M. S. et al. Apoio do enfermeiro às famílias de pessoas com transtornos mentais na APS: desafios e potencialidades. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 44, p. e20220231, 2023.
- 33) CARVALHO, L. B.; DIMENSTEIN, M. O cuidado em saúde mental na APS: desafios e potencialidades do trabalho em rede. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 26, e210833, 2022.
- 34) COSTA, F. C.; NASCIMENTO, L. C.; MARTINS, M. M. Sobrecarga e sofrimento de cuidadores familiares de pessoas com transtornos mentais. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 41, e20190235, 2020.
- 35) COSTA, J. C.; NITSCHKE, R. G.; THOLL, A. D.; HENCKEMAIER, L.; MICHELIN, S. R.; SILVA, A. P. M. Imaginário da promoção da saúde da família: olhar do familiar no cotidiano da Atenção Primária. *Cienc Cuid Saúde*, v. 16, n. 1, jan.-mar. 2017.
- 36) COUTO, D. S. et al. Acolhimento e vínculo como estratégias de cuidado em saúde mental na Atenção Primária. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 76, n. 4, p. e20220634, 2023.
- 37) CRESWELL, J. W. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- 38) DENZIN, N.; LINCOLN, Y. *The SAGE handbook of qualitative research*. 5. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- 39) DIAS, M. L.; MELO JÚNIOR, E. B.; CHIAVEGATO FILHO, L. G. Impacto da pandemia da COVID-19 na saúde mental dos profissionais da atenção primária. *Acervo Mais de Saúde*, v. 16, n. 6, p. e16870, 2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/16870>. Acesso em: 1 out. 2025.
- 40) DIMENSTEIN, M. et al. Práticas de cuidado em saúde mental na atenção primária: desafios e perspectivas. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 25, e210021, 2021.
- 41) DIMENSTEIN, M.; MACEDO, J. P.; FONTENELE, R. M. Família e cuidado em saúde mental na atenção básica. *Revista Psicologia em Estudo*, v. 27, e55678, 2022.
- 42) FALKENBERG, M. B. et al. Integralidade e cuidado em saúde mental na atenção básica: o papel do enfermeiro. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 5, e20190589, 2020.
- 43) FERREIRA LACHTIM, S. A. Vínculo e acolhimento na Atenção Primária à Saúde: potencialidades e desafios para o cuidado. *Tempus – Actas de Saúde Coletiva*, [S. l.], v. 16, n. 4, 2023. DOI: 10.18569/tempus.v16i4.3060. Disponível em: <https://www.tempus.unb.br/index.php/tempus/article/view/3060>. Acesso em: 6 abr. 2026.
- 44) FERREIRA, M. A. et al. Educação em saúde e promoção da autonomia do usuário na atenção primária. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 27, e220432, 2023.
- 45) FERREIRA, T. P. da S.; SAMPAIO, J.; OLIVEIRA, I. L. de; GOMES, L. B. A família no cuidado em saúde mental: desafios para a produção de vidas. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 43, n. 121, p. 441–449, abr./jun. 2022. Disponível em: <https://saudeemdebate.org.br/sed/article/view/2385>. Acesso em: 12 nov. 2025.
- 46) FLICK, U. *An introduction to qualitative research*. 6. ed. London: SAGE Publications, 2021.
- 47) FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J.; TURATO, E. R. *Pesquisa qualitativa: fundamentos e práticas*. 3. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2018.
- 48) FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 66. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

- 49) GAMA, C. A. P. Os profissionais da Atenção Primária à Saúde diante das demandas de saúde mental: desafios e perspectivas. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 25, e200438, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/ngR3KBLS6xBNvHGNGjscJ9S/>. Acesso em: 5 out. 2025.
- 50) GIDDENS, A. *Conceitos essenciais da sociologia*. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2020.
- 51) GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021.
- 52) GIOVANELLA, L.; BOUSQUAT, E. M.; SCHENKMAN, S.; ALMEIDA, P. F.; SARDINHA, L. M. V.; VIEIRA, M. L. F. Cobertura da Estratégia Saúde da Família no Brasil: o que nos mostram as Pesquisas Nacionais de Saúde 2013 e 2019. *Ciênc Saúde Colet.*, v. 26, supl. 1, p. 2543-56, jun. 2021.
- 53) GOLDIM, J. R. *Bioética: uma introdução*. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2020.
- 54) GOMES, C. B. S.; GUTIÉRREZ, A. C.; SORANZ, D. Política Nacional de Atenção Básica de 2017: análise da composição das equipes e cobertura nacional da Saúde da Família. *Ciênc. Saúde Colet.*, v. 25, n. 4, p. 1327-1338, abr. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020254.31512019>. Acesso em: 17 ago. 2024.
- 55) GONÇALVES, E. F.; SOUZA, J. A. Dinâmicas familiares e saúde mental: impactos positivos e negativos. *Rev. Psiq. Psicol.*, v. 25, n. 4, p. 280-295, 2021.
- 56) HIRDES, Alice. Atenção psicossocial na Atenção Primária à Saúde: desafios para a integralidade e a continuidade do cuidado. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 9, p. 3481-3490, 2020.
- 57) IBGE. *Porto Alegre: características demográficas e serviços de saúde*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023.
- 58) JESUS, M. C. P. et al. A fenomenologia social de Alfred Schütz e sua contribuição para a enfermagem. *Rev. Esc. Enferm. USP.*, v. 47, n. 3, p. 736-41, 2013.
- 59) KANTORSKI, L. P. et al. Atenção psicossocial e vínculo em saúde mental na APS. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 7, p. 2753-2762, 2020.
- 60) LANDIM, I.; BANACO, R. A.; BORSA, J. C. O que é família para você? Opinião de crianças sobre o conceito de família. *Av. Psicol. Latinoam.*, v. 38, n. 2, p. 1-15, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.7178>. Acesso em: 17 ago. 2024.
- 61) LIMA, A. M. et al. Práticas de cuidado em saúde mental na atenção primária: o papel da família na adesão ao tratamento. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 11, p. 1-19, 2021.
- 62) Lima, A. M. J.; Santos, C. S. F.; Almeida, M. M. O. Olhares sobre a assistência em saúde mental na Atenção Primária: desafios e perspectivas. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 25, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/icse/2021.v25/e200678/>. Acesso em: 03 out. 2025.
- 63) LIMA, A. Maria de; DIMENSTEIN, Magda. Cuidado em saúde mental na Atenção Primária: desafios da escuta e do acolhimento. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 32, n. 3, p. 1-19, 2022.
- 64) LOPES, F. A.; SILVA, J. M. O impacto do suporte familiar na adesão ao tratamento de saúde mental. *Rev. Bras. Psicol. Clín.*, v. 28, n. 1, p. 45-60, 2023.
- 65) LOPES, O. C. A.; HENRIQUES, S. H.; SOARES, M. I. et al. Competências dos enfermeiros na Estratégia Saúde da Família. *Esc. Anna Nery*, v. 24, n. 2, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2019-0145>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- 66) LOPES, P. F.; TOLEDO, V. P. Sentimentos do enfermeiro ao acolher paciente psiquiátrico agitado e agressivo. *Rev. Enferm. UFPE On Line.*, v. 14, e244485, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.244485>.

- 67) MACHINESKI, G. G.; SCHNEIDER, J. F.; CAMATTA, M. W. The experience lived by clients' family members of a child psychosocial care center. *Rev. Gaúcha Enferm.*, v. 34, n. 1, p. 126-132, 2013.
- 68) MARCOLINO, T. Q.; FANTINATTI, E. N.; GOZZI, A. P. N. F. Comunidade de prática e cuidado em saúde mental: uma revisão sistemática. *Trab. educ. saúde*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p. 643-58, mai.-ago. 2018.
- 69) MELO, F. A.; CAMPOS, G. W. S.; DOMITTI, A. C. O trabalho interprofissional e os desafios para a integralidade na Atenção Primária à Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 4, p. 1421-1430, 2020.
- 70) MENEZES, T.; LOPES, A. Estilos parentais e impacto na saúde mental familiar. *Psicologia em Estudo*, v. 24, e45123, 2019.
- 71) MERHY, Emerson Elias. *Trabalho vivo em ato: subjetividade, cuidado e o encontro com o outro no SUS*. São Paulo: Hucitec, 2022.
- 72) MERHY, Emerson Elias; FEUERWERKER, Laura Camargo Macruz. *Novo olhar sobre as tecnologias do cuidado em saúde: a micropolítica do trabalho vivo*. In: MERHY, E. E.; FRANCO, T. B. (Orgs.). *Trabalho, produção do cuidado e subjetividade*. São Paulo: Hucitec, 2016. p. 21–42.
- 73) MINAYO, M. C. S. *Pesquisa qualitativa: teoria, planejamento e execução*. 15. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2020.
- 74) MORAES, T. R.; SANTOS, E. A.; BARBOSA, M. C. Saúde mental na atenção primária: limites e possibilidades da prática de enfermagem. *Saúde em Debate*, v. 47, n. 136, p. 112–124, 2023.
- 75) MORAIS, L. G. de A.; ARAUJO, R. M. da S.; PORTO, R. de M.; TRAJANO, J. A.; SOUSA, M. N. A. de. Saúde mental: o papel da atenção primária à saúde / Mental health: the role of primary health care. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 10475–10489, 2021. DOI: 10.34119/bjhrv4n3-071. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/29716>.
- 76) NASCIMENTO, L. R. et al. Atenção integral e acolhimento na saúde da família: análise das práticas de acolhimento e sua importância na construção da atenção integral à saúde. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 48, 2026. DOI: 10.5712/rbmfc21(48)4440. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/4440>. Acesso em: 6 abr. 2026.
- 77) NASI, C. *O Cotidiano de usuários de um centro de atenção psicossocial na perspectiva da sociologia fenomenológica*. 2009. 100 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.
- 78) NASI, C.; CAMATTA, M. W.; MELLO, R. M.; LACCHINI, A. J. B.; SCHNEIDER, J. F.; OLIVEIRA, G. C.; PINHO, L. B.; GUIMARÃES, A. N.; TORRES, M. A. L. *Ações de enfermagem voltadas para a saúde mental na atenção básica*. Projeto Guarda Chuva (não publicado), 2018.
- 79) NUNES, V. V.; FEITOSA, L. G. G. C.; FERNANDES, M. A.; ALMEIDA, C. A. P. L.; RAMOS, C. V. Saúde mental na atenção básica: atuação do enfermeiro na rede de atenção psicossocial. *Rev. Bras. Enferm.*, v. 73, supl. 1, p. 1-7, 2020.
- 80) NÓBREGA, M. P. S. S.; FERNANDES, C. S. N. N.; ZERBETTO, S. R.; SAMPAIO, F. M. C.; DUARTE, E.; CHAVES, S. C. S.; MOREIRA, W. C. Nurses' attitudes facing the family involvement in caring for people with mental disorder. *Rev. Bras. Enferm.*, v. 73, supl. 1, p. 1-8, 2020.
- 81) Oliveira, B.V.S, et al. Impacto da pandemia da COVID-19 no cuidado na Atenção Primária à Saúde. *Saúde Coletiva*. 2021.

- 82) OLIVEIRA, E. C.; MEDEIROS, A. T.; TRAJANO, F. M. P.; CHAVES NETO, G.; ALMEIDA, S. A.; ALMEIDA, L. R. O cuidado em saúde mental no território: concepções de profissionais da atenção básica. *Esc. Anna Nery*, v. 21, n. 3, p. 1-7, 2017.
- 83) OLIVEIRA, L. P.; ARISTIDES, J. L.; ALTOÉ, D. P. G. O cuidado em saúde mental na atenção básica: percepção dos profissionais. *Cadernos Brasileiros de Saúde Mental / Brazilian Journal of Mental Health*, Curitiba, v. 16, n. 47, p. 18-40, 2024.
- 84) OLIVEIRA, M. et al. Transformações no cuidado em saúde: da atenção hospitalocêntrica à atenção primária. *Saúde e Sociedade*, v. 26, n. 4, p. 1045-1058, 2017.
- 85) OLTRAMARI, L.; NAUJORKS, C. *A fenomenologia de Alfred Schutz como fundamento para a análise da entrevista biográfica*. Gavagai, v. 9, n. 1, p. 9-25, 2022. Acesso em: 19 ago. 2024.
- 86) ONOCKO-CAMPOS, R. et al. *Atenção Psicossocial: a prática da saúde mental na atenção primária*. São Paulo: Hucitec, 2021.
- 87) PELEK, LR; CAVALCANTE, MDMA; MALAQUIAS, T. da SM; JERÔNIMO, DVZ; DE BORBA, KP; DA SILVA, DC; DE MORAIS, EP; MASSUQUETO, RRH Dimensões individuais e familiares da gestão do cuidado em saúde mental na atenção primária: revisão integrativa. *Braz. J. Desenvolver.*, [S. 1.], v. 4, pág. 32397–32420, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n4-633. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/47279>. Acesso em: 16 mar. 2025.
- 88) PEREIRA, L. C. et al. Articulação entre APS e CAPS: desafios para a integralidade do cuidado. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 32, n. 2, e320210, 2022.
- 89) PEREIRA, M. J.; COSTA, R. D.; ALMEIDA, C. L. A descontinuidade das ações coletivas de saúde mental na APS: desafios contemporâneos da RAPS. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 27, p. e230134, 2023.
- 90) PEREIRA, M. S. et al. Práticas de saúde mental na Atenção Primária à Saúde: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 40, n. 131, p. 59-74, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/download/12674/11474/167768>. Acesso em: 5 out. 2025.
- 91) PESSOA, J. C. et al. Cuidado compartilhado em saúde mental: intersubjetividade e redes de apoio na APS. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, n. 6, e20220045, 2022.
- 92) PINHO, E. S.; OLIVEIRA, F. A. O papel do enfermeiro no acolhimento e escuta em saúde mental na atenção básica. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 11, n. 3, p. 1–16, 2021.
- 93) POLIT, D. F.; BECK, C. T. *Nursing research: principles and methods*. 10. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021.
- 94) PORTO ALEGRE. *Plano Municipal de Saúde 2022-2025*. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://www.portoalegre.rs.gov.br/pms2022-2025>. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 95) PRADO, D. *O que é família*. São Paulo: Brasiliense, 2017.
- 96) PRADO, M. *Família contemporânea: diversidade e transformação*. São Paulo: Loyola, 2017.
- 97) PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. *Carta de serviços: atenção primária à saúde*. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/carta-de-servicos/atencao-primaria-saude-unidades-de-saude>. Acesso em: 23 set. 2024.
- 98) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. *Porto Alegre amplia cobertura da Estratégia Saúde da Família para quase 94% da população*. Porto Alegre, 19 mar. 2026. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/noticias/porto-alegre-amplia-cobertura-da-estrategia-saude-da-familia-para-quase-94-da>. Acesso em: 15 abr. 2026.

- 99) RAIMUNDI, D. M.; FERREIRA, F. F.; LIMA, F. C. A.; SIQUEIRA, V. de C. A. Análise das clínicas da família: visão dos enfermeiros de serviço. *Rev Esc Enferm USP*, São Paulo, v. 50, n. spe, p. 130-138, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420160000300019>. Acesso em: 23 set. 2024.
- 100) RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. *Relatório Anual de Gestão 2023*. Porto Alegre: Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, 2023. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202403/27113721-rag-2023-versao-final.pdf>. Acesso em: 1 set. 2024.
- 101) RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual da Saúde. *Manual para os novos gestores municipais (2021-2024) referente à Atenção Básica*. 1. ed. Porto Alegre: Secretaria Estadual da Saúde, 2021.
- 102) SANTOS, J. L. G. et al. Apoio emocional e prático da enfermagem aos familiares no cuidado em saúde mental na atenção primária. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. 4, e20200873, 2021.
- 103) SANTOS, L. F. et al. Integralidade e vínculo no cuidado em saúde mental na Atenção Primária: desafios contemporâneos. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 26, e210180, 2022.
- 104) SANTOS, L. M. dos; OLIVEIRA, R. M. de. Contribuições da enfermagem para o cuidado em saúde mental na Atenção Primária à Saúde. *Revista Brasileira de Saúde Pública*, v. 56, p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsp/a/6Y6h5Z7wD5h9Y6K6w8LxF9N/?lang=pt>. Acesso em: 5 out. 2025.
- 105) SANTOS, R. L.; ARAÚJO, P. C.; SILVA, V. A. Enfermagem e saúde mental na APS: práticas, limites e desafios na rede de atenção psicossocial. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 45, e20240128, 2024.
- 106) SCHNEIDER, J. F.; CAMATTA, M. W.; NASI, C. O trabalho em um centro de atenção psicossocial: uma análise sociológica fenomenológica em Alfred Schütz. *Rev. Gaúcha Enferm*, Porto Alegre, v. 28, n. 4, p. 520-6, 2007.
- 107) SCHNEIDER, J. F.; NASI, C.; CAMATTA, M. W.; OLIVEIRA, G. C.; MELLO, R. M.; GUIMARÃES, A. N. O referencial Schutiziano: contribuições para o campo da enfermagem e saúde mental. *J Nurs UFPE on line*, Recife, v. 11, supl. 12, p. 5439-47, dez. 2017.
- 108) SCHUTZ, A. *A construção significativa do mundo social: uma introdução à sociologia compreensiva*. Petrópolis: Vozes, 2018.
- 109) SCHUTZ, A. *El problema de la realidad social*. Buenos Aires: Amorrortu, 2012.
- 110) SCHUTZ, A. *Fenomenologia do mundo social: introdução à sociologia compreensiva*. Petrópolis: Vozes, 1979.
- 111) SCHUTZ, A. *Sobre a fenomenologia e as relações sociais*. Petrópolis: Vozes, 2012.
- 112) SCHUTZ, A.; LUCKMANN, T. *Estruturas do mundo da vida* [recurso eletrônico]. Tradução: Tomas da Costa; apresentação e revisão técnica: Hermílio Santos. Porto Alegre: ediPUCRS, 2023.
- 113) SILVA, F. M. da. et al. Family motivations and expectations in the care for psychoactive substance users. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 44, p. e20220141, 2023.
- 114) SILVA, F. M. da; NASI, C.; FIORINI, A. L. Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo. *Saúde Coletiva (Barueri)*, [S. l.], v. 16, n. 98, p. 16626–16647, 2025. DOI: 10.36489/saudecoletiva.2025v16i98p16626-16647. Disponível em:

- <https://revistasauodecoletiva.com.br/index.php/sauodecoletiva/article/view/3521>. Acesso em: 22 ago. 2025.
- 115) SILVA, G. L. A família no processo de cuidar. *Rev. Ciência Desenvolvimento*, v. 12, n. 2, p. 369-385, 2019. Disponível em: <http://srv02.fainor.com.br/revista/index.php/memorias/article/view/905/475>. Acesso em: 17 ago. 2024.
- 116) SILVA, J. A. et al. A escuta e o acolhimento como dispositivos de cuidado na atenção psicossocial. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 30, e3492, 2022.
- 117) SILVA, J. A.; LUZ, A. M. H. A dialogicidade como fundamento do cuidado em saúde mental na APS. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 42, n. spe, p. e20200456, 2021.
- 118) SILVA, J. P.; OLIVEIRA, C. F.; LOPES, R. M. Acolhimento e vínculo como dimensões essenciais do cuidado em saúde mental na APS. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 32, p. e3925, 2024.
- 119) SILVA, R. *Estratégia Saúde da Família: desafios e perspectivas*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2019.
- 120) SILVA, T. P.; ALMEIDA, R. S. Influência familiar na adesão ao tratamento de saúde mental: uma revisão de literatura. *J. Psicol. Saúde Mental*, v. 30, n. 2, p. 150-165, 2022.
- 121) SILVA, V. C. da. Effectiveness of Agreement Criteria and Flows of Collaborative Care in Primary Mental Health Care in Brazil. *BMC Primary Care*, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9690976/>. Acesso em: 5 out. 2025.
- 122) SOUSA, A. R. et al. Escuta e acolhimento como dispositivos de cuidado em saúde mental na Atenção Primária. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, n. 3, p. e20210523, 2022.
- 123) SOUSA, R. M.; BARROS, A. L.; LIMA, R. G. Desafios da integração entre APS e RAPS: fluxos, contrarreferência e acesso. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 27, e220079, 2023.
- 124) SOUZA, Juliana A.; PEREIRA, Rosane C.; CAMPOS, Gerson S. Acolhimento e vínculo como eixos do cuidado em saúde mental na APS. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 73, supl. 1, e20190615, 2020.
- 125) SOUZA, L. M. M.; KANTORSKI, L. P.; LIMA, D. D. Cuidado compartilhado e suporte às famílias na rede de atenção psicossocial. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 27, p. e220108, 2023.
- 126) SOUZA, M. N. C. *Algumas considerações sobre a sociologia de Alfred Schutz*. Tese, v. 9, n. 1, p. 1-26, 2012. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37988007/ALGUMAS_CONSIDERACOES_SOBRE_A_SOCIOLOGIA_D_E_ALFRED_SCHUTZ-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1666895096&Signature=gEZdeL7gs1VaGzZaNUs-. Acesso em: 18 ago. 2024.
- 127) TANAKA, O. Y.; RIBEIRO, E. L. Ações de saúde mental na atenção básica: caminho para ampliação da integralidade da atenção. *Cien Saude Colet*, v. 14, n. 2, p. 477–486, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000200016>. Acesso em: 25 jul. 2025. TISOTT, Z. L. et al. Família e redes de apoio social: uma revisão de literatura. In: Congresso Internacional em Saúde, 2019.
- 128) TISOTT, Z. L.; NASI, C.; BARROSO, T. Contribuições da sociologia fenomenológica de Alfred Schutz para o cuidado em enfermagem na saúde mental. *Rev. Enferm. Referência*, [S. l.], v. 6, n. 2, Supl. 1, p. 1–6, 2023. DOI: 10.12707/RV21126. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/referencia/article/view/30025>. Acesso em: 20 ago. 2024.

- 129) WALSH, F. *Processos normativos da família*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
- 130) WEBER, M. *Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. 1. ed. São Paulo: Editora Globo, 2004.
- 131) YIN, R. K. *Case study research and applications: design and methods*. 6. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE INFORMAÇÕES

1. CABEÇALHO	
Data: / /	Nº da Entrevista:
Local da entrevista:	Tempo duração:
Entrevistador:	Local de atuação:

2. DADOS DE CARACTERIZAÇÃO		
Nome:	Sexo: () M () F	Idade:
Escolaridade:	Situação conjugal:	
Ocupação/ profissão:	Religião ou crença:	

3. QUESTÕES DE ENTREVISTA	
ENFERMEIROS	
1) Que ações em saúde mental você vem desenvolvendo na Atenção Primária?	
2) O que tem em vista com essas ações?	
3) Que ações você vem desenvolvendo voltadas para familiares de usuários em sofrimento psíquico?	
FAMILIARES	
1) Me fale sobre o atendimento em saúde mental desenvolvido pelos enfermeiros da unidade ao seu familiar:	
2) O que você espera das ações de saúde mental desenvolvidas pelos enfermeiros?	

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO¹

Instituição de Origem: Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EENFUFRGS)

Projeto de Pesquisa: *Ações de enfermagem voltadas para a saúde mental na Atenção Básica*

Pesquisadora-Discente: Francine Moraes da Silva/morais.francine@hotmail.com

Provável Pesquisador Responsável: Cintia Nasi/cinasi@hcpa.edu.br

Concordo em participar do estudo intitulado “*Ações de enfermagem voltadas para a saúde mental na Atenção Básica*”.

Ficam claros para mim quais são os OBJETIVOS do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Tive oportunidade de perguntar sobre o estudo e todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Entendo que estou livre para decidir não participar desta pesquisa, sem nenhum prejuízo ou represália de qualquer natureza.

Estou ciente que receberei uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por mim, pela pessoa que realizou a discussão sobre o termo de consentimento e quando aplicável pela testemunha e/ou representante legal. Entendo que ao assinar este documento, não estou abdicando dos meus direitos legais.

Eu, _____ (nome do participante – letra de forma) estou ciente, após ter lido as informações contidas acima, dessa forma, concordo em participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.

Data:

Nome do entrevistado: _____

Assinatura do entrevistado: _____

Nome do entrevistador: _____

Assinatura do entrevistador: _____

¹ Elaborado conforme orientações contidas na Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do CONEP-CNS-MS. Duas vias de igual teor: uma destinada à pesquisadora e outra ao(à) participante.

ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP



UFRGS - PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL / PROPSQ & UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: AÇÕES DE ENFERMAGEM VOLTADAS PARA A SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Pesquisador: Cintia Nasi

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 04991418.1.1001.5347

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 3.578.583

Apresentação do Projeto:

Projeto de Pesquisa já aprovado por este CEP/UFRGS em 22/07/2019.

Foi apresentada uma emenda com a seguinte justificativa:

"Prezados membros do CEP, Encaminho Termo de ciência com assinatura do Diretor-Geral de Atenção Primária à Saúde, referente ao Projeto de Pesquisa "AÇÕES DE ENFERMAGEM VOLTADAS PARA A SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA" Envio também a última versão do projeto, com as alterações sugeridas pela Direção da Atenção Primária, devido às mudanças referentes ao processo de Matriciamento em Saúde Mental no Município. Atenciosamente, Prof. Cintia Nasi"

No parecer anterior, constava:

"É uma pesquisa qualitativa (sociologia fenomenológica de Alfred Schutz) no campo da ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, sob a forma de entrevistas (alinhadas à fenomenologia) com enfermeiros, usuários e familiares de Unidades de Saúde da Gerência Distrital de Saúde Norte / Eixo Baltazar (estruturas administrativas e gestoras regionais para as ações de saúde da esfera do SUS, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, neste caso específico composta pelos bairros Passo das Pedras, Sarandi e Rubem Berta).

A Gerência possui 1 gerente distrital, 2 assessores, 3 apoiadores institucionais, 1 responsável

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



UFRGS - PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL / PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 3.578.583

técnico de enfermagem, 2 técnicos de enfermagem e 3 auxiliares administrativos. Ela atende cerca de 200 mil pessoas, com atuação de 45 enfermeiros no total.

Consiste na realização de um estudo com grupos de enfermeiros, familiares e usuários de um serviço de saúde, no campo da saúde mental, levando em conta as ações dos enfermeiros e suas significações para todos os componentes do grupo em questão. É uma pesquisa de cunho acadêmico e também de cunho assistencial, uma vez que os conhecimentos construídos servirão para refletir acerca das ações dos enfermeiros e os modos da atenção ao campo psicossocial. Trata-se de pesquisa de cunho interdisciplinar envolvendo questões da saúde mental, da enfermagem psiquiátrica, da atenção primária à saúde, dos estudos em fenomenologia, e das relações entre familiares, usuários e enfermeiros nos serviços de saúde. Serão explorados aspectos das ações, intenções e significados das ações dos enfermeiros e as contrapartidas no campo das expectativas de usuários dos serviços de saúde mental e seus familiares (linguagem significativa da interação social). É uma pesquisa baseada em procedimentos e protocolos de observação e na interpretação das descrições individuais de vivências e experiências dos atores individuais num campo social (perspectiva da intersubjetividade). O foco é observar as transformações dos significações e das

ações propriamente ditas dos grupos de enfermeiros afetados pela reconcepção dos serviços de saúde, envolvendo propostas multidisciplinares de atenção à saúde, cenários extrahospitalares, valorização da subjetividade de familiares e usuários, noções de cuidado e de sofrimento psíquico, noções e políticas de inserção social e de reabilitação psicossocial.

Os dados coletados nas entrevistas serão analisados segundo o mesmo referencial teórico-metodológico, da sociologia fenomenológica: leitura e interpretação das falas de todos os participantes, identificação de categorias concretas que sejam explicativas e interpretativas dos atos dos sujeitos (relações entre a ação e a intenção), construção de grupamentos significativos narrativos, estabelecimento de significados.

A hipótese da pesquisa é de que as práticas dos enfermeiros são modos de visualizar a consolidação da Reforma Psiquiátrica, com uma transformação subjetiva e intersubjetiva dos agentes.

O projeto prevê a participação de 36 indivíduos (12 enfermeiros, 12 familiares, 12 usuários) e tem período de execução de 3 anos (2019/2021).

Para a viabilização do projeto, a pesquisadora indica todos os passos a serem dados no campo da investigação: apresentação do projeto para coordenadores de saúde, realização de visitas às unidades e apresentação do projeto para as equipes, coleta de dados nas Unidades de Saúde da

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



UFRGS - PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL / PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 3.578.583

Família e seleção dos participantes do estudo (num total de 36 participantes). Os participantes enfermeiros serão incluídos na pesquisa a partir dos seguintes itens: - ser do quadro funcional; - não estar em férias ou licença; - atuar no serviço no mínimo a seis meses. Os participantes usuários: - ser maior de 18 anos; - realizar ou ter realizado

atendimento de saúde mental junto às Unidades selecionadas; - estar em condições clínicas para a compreensão da pesquisa e ter capacidade de comunicação verbal. Quanto aos familiares: - ser maior de 18 anos; residir na mesma casa que o usuário; - acompanhar ou ter acompanhado o usuário em atendimentos; - estar em condições clínicas para a compreensão da pesquisa e ter capacidade de comunicação verbal.

Além da pesquisadora são identificados no projeto assistentes de pesquisa, membros da equipe de pesquisa e centro participantes e co-participes no projeto em questão.

Objetivo da Pesquisa:

O objetivo primário desta investigação é a compreensão dos significados das ações dos enfermeiros na saúde mental na Atenção Básica, envolvendo as percepções e interpretações dos próprios enfermeiros, dos familiares e dos usuários dos serviços de saúde mental.

Os objetivos secundários são os seguintes:

1. identificar ações de saúde mental desenvolvidas pelos enfermeiros na Atenção Básica e as ações voltadas para usuários de substâncias psicoativas;
2. analisar as intenções dos enfermeiros em relação às suas ações de saúde mental;
3. identificar estratégias de enfrentamento familiar para as situações do sofrimento psíquico dos seus familiares;
4. analisar as expectativas dos usuários e familiares sobre as ações dos enfermeiros;
5. compreender as convergências entre intenções e expectativas nestes grupos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Os riscos desta pesquisa são mínimos, pois ocupará um curto intervalo de seu tempo, que será programado com antecedência, bem como pode causar algum tipo de desconforto emocional, ao refletir sobre a temática, o processo de trabalho ou então alguma experiência de vida. Em caso de desconforto os participantes poderão interromper a entrevista e o suporte emocional necessário será fornecido, sendo que poderão optar por retornar em outro momento ou não.

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



UFRGS - PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL / PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 3.578.583

Benefícios:

Os benefícios do estudo não se darão de imediato aos participantes, mas sim ao propor-se um repensar das práticas dos enfermeiros da atenção básica quanto às ações de saúde mental.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Ver apresentação

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nessa versão (3) para aprovação da emenda foram apresentados:

1 PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_1426872_E1.pdf

2 Termo_Ciencia_DGAPS.pdf

3 Projeto_ENF_ACAO.pdf

4 TCLEUSUARIOFAMILIA.pdf

5 TCLEPROFISSIONAIS.pdf

6 cronogramaProjeto.pdf

7 Termo_cienciaGDNEB.PDF

8 termocintia.pdf

9 FolhadeRosto.pdf

10 orcamentoProjeto.pdf

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Emenda em condições de aprovação.

Considerações Finais a critério do CEP:

APROVADO.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_1426872_E1.pdf	02/09/2019 09:21:49		Aceito
Outros	Termo_Ciencia_DGAPS.pdf	02/09/2019 09:19:53	Cintia Nasi	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_ENF_ACAO.pdf	02/09/2019 09:18:58	Cintia Nasi	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de	TCLEUSUARIOFAMILIA.pdf	19/03/2019 17:24:07	Cintia Nasi	Aceito

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



UFRGS - PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL / PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 3.578.583

Ausência	TCLEUSUARIOFAMILIA.pdf	19/03/2019 17:24:07	Cintia Nasi	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLEPROFISSIONAIS.pdf	19/03/2019 17:23:50	Cintia Nasi	Aceito
Cronograma	cronogramaProjeto.pdf	19/03/2019 17:23:11	Cintia Nasi	Aceito
Outros	Termo_cienciaGDNEB.PDF	20/12/2018 22:17:41	Cintia Nasi	Aceito
Declaração de Pesquisadores	termocintia.pdf	12/12/2018 11:46:55	Cintia Nasi	Aceito
Folha de Rosto	FolhadeRosto.pdf	12/12/2018 11:45:04	Cintia Nasi	Aceito
Orçamento	orcamentoProjeto.pdf	12/12/2018 09:24:13	Cintia Nasi	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 16 de Setembro de 2019

Assinado por:

MARIA DA GRAÇA CORSO DA MOTTA
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 317 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br

Página 05 de 05

Revisão de Escopo

Silva FM, Nasi C, Fiorini AL
Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

Mental Health Nursing Actions in Primary Health Care: Scope Review

Acciones de Enfermería en Salud Mental en la Atención Primaria de Salud: Revisión de Alcance

RESUMO

Objetivo: Identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde. **Método:** Será conduzida uma revisão de escopo, seguindo o referencial do *Joanna Briggs Institute* e pelo protocolo PRISMA-ScR, com o objetivo de responder à questão: "Quais são as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde?" nas bases de dados LILACS, BVS, Medline e BDNF. **Resultados:** Foram incluídos 20 estudos na revisão. As ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS foram classificadas em duas categorias: Ações de cuidado enfermeiro-paciente e Desafios das ações de Saúde Mental. Exibição do fluxograma construído. **Conclusão:** Espera-se que a *scoping review* contribua em âmbito científico e assistencial para a construção do conhecimento na área da saúde e da enfermagem a partir da análise crítica das ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde.

DESCRIPTORES: Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental

ABSTRACT

Objective: Identify and map mental health actions developed by nurses in Primary Health Care. **Methods:** A scoping review will be conducted, following the Joanna Briggs Institute framework and the PRISMA-ScR protocol, with the aim of answering the question: "What are the mental health actions developed by nurses in Primary Health Care?" in the LILACS, BVS, Medline and BDNF databases. **Results:** 20 studies were included in the review. The mental health actions developed by nurses in PHC were classified into two categories: Nurse-patient care actions and Challenges of Mental Health actions. Display of the constructed flowchart. **Conclusion:** It is expected that the scoping review will contribute in a scientific and care context to the construction of knowledge in the area of health and nursing based on the critical analysis of mental health actions developed by nurses in Primary Health Care.

DESCRIPTORS: Primary Health Care; Nursing; Mental Health

RESUMEN

Objetivo: Identificar y mapear acciones de salud mental desarrolladas por enfermeros en la Atención Primaria de Salud. **Métodos:** Se realizará una revisión de alcance, siguiendo el marco del Instituto Joanna Briggs y el protocolo PRISMA-ScR, con el objetivo de responder a la pregunta: "¿Cuáles son las acciones de salud mental que desarrollan las enfermeras en Atención Primaria de Salud?" en las bases de datos LILACS, BVS, Medline y BDNF. **Resultados:** Se incluyeron 20 estudios en la revisión. Las acciones de salud mental desarrolladas por los enfermeros en la APS fueron clasificadas en dos categorías: acciones de atención enfermero-paciente y acciones de Desafíos de la Salud Mental. Visualización del diagrama de flujo construido. **Conclusión:** Se espera que la revisión del alcance contribuya en un contexto científico y asistencial a la construcción de conocimiento en el área de salud y enfermería a partir del análisis crítico de las acciones de salud mental desarrolladas por los enfermeros en la Atención Primaria de Salud.

DESCRIPTORES: Atención Primaria de Salud; Enfermería; Salud Mental

RECEBIDO EM: 18/06/2025 APROVADO EM: 10/07/2025

Como citar este artigo: Silva FM, Nasi C, Fiorini AL. Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo. *Saúde Coletiva* (Edição Brasileira) [Internet]. 2025 [acesso ano mês dia];15(98):16626- 16647. Disponível em: DOI: 10.36489/saudecoletiva.2025v15i98p16626- 16647

ID Francine Moraes da Silva
Mestre em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9226-7663>

ID Cíntia Nasi
Doutora em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4322-3701>

ID Alice Lena Fiorini
Acadêmica de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9311-6433>

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como o primeiro nível assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada o centro articulador de acesso à comunidade às Redes de Atenção em Saúde (RAS), orientada pelos princípios de acessibilidade, integralidade, coordenação do cuidado e espaço potente para desenvolvimento de programas e ações, considerando as reais necessidades de saúde dos usuários e suas famílias.⁽¹⁾

As principais estruturas físicas da APS são as unidades de saúde (US) instaladas próximas às comunidades, isto é, desempenham papel central na garantia de acesso aos usuários e suas famílias a uma saúde pública de qualidade. As US ofertam à comunidade serviços diversos, entre eles: acolhimento de demandas, consultas médicas e de enfermagem, educação em saúde, espaço de promoção de saúde mental, dentre outros.^(2,3)

As US proporcionam a mobilização de recursos institucionais e comunitários para o enfrentamento aos problemas relacionados à saúde mental, além de articular saberes técnicos e populares ao cuidado à essa clientela.⁽⁴⁾ O cuidado em saúde mental no território proporciona à pessoa em sofrimento psíquico e suas famílias a possibilidade de reinserção aos espaços de vida cotidiana, ofertando maior inserção e aceitação dos usuários na comunidade.⁽¹⁾

Tendo em vista que a APS se constitui como plano privilegiado para o cuidado em saúde mental no território, os enfermeiros, atuantes desse serviço,

necessitam ampliar seu olhar para além da saúde física e reconhecer a saúde mental como indissociável de qualquer contexto e ação realizada. Faz-se necessário aprimorar sua prática de trabalho, incluindo a família com fator indispensável para o cuidado em saúde mental.⁽⁵⁾

Ao envolver as famílias, o enfermeiro promove o cuidado em saúde mental integral, possibilitando que essas famílias encontrem sentido para a vivência de seus próprios sofrimentos, ampliando seus conhecimentos a respeito do sofrimento psíquico de seu familiar-cuidador, além de desenvolverem habilidades no contexto de cuidar.⁽⁶⁾ Nesse sentido, torna-se essencial a construção de uma parceria enfermeiro-família para potencializar o cuidado em saúde mental, mas para tanto, torna-se pertinente identificar as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS.⁽⁷⁾

Nesse sentido, com o intuito de identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS, define-se como questão norteadora: *Quais são as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde?*

Essa pesquisa torna-se relevante e tem como propósito oferecer subsídios para a construção do conhecimento na área da saúde e da enfermagem a partir da análise crítica das ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS.

Assim, essa pesquisa permitirá um olhar mais aprofundado sobre as práticas atuais, desafios enfrentados e estratégias eficazes no cuidado à saúde mental no contexto da APS.

Ao analisar as ações desenvolvidas

por enfermeiros no referido campo de atuação a nível primário, essa pesquisa visa identificar as potencialidades no cuidado à pessoa em sofrimento psíquico e suas famílias promovendo um entendimento mais claro das dinâmicas envolvidas no cuidado à essa clientela. Espera-se que esse estudo possa proporcionar insights valiosos que impulsionem a formulação de políticas, a prática de cuidado em liberdade e a educação profissional, contribuindo para um atendimento mais eficaz e humanizado.

Além disso, ao destacar as limitações e desafios, essa pesquisa visa sugerir direções para a implementação de melhorias, como a necessidade de mais formação específica em saúde mental para enfermeiros e a importância de abordagens integradas e colaborativas no cuidado. A identificação de boas práticas e a análise crítica das ações realizadas são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover o cuidado em saúde mental centrado nos princípios do SUS e no cuidado em liberdade preconizado pela Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Em última análise, essa pesquisa busca promover um avanço no conhecimento e na prática da saúde mental na APS, apoiando a construção de um sistema de saúde mais inclusivo e efetivo. Através da análise crítica e da reflexão sobre as práticas atuais, espera-se contribuir para a melhoria contínua da qualidade do cuidado e o fortalecimento da saúde mental no nível primário de atenção.

O objetivo dessa revisão de escopo consiste em identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas

Revisão de Escopo

Silva FM, Nasi C, Fiorini AL
Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

por enfermeiros na APS. Esse mapeamento permitirá identificar as práticas e estratégias empregadas, os desafios enfrentados, as potencialidades observadas e as lacunas existentes no cuidado em saúde mental oferecido nesse nível de atenção.

MÉTODO

O estudo configura-se como uma revisão de escopo a qual seguiu as orientações do Preferred Reporting items for Systematic Reviews and meta-analysis extension for scoping reviews⁽⁸⁾, elaborada de acordo com o referencial teórico disponibilizado pelo Joanna Briggs Institute (JBI)⁽⁹⁾ utilizando a estratégia PCC (acrônimo de P: População = Enfermeiros, C: Conceito = Ações em Saúde Mental, C: Contexto = Atenção Primária à Saúde), com a questão norteadora: Quais são as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Primária à Saúde? O protocolo de pesquisa foi registrado no Open Science Framework, com identificação do doi:10.17605/OSF.IO/TEWVZ.

Esse tipo de revisão permite explorar as principais evidências científicas, identificar e mapear possíveis lacunas e propor estudos futuros. Buscou-se realizar uma análise com objetivo de propagar conhecimentos acerca do tema das ações em saúde mental na APS.⁽⁹⁾ As buscas foram realizadas de abril a julho de 2024. Os critérios de inclusão foram: publicações disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês, português e espanhol, nos últimos 10 anos. Foram excluídos estudos do tipo opinião, carta ao editor, editoriais, utilizando-se as palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Enfermagem, Saúde Mental e Família nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline), Banco de Dados em Enfermagem – Bibliografia Brasileira (BDENF). A busca conside-

rou documentos da literatura cinzenta como Google Acadêmico (apenas as 05 primeiras páginas). Para adequação às demais bases de dados e plataformas foram também utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) para as bases em português: Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família e Medical Subject Heading (MESH): Primary Health Care, Nursing, Mental Health, Family, para as bases em inglês.

A primeira etapa da pesquisa foi realizada na BVS, para análise das palavras contidas no título e no resumo, com a utilização das seguintes palavras-chave: “Primary Health Care”, “Nursing”, “Mental Health”, “Family” que eram potencialmente elegíveis, para responder à questão e abordavam os elementos do PCC: População = Enfermeiros, C: Conceito = Ações em Saúde Mental, C: Contexto = Atenção Primária à Saúde. Para a continuidade da seleção e recuperação dos textos completos, foi gerada uma planilha Excel^a, a partir do Rayyan do *Qatar Computing Research Institute* (QCRI)⁽¹⁰⁾, onde foram extraídos os seguintes dados: título, autores, objetivo e metodologia. Na segunda etapa, os estudos foram identificados por meio de estratégia de busca adap-

tada para cada base eletrônica de dados (Quadro 1). Somando-se os descritores com os termos booleanos: AND, OR para compor as chaves de busca. Nessa etapa houve a leitura do texto completo de todos os artigos selecionados e foram excluídos os estudos que não cumpriam os critérios de inclusão do estudo (Figura 1).

A análise do conteúdo deu-se a partir da leitura atenta e detalhada dos estudos, que foram agrupados conforme suas semelhanças, emergindo dois temas que atendiam ao objetivo desta revisão de escopo. O método de tratamento e o resumo dos dados foram mapeados conforme a temática e seguiram as determinações do PRISMA-ScR.

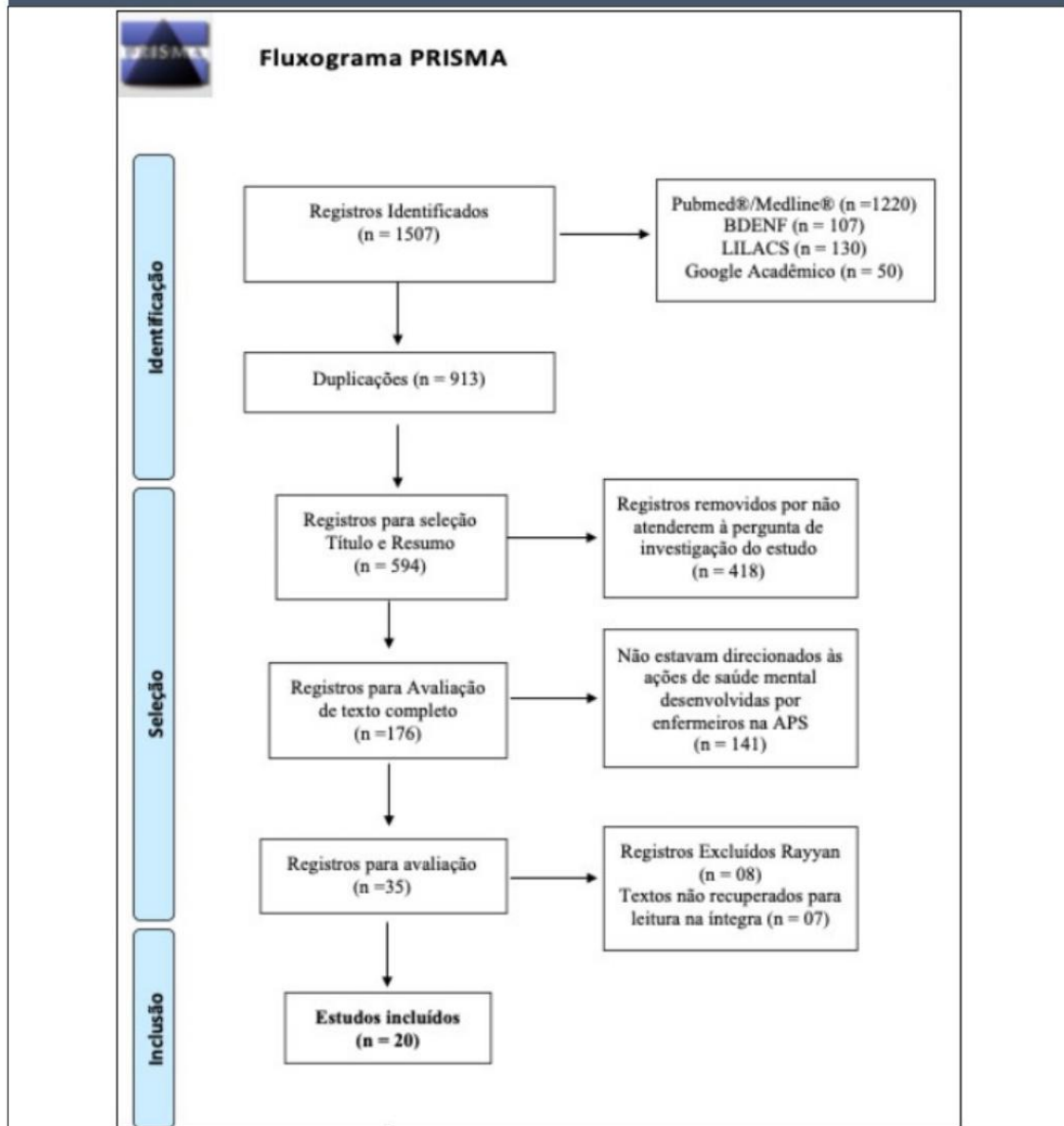
Por se tratar de uma revisão de escopo, não houve submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pois foram utilizados, como fonte de dados, documentos com acesso aberto (artigos, consensos e recomendações), garantindo-lhes a especificação de autoria para salvaguardar a propriedade intelectual. Este estudo respeita a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998⁽¹⁰⁾, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais e dá outras providências.

Quadro 1. Estratégias de busca por base de dados. Porto Alegre, 2024.

Bases	Estratégia de Busca
Medline/PubMed	(Primary Health Care) AND (nursing) AND (Mental Health) AND (Family)
LILACS BDENF	Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família
Google Acadêmico	Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Saúde Mental; Família

As etapas de seleção dos estudos foram realizadas de acordo fluxograma de revisão do escopo (PRISMA - ScR), conforme a Figura 1.

Figura 1. Diagrama de fluxo do processo de seleção dos artigos da revisão, PRISMA-ScR.



Fonte: Perters et al.⁽⁹⁾

RESULTADOS

Nessa revisão de escopo foram encontradas 1507 publicações, após ava-

liação, 20 contemplaram os critérios de inclusão do estudo.

Para a apresentação dos estudos selecionados, foi gerada uma planilha no Excel®, na qual foram extraídos os dados

que seguem: título, autores, objetivo e metodologia. Assim, os resultados estão descritos no Quadro 2.

Revisão de Escopo

Silva FM, Nasi C, Fiorini AL
Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

Quadro 2. Artigos incluídos na revisão de escopo, considerando: título, autores, objetivo e metodologia. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, 2024.

Nº artigo	Título	Autor	Objetivo	Metodologia
01	Atitudes de enfermeiros frente ao envolvimento da família nos cuidados à pessoa com transtorno mental	Nóbrega et al. ⁽¹²⁾	Caracterizar as atitudes dos enfermeiros, de APS, quanto ao envolvimento da família nos cuidados às pessoas com transtorno mental.	Estudo correlacional, com 257 enfermeiros do município de São Paulo. Utilizou-se a escala "Importância das Famílias nos Cuidados de Enfermagem-Atitudes dos Enfermeiros". A análise foi realizada com recurso de estatística descritiva e inferencial.
02	Saúde mental: representações sociais dos enfermeiros da estratégia saúde da família	Tavares et al. ⁽¹³⁾	Compreender as representações sociais dos enfermeiros das Estratégias Saúde da Família (ESF) sobre a Saúde Mental na APS e analisar as implicações dessas representações sociais no cuidado de pessoas acometidas de doença mental.	Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando o referencial teórico e metodológico da Teoria das Representações Sociais.
03	Usuários de substâncias psicoativas: desafios à assistência de enfermagem na Estratégia Saúde da Família	Militão et al. ⁽¹²⁾	Analisar a assistência de Enfermagem ao usuário de substâncias psicoativas na ESF.	Estudo descritivo e qualitativo realizado com sete enfermeiros da ESF de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas guiadas por um roteiro semiestruturado e a Análise Temática de Conteúdo foi utilizada para o seu tratamento.
04	Assistência em saúde mental na Atenção Primária: perspectiva dos profissionais da Estratégia Saúde da Família	Cardoso et al. ⁽¹³⁾	Apreender as percepções dos profissionais que atuam na APS sobre a assistência em saúde mental.	Estudo descritivo, qualitativo, realizado com 29 profissionais de saúde, mediante entrevistas abertas e individuais. Adotou-se o <i>software</i> IRaMuTeQ® para organização dos dados, após a qual foram submetidos ao processo de análise de conteúdo de modalidade temática.
05	A percepção dos profissionais sobre as ações de saúde mental na rede de atenção psicossocial em Belo Horizonte	Coelho et al. ⁽¹⁴⁾	Compreender a construção das ações de saúde mental na rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte, sob a ótica dos profissionais em uma perspectiva histórica.	Trata-se de uma abordagem qualitativa baseada na história oral, fundamentada na Sociologia Compreensiva do Cotidiano.
06	O cuidado aos portadores de sofrimento mental na atenção primária: uma prática interdisciplinar e multiprofissional	Almeida et al. ⁽¹⁵⁾	Conhecer como é realizado o cuidado ao Portador de Transtorno Mental (PTM) nas ESF, verificando se os profissionais estão seguros da sua atuação.	Trata-se de um estudo qualitativo, embasado na análise do discurso, realizado nas ESF de uma cidade da região norte de Minas Gerais; a coleta de dados realizou-se através de um roteiro de entrevista semiestruturada.
07	Práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Estratégia Saúde da Família	Silva Filho et al. ⁽¹⁶⁾	Compreender as práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros no âmbito da ESF.	Pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa. Participaram do estudo 10 enfermeiros atuantes nas ESF de um município da região Centro-Sul do Estado do Ceará.
08	Saúde mental na atenção básica: atuação do enfermeiro na rede de atenção psicossocial	Nunes et al. ⁽¹⁶⁾	Descrever e analisar a atuação do enfermeiro especialista em saúde mental na ESF.	Estudo qualitativo, com 20 enfermeiros que atuam nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) de Teresina, Piauí. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas no período de março a maio de 2017 e analisadas pelo método de análise de conteúdo.
09	Estratégia saúde da família: ações no campo da saúde mental	Silva et al. ⁽¹⁷⁾	Analisar as atividades de atenção à saúde mental desenvolvidas por equipes de uma UBSF em Fortaleza, Ceará, Brasil.	Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi realizada entre abril e maio de 2013, através de entrevista semiestruturada, com sete profissionais da ESF. Utilizou-se para tratamento dos dados a análise de conteúdo.
10	Saúde mental na Estratégia Saúde da Família: a percepção dos profissionais	Souza et al. ⁽¹⁸⁾	Analisar o manejo das necessidades de saúde mental na APS de acordo com a percepção dos profissionais da ESF.	Estudo qualitativo, descritivo exploratório, desenvolvido no território de abrangência de cinco equipes de saúde da família. Os participantes foram cinco enfermeiras, cinco coordenadores e 17 agentes comunitários de saúde. Os dados foram coletados utilizando observação, entrevistas grupais, entrevistas individuais semiestruturadas e grupos focais. Fez-se a análise de conteúdo com o auxílio de um Software de análise textual, e a interpretação baseou-se nas estruturas analíticas correspondentes.

Revisão de Escopo

Silva FM, Nasi C, Fiorini AL
Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

11	Saúde mental no trabalho do Enfermeiro da Atenção Primária de um município no Brasil	Maia et al. ⁽¹⁹⁾	Compreender como se desenvolve a preparação e qual o conhecimento que os enfermeiros que atuam na ESF de Montes Claros - Minas Gerais apresentam sobre Saúde Mental para atendimento a pacientes com transtornos psíquicos.	Pesquisa qualitativa e exploratória, realizada com oito enfermeiros que atuavam na APS do meio urbano de Montes Claros. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2011, por meio de entrevistas, que foram gravadas e, em seguida, transcritas. Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise do conteúdo.
12	A situational analysis of primary health care centers in Brazil: challenges and opportunities for addressing mental illness and substance use-related stigma.	Bobbili et al. ⁽²⁰⁾	Analysis are twofold: (1) to understand the current mental health and substance use service delivery context and (2) identify challenges and opportunities for addressing MISUP-related stigma in PHC centers in Ribeirão Preto, Brazil.	Environmental scans of four Family Health Units were conducted in early 2018 to explore population needs and service delivery for individuals with MISUP. In addition, a symposium was organized in October 2018 to consult with diverse stakeholders and gather local perspectives about MISUP-related stigma conveyed in PHC settings. NVivo 12 software was used to conduct a thematic analysis of the qualitative data collected from the environmental scans and the symposium consultation.
13	Factors Associated With Primary Family Caregivers' Perceptions on Quality of Family-Centered Care in Mental Health Practice	Hsiao et al. ⁽²¹⁾	This study aimed to examine the quality of family-centered care perceived by primary family caregivers and its influencing factors in mental healthcare practice.	A convenience sample of 121 mental health nurses and 164 primary family caregivers of patients with schizophrenia was recruited from acute psychiatric wards and chronic psychiatric rehabilitation wards in three psychiatric hospitals in Taiwan. Structured questionnaires for mental health nurses were designed to examine nurses' attitudes toward schizophrenia and the importance of families in nursing care. Primary family caregivers were assessed to determine their perceptions of quality of family-centered care. At least one primary family caregiver of patients was matched to a nurse who took major responsibility for the patient during the hospitalization. Data were analyzed with descriptive statistics, Pearson's product-moment correlations, independent t-test, one-way analysis of variance, and stepwise regression analyses.
14	Saúde mental na atenção primária: processo saúde-doença, segundo profissionais de saúde	Barros et al. ⁽²²⁾	Analisar percepções da equipe de profissionais da ESF sobre o processo saúde-doença mental e identificar ações de saúde desenvolvidas pela equipe para pessoas com transtorno mental.	Estudo qualitativo, de referencial teórico marxista e método dialético. Participaram 99 profissionais de nível médio e superior da ESF, município de São Paulo. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas, cujos dados foram submetidos ao software ALCESTE e Análise de Conteúdo Temática.
15	A percepção e a prática dos profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre a Saúde Mental	Pereira et al. ⁽²³⁾	Conhecer a percepção e a prática dos profissionais sobre a Saúde Mental na APS para contribuir no esclarecimento das dificuldades percebidas.	Trata-se de um estudo transversal qualitativo em profissionais das equipes de ESF de Itumbiara, Goiás, Brasil, por meio de questionário semiestruturado, sendo realizada análise de conteúdo conforme técnica de Bardin.
16	Práticas em saúde mental na estratégia saúde da família: um estudo exploratório	Lima et al. ⁽²⁴⁾	Conhecer os procedimentos, as ações e condutas adotadas em saúde mental no âmbito da atenção básica.	Pesquisa qualitativa exploratória desenvolvida com duas equipes da ESF, em Juazeiro do Norte, Ceará, entre maio e junho/2009, através da observação não participante e de entrevistas semiestruturadas.
17	O processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental: análise reflexiva	Nascimento et al. ⁽²⁵⁾	Refletir acerca do processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental, de qualquer natureza, da população ESF.	Realizada uma reflexão voltada para o processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental da população da ESF.
18	Atenção à saúde mental na atenção primária de saúde: uma revisão sistemática	Sterling et al. ⁽²⁶⁾	Verificar evidências científicas referentes à atenção à saúde mental na APS.	A busca por artigos científicos foi conduzida por dois pesquisadores independentes nas bases de dados Medline (Pubmed), LILACS, SciELO, Bireme, Web of Science e Scopus, sem restrição de idioma, período e localização. Foram incluídos na pesquisa estudos que obtiveram pontuação ≥ 6 pontos segundo o protocolo.

Revisão de Escopo

Silva FM, Nasi C, Fiorini AL
Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

19	Concepções e intervenções em saúde mental na ótica de Profissionais da estratégia saúde da família	Drescher et al.(27)	Compreender as percepções de profissionais da saúde vinculados às ESF sobre doença mental e acerca do atendimento a pessoas em sofrimento psíquico.	Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, no qual participaram nove profissionais de saúde vinculados a duas equipes com Estratégia de Saúde da Família de um município do Norte do Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados de acordo com a Técnica de Análise de Conteúdo, na modalidade análise temática.
20	Saúde Mental na atenção primária: desafios para a resolutividade das ações	Rotoli et al.(28)	Identificar os desafios enfrentados pelos profissionais para agregar resolutividade às ações de saúde mental desenvolvidas no âmbito da APS.	Estudo qualitativo realizado com 30 profissionais, sendo 17 enfermeiras, quatro médicos, cinco psicólogos e quatro assistentes sociais. Dados coletados em três municípios do Rio Grande do Sul, Brasil, em abril de 2018 através de entrevistas semiestruturadas, posteriormente submetidos à análise temática.

DISCUSSÃO

Essa revisão de escopo teve como propósito identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS. Apesar dos estudos selecionados estarem limitados a APS, foi possível encontrar ações de desenvolvidas por enfermeiros, além de explorar as relações enfermeiro-paciente, que no campo da APS, essa relação estende-se também aos familiares e comunidade, ou seja, uma das ações fundamentais é a relação de cuidado enfermeiro-paciente. Com isso, estrutura-se a primeira categoria, que se segue abaixo.

Ações de cuidado enfermeiro-paciente na Atenção Primária em Saúde

A APS configura-se como um espaço potente para o desenvolvimento de programas e ações, uma dessas ações, direcionadas para o campo da saúde mental e atenção psicossocial, à pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador, ao buscar suporte para atendimento na APS, carrega consigo um arsenal de experiências vividas e expectativas em relação ao seu atendimento, isto é, arsenal composto por um histórico único de experiências prévias, podendo incluir episódios anteriores de tratamento favoráveis e desfavoráveis, estigmatização, desafios pessoais e familiares.^(1,17)

Nesse sentido, compreender esse arsenal de vivências da pessoa em sofrimento psíquico e suas famílias, torna-se essencial para ofertar um acolhimento personalizado e sensível em relação às

demandas em saúde mental apresentadas, ou seja, permitir que pacientes e suas famílias expressem suas expectativas, ajuda o profissional a entender as motivações para a busca desse atendimento na APS, além de construir uma relação de confiança.⁽¹⁴⁾

Essa relação caracteriza-se por ser baseada na comunicação aberta, apoio emocional tendo como pilares essenciais a educação e colaboração de ambos envolvidos. Esse relacionamento é fundamental para garantir um cuidado eficaz, respeitoso e centrado no paciente e suas famílias, promovendo seu bem-estar mental e emocional, ou seja, essa relação caracteriza-se como componente central para a eficácia do cuidado e pode impactar nos resultados de saúde dos envolvidos. Uma relação de qualidade entre enfermeiro-paciente e seu familiar-cuidador na APS não apenas melhora a experiência do paciente, mas também pode levar a melhores resultados de saúde e maior satisfação com o cuidado recebido.⁽¹³⁾

Destaca-se alguns aspectos que são componentes chave dessa relação como: confiança e vínculo como dispositivo central para o compartilhamento de informações, sentimentos e preocupações lançando mão de uma comunicação aberta, com honestidade e suporte às necessidades do indivíduo e seu familiar-cuidador. Outros componentes primordiais para alicerçar essa relação são a escuta ativa e a empatia pelo sofrimento do próximo afim de validar as queixas trazidas, acolhê-las com propósito de ofertar apoio a situação descrita pelo pa-

ciente e suas famílias.⁽¹⁶⁾

Nesse contexto, a escuta qualificada com clareza e simplicidade afim de elucidar diagnósticos, tratamentos e planos de cuidado, proporciona a melhor compreensão do paciente e suas famílias para que ambos possam participar ativamente do processo de cuidado instituído, para que obtenham entendimento necessário e concordem com as ações instituídas a fim de instrumentalizar o paciente a tomar decisões sobre seu próprio cuidado e promover sua autogestão como dispositivo crucial para o empoderamento sobre sua saúde.⁽¹⁶⁾

Diante disso, auxiliar o paciente a promover sua autonomia diante das mais variadas ações cotidianas, o instrumentaliza a sentir-se pertencente à sociedade, ou seja, incentivá-lo a gerenciar suas expectativas de maneira realista sobre seu tratamento em saúde, a fim de ajudá-lo a lidar com os anseios que a vida cotidiana proporciona.⁽⁴⁾

O enfermeiro nesse processo de cuidado, ao incluir às famílias, ao elucidar o plano de cuidados instituídos ao paciente, minimiza anseios do familiar-cuidador, isto é, integra-o ao processo de cuidado e esclarece eventuais dúvidas e acaba por fortalecer o vínculo enfermeiro-paciente-família e comunidade.^(22, 25)

Assim, ao estimular a participação ativa do paciente e suas famílias no plano de cuidado instituído, ajuda a garantir que as intervenções sejam relevantes e alinhadas com as necessidades e preferências apresentadas, ou seja, nesse processo, é importante que o Enfermeiro reconheça e considere as especificida-

des culturais, sociais e pessoais de cada paciente e seu contexto familiar, os ajudando a fornecer um cuidado mais individualizado e eficaz de acordo com suas necessidades em saúde.⁽⁶⁾

Nesse sentido, ao ajustar o plano proposto, tendo em vista a necessidade de flexibilização diante das mais variadas situações da vida cotidiana do paciente e suas famílias, proporciona fortalecimento do vínculo enfermeiro-paciente e garante maior eficácia no tratamento proposto e maior engajamento do paciente e suas famílias no processo de cuidado instituído.^(6,21)

Em suma, essas ações são fundamentais para garantir um atendimento holístico e integrado na APS, ajudando a promover o bem-estar mental e a qualidade de vida do paciente e seu familiar-cuidador.^(15,26)

Contudo, todas ações apontadas, exigem do profissional Enfermeiro um arsenal de ferramentas que nem sempre os profissionais da APS as dispõem, por uma série de fatores desafiantes, dentre esses, certa resistência e medo em assistir a pessoa em sofrimento psíquico, além de pouco arcabouço teórico para absorver as demandas de saúde mental no território, estigmas relacionados à pessoa em sofrimento psíquico, conhecimento ineficiente da rede de atenção psicossocial, entre outros.⁽²⁵⁾ Diante do exposto, estrutura-se a próxima categoria que se segue abaixo.

Desafios das ações de Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde

Ao final do ano 1989, tramitava no Congresso Nacional o projeto de Lei que resultou, 12 anos depois, na lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. A referida lei reformulou, criou condições e instituiu novas formas de cuidar do indivíduo em sofrimento mental, visando sua inclusão na sociedade e protagonizou uma nova forma de pensar sobre a saúde mental e cuidado em liberdade.^(29,30)

Em 2011 foi instituída a RAPS, pela Portaria GM/ MS no 3.088 de 23 de dezembro de 2011,⁽³¹⁾ que tem por ob-

jetivo principal a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em seus diferentes níveis de complexidade; promoção do acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção.^(29,31)

Nesse sentido, historicamente, os territórios caracterizam-se como espaços privilegiados para que às equipes da APS construam um processo de trabalho territorial, prestando assistência às necessidades de saúde apresentadas, inclusive absorvendo as demandas em saúde mental existentes. No entanto, cabe salientar, que as ações em saúde mental devem ser construídas em equipe, pautadas nas necessidades em saúde apresentadas pelas comunidades e alicerçadas no cuidado em liberdade com a manutenção do vínculo enfermeiro-paciente e seu familiar-cuidador.^(17,24)

Sabe-se que o enfermeiro, no campo da APS, é o profissional que atua nos mais diversos dispositivos da rede de atenção psicossocial, ocupando importante papel nos cuidados à população adstrita. No entanto, sabe-se que o atendimento à saúde mental se torna um desafio ao enfermeiro da APS, exigindo não apenas habilidades técnicas e conhecimento especializado, mas também requer um arsenal de ferramentas a fim de lidar com as especificidades da área, bem como com o estigma vivenciado pela pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador.⁽²⁰⁾

Nesse sentido, em um estudo conduzido com profissionais da APS, em uma ESF, apontam desafios como: a incapacidade em absorver as demandas em saúde mental existentes no território, falta de conhecimento da RAPS, estigma imposto pela sociedade em relação à loucura, receio no contato com paciente em sofrimento psíquico, incompreensão de como realizar o cuidado em saúde mental e o pouco conhecimento teórico na área como barreiras apontadas na referida pesquisa. O entrave principal aponta a necessidade de intervenções

efetivas de educação permanente.^(19,23)

Diante do exposto, pacientes em sofrimento psíquico acabam por atrair o olhar dos profissionais atuantes da APS pela ótica do estigma e preconceito, acabando por gerar barreiras e entraves no acesso à essa referida população. Na APS, em seu contexto, cuidados adequados, acolhimento e manejos apropriados, tornam-se fundamentais. No entanto, torna-se primordial ações conjuntas e articuladas de acordo com as demandas apresentadas, e caso não seja possível, é imprescindível conhecimento da rede de atenção psicossocial para que os encaminhamentos sejam realizados, para que paciente e seu familiar-cuidador possam sanar suas necessidades de atendimento com maior resolutividade.⁽²⁸⁾

Para que o profissional saiba o melhor encaminhamento a ser realizado, torna-se necessária capacitação das equipes da APS, para que saibam lidar com os anseios trazidos pela pessoa em sofrimento psíquico e seus familiares, uma vez que o cuidado em saúde mental acaba por gerar frustração, diferentemente, do cuidado clínico que busca a cura efetiva da comorbidade apresentada, que no caso da saúde mental, esse cuidado torna-se diferente, pois muitas vezes não é factível, podendo levar a sentimentos como impotência, autodepreciação e culpa.⁽²⁴⁾

Entretanto, em saúde mental, o objetivo pode não ser necessariamente a "cura" no sentido absoluto, mas sim proporcionar um tratamento eficaz, promover a recuperação e ajudar os pacientes a viverem de maneira saudável e significativa.⁽¹²⁾

Nesse sentido, o cuidado em saúde mental no território tem caráter multifacetado, isto é, para que o profissional consiga absorver as demandas existentes, precisa sentir-se capacitado para tal. Assim, ações como a educação permanente em saúde se fazem necessárias. A educação permanente em saúde mental é essencial para melhorar a prática profissional, proporcionar um atendimento de qualidade e promover a recuperação e

Revisão de Escopo

Silva FM, Nasi C, Fiorini AL
Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

o bem-estar dos pacientes.⁽²³⁾

Em suma, desafios são inerentes ao processo de trabalho do enfermeiro na APS, contudo, afim de superar esses desafios como forma de amenizar os obstáculos vivenciados, afim de ofertar atendimento de qualidade e com caráter resolutivo, ações como: expansão dos espaços para discussões de casos, investimento em ações de matriciamento, capacitações em ações de saúde mental e melhor conhecimento da rede de atenção psicossocial são essenciais, para que os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica possam ser seguidos, sem faltar a motivação dos profissionais que atendem pacientes em sofrimento psíquico e suas famílias nos territórios e comunidades.^(25, 28)

Limitações do Estudo

Este trabalho também identifica limitações relacionadas à escolha dos componentes da rede de atenção e sugere a necessidade de uma abordagem mais abrangente que inclua posteriormente os usuários dos serviços. Estes são atores essenciais para a integração das práticas e conhecimentos em saúde. Portanto, recomenda-se a realização de estudos adicionais que considerem os diversos níveis de assistência no município, a gestão da assistência e as especificidades do cuidado em saúde mental, a fim de otimizar a rede de atenção e promover uma integração mais eficaz dos serviços.

Contribuições para a Área

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir com o aprofundamento da compreensão dessa temática, contribuindo em âmbito científico e assistencial para a construção do conhecimento na área da saúde e da enfermagem, colaborando para o cuidado em saúde mental no território. Nesse sentido, partindo da implicação como enfermeira, pesquisadora e futura docente de Enfermagem, a confecção desse projeto de doutorado tem por finalidade a produção de conhecimento na área da saúde mental.

CONCLUSÃO

Esse estudo teve como propósito identificar e mapear as ações em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na APS. Pode-se perceber que inúmeras ações em saúde mental são desenvolvidas no campo da APS, como supracitado acima. Tais ações tornam-se essenciais a fim de garantir um cuidado acessível, eficaz e centrado na pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador.

Entretanto, durante a jornada profissional, o enfermeiro acaba por vivenciar desafios e obstáculos associados ao cuidado de pessoas com sofrimento psíquico e suas famílias exigindo desse profissional uma abordagem integrada, com formação adequada e colaboração entre diferentes profissionais e diversos serviços existentes na rede atenção psicossocial. A superação desses desafios é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover o cuidado em saúde mental centrado nos princípios do SUS e no cuidado em liberdade preconizado pela Reforma Psiquiátrica Brasileira.

É fato que com esse estudo, a discussão sobre o tema não é esgotada. Cabe ressaltar que apesar do enfermeiro ser um profissional que pode atuar nos mais diferentes níveis de atenção, a saúde mental transpassa por todas as áreas de atuação. É natural enfrentar desafios, conhecer as limitações no cuidado à essa clientela tão específica, contudo, ações em educação em saúde se tornam necessárias, a fim de instrumentalizar o profissional que atua no primeiro nível de atenção, existindo e coexistindo próximo às comunidades.

Os enfermeiros enfrentam desafios substanciais ao lidar com pacientes que sofrem de transtornos mentais, incluindo a necessidade de adaptar suas práticas às especificidades e complexidades dos casos, lidar com a estigmatização e garantir uma adesão eficaz ao tratamento. Além disso, é fundamental reconhecer e respeitar as limitações

no cuidado, abordando as lacunas existentes e trabalhando para superá-las.

Para enfrentar esses desafios e melhorar a qualidade do atendimento, a implementação de ações educativas em saúde mental se torna essencial. A educação permanente em saúde para os profissionais da APS é uma ferramenta indispensável para aprimorar o entendimento sobre os transtornos mentais, desenvolver habilidades de manejo e fortalecer a capacidade de oferecer um cuidado centrado nas necessidades apresentadas pelo paciente.

A educação em saúde caracteriza-se por contemplar não apenas a atualização sobre novas práticas e evidências, mas também estratégias para lidar com as questões emocionais e comportamentais dos pacientes e suas famílias. Programas de formação devem incluir a promoção de habilidades interpessoais, o manejo de crises e o desenvolvimento de estratégias para melhor adesão ao tratamento.

Além disso, é crucial fomentar a educação e a conscientização nas comunidades para reduzir o estigma associado aos transtornos mentais e promover um ambiente de suporte e compreensão. A integração de práticas profissionais e a colaboração interprofissional também são componentes chave para a melhoria contínua do cuidado.

Em suma, o cuidado em saúde mental exige um compromisso contínuo com a educação e o aprimoramento profissional, bem como a implementação de estratégias eficazes para superar os desafios encontrados. O enfermeiro, ao desempenhar um papel ativo e informativo, contribui significativamente para a promoção da saúde mental e para a criação de um sistema de cuidado mais inclusivo e eficaz. Acredito que suas ações primordiais são a escuta e acolhimento capazes de amenizar as angústias e sofrimentos da pessoa em sofrimento psíquico e seu familiar-cuidador.

REFERÊNCIAS

1. Oliveira EC, Medeiros AT, Trajano FMP, Chaves Neto G, Almeida SA, Almeida LRO. O cuidado em saúde mental no território: concepções de profissionais da atenção básica. *Esc Anna Nery*. 2017;21(3):1-7.
2. Giovanella L, Bousquat EM, Schenkman S, Almeida PF, Sardinha LMV, Vieira MLFP. Cobertura da Estratégia Saúde da Família no Brasil: o que nos mostram as Pesquisas Nacionais de Saúde 2013 e 2019. *Ciênc. Saúde Colet*. 2021;26(supl. 1):2543-56.
3. Tavares JH, Silva SD, Pinheiro EPF, Vasconcelos JS, Rodrigues DP, Oliveira MA. Saúde mental: representações sociais dos enfermeiros da estratégia saúde da família. *Rev Pesqui: Cuid. Fundam Online*. 2023;15:e11984.
4. Nunes VV, Feitosa LGGC, Fernandes MA, Almeida CAPL, Ramos CV. Saúde mental na atenção básica: atuação do enfermeiro na rede de atenção psicossocial. *Rev Bras Enferm*. 2020;73(supl. 1):1-7.
5. Marcolino TQ, Fantinatti EN, Gozzi APNF. Comunidade de prática e cuidado em saúde mental: uma revisão sistemática. *Trab Educ Saude*. 2018;16(2):643-58.
6. Nóbrega MPSS, Fernandes CSNN, Zerbetto SR, Sampaio FMC, Duarte E, Chaves SCS, Moreira WC. Nurses' attitudes facing the family involvement in caring for people with mental disorder. *Rev Bras Enferm*. 2020;73(supl. 1):1-8.
7. Costa JC, Nitschke RG, Tholl AD, Henckemai-er L, Michelin SR, Silva APM. Imaginário da promoção da saúde da família: olhar do familiar no cotidiano da Atenção Primária. *Cienc Cuid Saude*. 2017;16(1):83-90.
8. PRISMA. Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-Analyses. PRISMA Flow Dia-gram [Internet]. 2021 [cited 2025 Feb. 9]. Available from: <https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram>
9. Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Baldini SC, Khalil H, Parker D. Scoping reviews. In: Aromataris E, Munn Z, editors. *Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual*. Australia: Joanna Briggs Institute; 2020.
10. Rayyan, Intelligent Systematic Review. Rayyan.ai. 2022. [cited 2022 Mar. 17]. Available from: <https://www.rayyan.ai>
11. Brasil. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. (Lei dos Direitos Autorais). *Diário Oficial da União*. 1998 Feb. 20; 36-E(seção 1):3.
12. Militão L de F, Santos LI, Cordeiro GFT, Sousa KHJF, Peres MA de A, Peters AA. Usuários de substâncias psicoativas: desafios à assistência de enfermagem na Estratégia Saúde da Família. *Esc Anna Nery*. 2022;26:e20210429.
13. Cardoso LCB, Marcon SS, Rodrigues TFC da S, Paiano M, Peruzzo HE, Giacon-Arruda BCC, Pinho LB de. Mental health assistance in Primary Care: the perspective of professionals from the Family Health Strategy. *Rev Bras Enferm*. 2022;75(Suppl. 3):e20190326.
14. Coelho NA, Nascimento J, Barreto BI, Rezende LC, Penna CMM, Brito MJM. A percepção dos profissionais sobre as ações de saúde mental na rede de atenção psicossocial em Belo Horizonte. *REME - Rev Min Enferm*. 2021;25:e-1416.
15. Almeida DR, Soares JNC, Dias MC, Rocha FC, Andrade GRN, Andrade DLB. Care for carriers of mental disorder in primary care: an interdisciplinary and multiprofessional practice. *Rev Fun Care Online*. 2020;12:420-5.

Revisão de Escopo

Silva FM, Nasi C, Fiorini AL
Ações de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde: Revisão de Escopo

16. Silva Filho AD, Marques APBF, Silva CL, Nóbrega JN, Pinto GA. Práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas por enfermeiros na Estratégia Saúde da Família. *Rev Nursing*. 2020;23(262):3638-42.
17. Silva SM da, Silva AM da, Souza AR de, Moura ADA, Lima GG de, Feitoza AR. Estratégia saúde da família: ações no campo da saúde mental *Rev Enferm UERJ*. 2017;25:e16926.
18. Souza J de, Almeida LY de, Luis MAV, Nieves AF, Veloso TMC, Barbosa SP, Giacon BCC, et al. Mental health in the Family Health Strategy as perceived by health professionals. *Rev Bras Enferm*. 2017;70(5):935-41.
19. Silva APM da, Coelho BP, Souza LPS e, Silva KMA e, Silva EP da, Pinto IS, Oliveira RM de, et al. Saúde mental no trabalho do Enfermeiro da Atenção Primária de um município no Brasil. *Rev. Cubana Enfermer*. 2015;31(1):70-83.
20. Bobbili SJ, Carrara BS, Fernandes RHH, Ventura CAA. Uma análise situacional dos centros de atenção primária à saúde no Brasil: desafios e oportunidades para abordar o estigma relacionado à doença mental e ao uso de substâncias. *Prim Health Care Res Dev*. 2022;23:e37:1-9.
21. Hsiao CY, Lu HL, Tsai YF. Factors Associated With Primary Family Caregivers' Perceptions on Quality of Family-Centered Care in Mental Health Practice. *J Nurs Scholarsh*. 2019;51(6):680-8.
22. Barros S, Nóbrega MPSS, Santos JC, Fonseca LM, Floriano LSM. Mental health in primary health care: health-disease according to health professionals. *Rev Bras Enferm*. 2019;72(6):1609-17.
23. Pereira RMP, Amorim FF, Gondim MFN. A percepção e a prática dos profissionais da Atenção Primária à Saúde sobre a Saúde Mental. *Interface*. 2020;24(supl. 1):e190664.
24. Martins ÁKL, Souza ÂMA e, Vieira NFC, Pinheiro PN da C, Braga VAB. Práticas em saúde mental na estratégia de saúde da família: um estudo exploratório. *J. res.: fundam. care*. 2015;7(1):1905-14.
25. Nascimento MGG, Nadeleti NP, Nadeleti SC, Vilela S de C, Terra F de S, Silva SA da, Resck ZMR. O processo de trabalho do enfermeiro na promoção da saúde mental da população atendida na ESF: uma análise reflexiva. *Rev. enferm. Cent.-Oeste Min*. 2017;7:1-7.
26. Sterling RAM, Gonçalves LF, Haas P. Atenção à saúde mental na atenção primária de saúde: uma revisão sistemática. *Res Soc Dev*. 2021;10(3):e43210313394.
27. Drescher A, Both JE, Hildebrandt LM, Leite MT; Piovesan SMS. Concepções e intervenções em saúde mental na ótica de profissionais da estratégia saúde da família. *Rev Enferm UFPE*. 2016;10(4):3548-59.
28. Rotoli A, Silva MRS da, Santos AM dos, Oliveira AMN de, Gomes GC. Mental health in Primary Care: challenges for the resoluteness of actions. *Esc Anna Nery*. 2019;23(2):e20180303.
29. Amarante P, Nunes MO. A reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2018;23(6):2037-74.
30. Berlinck MT, Magtaz AC, Teixeira M. A Reforma Psiquiátrica Brasileira: perspectivas e problemas. *Rev. latinoam. psicopatol. fundam*. 2008;11(1):21-7.
31. Ministério da Saúde (Brasil). Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Aprova a Política Nacional de Saúde Mental, incluindo os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e dá outras providências. *Diário Oficial da União*. 2011 Dec. 30;251(seção 1):59

ANEXO 3 – TERMO DE CIÊNCIA



Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Secretaria Municipal de Saúde
Comitê de Ética em Pesquisa

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO
ONDE SERÁ REALIZADA A PESQUISA

Eu Barbara Cristina de Aguiar Reis, matrícula 43747.8/03

Coordenador do/a () Coordenadoria da Rede de Atenção Primária em Saúde e
Serviços Especializados Ambulatoriais e Substitutivos (CGAPSES)

() Coordenadoria da Rede de Urgências e Emergências

() Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde (CGVS)

() Coordenadoria de Regulação de Serviços em Saúde (GRSS)

() Comissão Multiprofissional de Ensino-Serviço e Pesquisa
(COMESP) do Hospital de Pronto Socorro

() Assessoria de Planejamento (ASSEPLA)

(x) Outra área/secretaria: Gerência Norte Eixo Baltazar

conheço o Protocolo de Pesquisa intitulado "AÇÕES DE ENFERMAGEM VOLTADAS
PARA A SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA", tendo como Pesquisador
Responsável: Cíntia Nasi

Declaro estar ciente do projeto e autorizo, após o parecer de aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, a realização desta
pesquisa.

Porto Alegre, 30/11/2021

Assinatura e carimbo

Barbara Cristina Lima
Gerente Distrital
GD NEB - SMS
Matrícula: 437478.03

Obs.: Este documento não autoriza o início da pesquisa, sendo apenas um requisito exigido pelo Comitê de
Ética da SMSPA para análise do projeto de pesquisa. Sua finalidade é atestar que a Coordenação da área
tem ciência e autoriza a realização do projeto de pesquisa, quando forem cumpridas as instâncias de avaliação
ética.

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre – CEP SMSPA
Rua Capitão Montanha, 27 - 7º andar – CEP 90.010-040
☎ 3289.5517 ✉ cep-smis@sms.prefpoa.com.br cep_sms@hotmail.com

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO – CEP SMSPA